BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Halk Sağlığı Hemşireliği Kapsamlı Çalışma Notu

FR.184 İME Beceri Listesi · FR.185 İME Değerlendirme Formu · FR.186 Saha Çalışması Değerlendirme Formu

14 bölüm: puanlama ve kanıt dosyası · profesyonel davranış · ASM ve demografi · invaziv işlemler ve aşılama · bebek-çocuk-ergen izlemi · gebe ve lohusa izlemi · erişkin-yaşlı-kronik hastalık izlemi · kanser taramaları · Omaha · hemşirelik süreci · sağlık eğitimi · okul sağlığı · toplum süreci · hızlı tekrar ve soru bankası

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Uygulama Değerlendirmelerine Kapsamlı Çalışma Notu

Bölümler ve puanlandıkları yerler
Nasıl çalışmalısın? (Önerilen 7 günlük plan)
Önemli uyarı
Temel kaynaklar

01 – Değerlendirme Formları ve Puanlama Mantığı

1. Formların genel resmi
2. FR.184 – İME Beceri Listesi (10 beceri)
3. FR.185 – İME Değerlendirme Formu (100 puan, 3 değerlendirme)
4. FR.186 – Saha Çalışması Değerlendirme Formu (100 puan)
5. Kanıt dosyası (portfolyo) – puanı güvenceye almanın yolu
6. Puan kaybettiren en yaygın 20 hata
7. Değerlendirmede sözlü soru gelirse – genel cevap iskeleti

02 – Profesyonel Davranış, Mesleki İletişim ve Etik

1. Formdaki 10 madde ve değerlendirenin gözü
2. Terapötik (etkili) iletişim
3. Etik ilkeler ve hasta hakları
4. Öğrenci olarak sınırların
5. Kontrol listesi – her sabah

03 – ASM, Birinci Basamak Hizmetler ve Hizmet Verilen Toplumun Demografik Özellikleri

1. Temel kavramlar
2. ASM'nin verdiği hizmetler (sayabilmen gereken liste)
3. Aile Sağlığı Elemanının (hemşire/ebe) görevleri
4. Hizmet verilen toplumun demografik özellikleri
5. Sağlık göstergeleri ve formüller
6. ASM fiziki yapısı ve birimler (gözlemleyip anlatabilmen için)
7. Kendini test et

04 – Birinci Basamakta İnvaziv İşlemler ve Aşılama

1. Her invaziv işlemin ortak iskeleti (ezberle)
2. Enjeksiyon yolları – karşılaştırmalı tablo
3. Kan alma ve diğer örnekler
4. Aşılama
5. "Değerlendirebilme" kısmı – işlem sonrası değerlendirme örnekleri
6. Kendini test et

05 – Yenidoğan, Bebek, Çocuk ve Ergen İzlemi

1. İzlem takvimi
2. Her izlemde izlenecek basamaklar (izlem iskeleti)
3. Yenidoğan değerlendirmesi
4. Büyüme
5. Gelişim – kilometre taşları
6. Beslenme
7. Güvenlik ve sağlığı koruma eğitimleri
8. Bebekte tehlike belirtileri (aileye her izlemde öğret)
9. Çocuk ve okul çağı izleminde öne çıkanlar
10. Ergen izlemi
11. Örnek: "4 aylık bebek izlemini anlat" sorusuna model cevap
12. Kendini test et

06 – Gebe ve Lohusa (Doğum Sonu) İzlemi

BÖLÜM A – GEBE İZLEMİ
1. İzlem takvimi – riskli olmayan gebede **en az 4 izlem**
2. Gebe izleminin basamakları
3. Hesaplamalar
4. Fizik muayene detayları
5. Laboratuvar ve taramalar
6. Destek programları
7. Riskli gebelik kriterleri (sevk/yakın izlem)
8. Gebelikte tehlike belirtileri (her izlemde anlat!)
9. Gebelikte sık yakınmalar ve öneriler
10. Gebelikte sağlıklı yaşam eğitimi

BÖLÜM B – LOHUSA (DOĞUM SONU) İZLEMİ
11. Lohusalık ve izlem takvimi
12. Lohusa izleminin basamakları
13. Doğum sonu tehlike belirtileri (lohusaya öğret)
14. Emzirme sorunları ve çözümleri
15. Doğum sonu aile planlaması
16. Örnek: "28 haftalık gebe izlemini anlat" – model cevap
17. Kendini test et

07 – Erişkin, Yaşlı ve Kronik Hastalığı Olan Birey İzlemi

1. Kronik hasta izleminin genel iskeleti
2. Hipertansiyon
3. Diyabet
4. Obezite ve kardiyometabolik risk
5. KOAH ve astım
6. Yaşlı sağlığı ve yaşlı izlemi
7. Erişkine yönelik koruyucu hizmetler (özet tablo)
8. Örnek: "68 yaşında hipertansif ve diyabetik birey izlemi" – model cevap
9. Kendini test et

08 – Kanser Tarama Programları ve Eğitimleri

1. Tarama nedir, neden yapılır?
2. Ulusal kanser tarama standartları (özet tablo – ezberle)
3. Meme kanseri
4. Serviks (rahim ağzı) kanseri
5. Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri
6. Diğer kanserlerde erken tanı/farkındalık
7. Kanser tarama eğitimini planlamak (FR.185/23 ve FR.186/13 için)
8. Kendini test et

09 – OMAHA Sınıflama Sistemi

1. Omaha Sistemi nedir?
2. Bileşen 1 – Problem Sınıflama Şeması
3. Bileşen 2 – Girişim Şeması
4. Bileşen 3 – Problem Değerlendirme Ölçeği (Sonuçlar için)
5. Omaha kayıt şablonu (her eğitim/izlem için doldur)
6. Doldurulmuş örnekler
7. Sık yapılan Omaha hataları
8. Kendini test et

10 – Hemşirelik Süreci: Sağlık Öyküsü, Tanılama, Planlama, Uygulama, Değerlendirme

1. Madde madde ne bekleniyor?
2. Veri toplama ve sağlık öyküsü alma
3. Tanılama (NANDA-I)
4. Planlama
5. Uygulama
6. Değerlendirme ve yeniden planlama
7. Örnek bakım planları
8. Bakım planı şablonu
9. Kendini test et

11 – Sağlık Eğitimi: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Konu Bankası

1. Temel kavramlar
2. Öğrenme alanları ve hedef yazımı (Bloom)
3. Yetişkin ve çocuk eğitiminin ilkeleri
4. Sağlık davranışı modelleri (planlamada gerekçe olarak kullan)
5. Yöntem ve materyal seçimi
6. Eğitimin uygulanması – 3 aşama
7. Eğitimin değerlendirilmesi
8. Sağlık eğitim planı şablonu
9. Doldurulmuş örnek planlar
10. "Haftada en az 15 kişi" kuralını kanıtlamak (FR.185/23–25)
11. Konu bankası – anahtar mesajlar
12. Kendini test et

12 – Okul Sağlığı Süreci

1. Okul sağlığı ve okul sağlığı hemşiresi
2. Okul risk değerlendirmesi (FR.186/15)
3. Öğrenci sağlığına yönelik girişimler (FR.186/16)
4. Okul çalışanlarına yönelik girişimler (FR.186/17)
5. Eğitimin uygulanması – veli ve çalışanlarla iletişim (FR.186/18)
6. Okulda Omaha kullanımı (FR.186/19)
7. Okul sağlığı süreci raporu – iskelet
8. Kendini test et

13 – Toplum Süreci: Kurum ve Kuruluşlarda Risk Belirleme, Planlama ve Girişim

1. Hangi kurumlar olabilir?
2. Temel kavramlar (sözlü sınavda sorulabilir)
3. Toplum değerlendirme modelleri
4. Toplum süreci – adım adım
5. Kurum türlerine göre olası riskler ve girişimler (hazır liste)
6. Toplum süreci raporu – iskelet
7. Kendini test et

14 – Hızlı Tekrar, Ezber Kartları ve Soru Bankası

1. Rakamlar – tek sayfada ezber kartı
2. Formüller
3. Çerçeveler (kısaltmalar)
4. Soru bankası (kısa cevaplı)
5. Vaka senaryoları (sözlü sınava hazırlık)
6. Değerlendirme günü kontrol listesi

Halk Sağlığı Hemşireliği – Uygulama Değerlendirmelerine Kapsamlı Çalışma Notu

> BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü – Halk Sağlığı Hemşireliği **FR.184** İME Beceri Listesi · **FR.185** İME Değerlendirme Formu · **FR.186** Saha Çalışması Değerlendirme Formu

Bu not, üç değerlendirme formundaki **her maddeye** hazırlanabilmen için hazırlandı. Her bölüm bir konu bloğunu anlatıyor ve başında "bu konu hangi form maddesinde puanlanıyor" bilgisi var.

Bölümler ve puanlandıkları yerler

#	Bölüm	Konu	Puanlandığı yer
1	Bölüm 01	Üç formun yapısı, puan dağılımı, kanıt (fotoğraf/plan) gereklilikleri, puan kaybettiren hatalar	Hepsi
2	Bölüm 02	Forma düzeni, sorumluluk, mesleki iletişim, etik, KVKK	FR.184/2 · FR.185/1-10 · FR.186/1-10
3	Bölüm 03	Birinci basamak, ASM'nin hizmetleri, ASE görevleri, kayıtlı nüfus analizi, sağlık göstergeleri ve formülleri	FR.184/1
4	Bölüm 04	Enjeksiyonlar, kan alma, topuk kanı, glukometre, aşı takvimi, soğuk zincir, ASİE, anafilaksi	FR.184/3 · FR.185/21 · FR.186/11
5	Bölüm 05	İzlem takvimi, büyüme-gelişme, taramalar, D vitamini/demir, beslenme, kaza önleme, ergen görüşmesi	FR.184/4-5 · FR.185/22 · FR.186/11
6	Bölüm 06	Gebe izlem basamakları, risk, laboratuvar, destekler, tehlike belirtileri, lohusa izlemi, emzirme, AP	FR.184/6 · FR.185/22 · FR.186/11
7	Bölüm 07	HT, DM, KOAH, obezite, KVH riski, yaşlı değerlendirme ölçekleri, düşme, polifarmasi	FR.184/7 · FR.185/21
8	Bölüm 08	Ulusal tarama programları, KKMM, HPV-smear, GGK testi, eğitim içerikleri	FR.184/10 · FR.185/23 · FR.186/13
9	Bölüm 09	Problem sınıflama (42 problem), girişim şeması, problem değerlendirme ölçeği, doldurulmuş örnekler	FR.184/9 · FR.186/14, 19
10	Bölüm 10	Veri toplama, NANDA tanısı (PES), amaç–sonuç kriteri, girişim, değerlendirme, örnek bakım planları	FR.184/8 · FR.185/11-20
11	Bölüm 11	Eğitim planı şablonu, hedef yazımı, modeller, materyal, "haftada 15 kişi" lojistiği, konu bankası	FR.184/8 · FR.185/23-25 · FR.186/12-13, 18
12	Bölüm 12	Okul risk değerlendirmesi, öğrenci taramaları, kronik hastalıklı öğrenci, okul çalışanları, veli eğitimi	FR.186/15-19
13	Bölüm 13	Kurum/kuruluşlarda risk belirleme, toplum tanılama modelleri, toplum tanısı, planlama ve değerlendirme	FR.186/20
14	Bölüm 14	Ezber kartları, rakamlar, formüller, sözlü sınav soruları ve vaka senaryoları	Hepsi

---

Nasıl çalışmalısın? (Önerilen 7 günlük plan)

Gün	Çalış	Kendini test et
1	01 + 02 + 03	Kendi ASM'nin nüfus tablosunu doldur (03'teki şablon)
2	04	Aşı takvimini kağıda ezberden yaz; IM/SC/ID açılarını say
3	05	9 bebek izlemini ve her birinde yapılanları ezberden say
4	06 + 07	Gebe 4 izlem + lohusa izlemleri; KB ölçüm basamakları
5	08 + 11	Bir KKMM eğitim planını baştan sona kendin yaz
6	09 + 10	Bir vakaya hem NANDA hem Omaha ile plan yaz
7	12 + 13 + 14	Soru bankasını sesli cevapla; eksik kalan yere dön

Altın kural: Formlarda neredeyse her madde ya "**yapabilme**" ya da "**açıklayabilme**" ister. Her konuyu hem *nasıl yapılır* (basamak basamak) hem *neden yapılır* (gerekçe) düzeyinde çalış. Değerlendiren kişi çoğunlukla "Bunu neden yaptın?", "Sonraki izlem ne zaman?", "Bu bulguda ne yaparsın?" diye sorar.

Önemli uyarı

- Bu notlar ders kitapları ve Sağlık Bakanlığı rehberlerine (Doğum Öncesi/Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberleri, Bebek-Çocuk-Ergen İzlem Protokolleri, Genişletilmiş Bağışıklama Programı, Ulusal Kanser Tarama Standartları) dayanarak hazırlandı.
- Rehberler zaman zaman güncellenir (ör. 2025'te beşli karma aşı yerine **altılı karma aşıya** geçildi). Uygulama alanındaki **güncel kurum talimatı ve rehber hemşirenin yönlendirmesi her zaman önceliklidir.** Not ile kurum uygulaması çelişirse sor, kayda geçir.
- İlaç dozları ve tıbbi kararlar hekim istemi/protokol gerektirir; öğrenci olarak her uygulamayı **rehber hemşire gözetiminde** yaparsın.

Temel kaynaklar

Resmi rehberler (asıl başvuru kaynakların):

- T.C. Sağlık Bakanlığı HSGM – *Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri* (2018)
- T.C. Sağlık Bakanlığı – *Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi* ve *Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi* (2014/2018)
- T.C. Sağlık Bakanlığı – *Genişletilmiş Bağışıklama Programı / Ulusal Aşı Takvimi* (asi.saglik.gov.tr)
- T.C. Sağlık Bakanlığı – *Ulusal Kanser Tarama Standartları* (kanser.gov.tr)
- Martin KS. *The Omaha System: A Key to Practice, Documentation, and Information Management*
- NANDA International – *Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflama* (kullandığın baskı)
- Anderson ET, McFarlane J. *Community as Partner* (Toplum Ortaklığı Modeli)

Bu notta bazı güncel bilgileri doğrulamak için bakılan sayfalar:

- Altılı karma aşıya geçiş (14 Nisan 2025): ANKAHED – 6'lı Karma Aşı Hakkında, Türkiye Güncel Aşı Takvimi 2025
- HPV aşısının ulusal programdaki durumu: 24 Saat Gazetesi, Diken
- Bebek izlem zamanları: Bartın Avara ASM – Bebek Sağlığı İzlemleri, Habertürk – 6 yaşına kadar 16 izlem
- Gebe izlem haftaları: OMÜ – Doğum Öncesi Bakım ve İzlem, Türkiye Klinikleri – Doğum Öncesi Değerlendirme
- Kanser tarama yaşları: Bianet – TTB kanser taramaları görüşü, CNN Türk – Kanser taramaları

01 – Değerlendirme Formları ve Puanlama Mantığı

Bu dosya, seni değerlendirecek üç formu **madde madde** açar: neyi ölçüyor, değerlendiren ne görmek istiyor, puanı nasıl alırsın, nasıl kaybedersin.

1. Formların genel resmi

Form	Adı	Nerede kullanılır	Toplam	Yapı
FR.184	İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) Halk Sağlığı Hemşireliği **Beceri Listesi**	İME (son sınıf/intörnlük) – ASM	10 beceri × 10 puan	Her beceri x / 1–10 arası derecelendirilir
FR.185	İME **Değerlendirme Formu**	İME – ASM	100	Profesyonel davranış 20 + Hemşirelik süreci 40 + Uygulama alanı/bakım becerileri 40; **I-II-III** olmak üzere 3 kez değerlendirme
FR.186	Halk Sağlığı Hemşireliği **Saha Çalışması Değerlendirme Formu**	Saha çalışması dersi – ASM + Okul + Toplum (kurum)	100	Profesyonel 20 + ASM 34 + Okul 26 + Toplum 20

> Her iki 100 puanlık formda (FR.185, FR.186) yönerge aynıdır: "Değerlendirme öğrencinin **bilgi, beceri ve mesleki tutumunu** çok boyutlu ölçer; her alt ölçüte puan verilir, toplamı 100 üzerinden nihai başarı puanıdır."

2. FR.184 – İME Beceri Listesi (10 beceri)

2.1 Derecelendirme ölçeği

Kod	Düzey	Anlamı (pratikte)
x	Gözlemlenemedi	Uygulama fırsatı olmadı. Bunu önlemek için her beceriyi en az 1 kez **görünür biçimde** yapmaya çalış.
1–3	Beklentinin altında	Basamakları bilmiyor, güvenli değil, yardım olmadan yapamıyor
4–5	Sınırda	Yapıyor ama eksik/sırasız; gerekçeyi açıklayamıyor
6–8	Beklenti düzeyinde	Basamakları doğru, güvenli; gerekçeyi açıklayabiliyor
9–10	Yeterli/Üst düzeyde	Bağımsıza yakın, bireye özgü uyarlıyor, eğitimi ve kaydı eksiksiz

9–10 almak için formül: Doğru basamak + gerekçe + bireye özgü uyarlama + iletişim + kayıt + "sonraki adım"ı (sonraki izlem, sevk, eğitim) söyleyebilme.

2.2 Beceriler ve nerede çalışacağın

#	Beceri (formdaki ifade özetle)	Değerlendiren ne bekler?	Bölüm
1	Kurumun hizmet verdiği toplumun **demografik özelliklerini açıklama** (gebe, bebek, çocuk, ergen, yaşlı, kronik hastalıklı sayısı vb.); **ASM'nin verdiği hizmetleri sayma/açıklama**	Kayıtlı nüfus, yaş-cinsiyet dağılımı, hedef grupların sayıları; ASM hizmet listesi	03
2	**Profesyonel tutum ve davranış** (duruş, beden dili, kılık-kıyafet), öğretim elemanı/arkadaş/çalışan/başvuranlarla **etkili iletişim**	Forma, dakiklik, kendini tanıtma, terapötik iletişim	02
3	Birinci basamakta yapılan **invaziv işlemleri** yapabilme; girişimlerin etkisini ve beklenen sonuca ulaşmayı **değerlendirebilme**	IM/SC/ID enjeksiyon, aşı, kan alma, topuk kanı, glukometre, pansuman + işlem sonrası değerlendirme	04
4	SB izlem kriterlerine göre **yenidoğan/bebek izlemi** (izlem basamaklarını eksiksiz)	9 bebek izlemi, ölçümler, gelişim, taramalar, aşı, D vit/demir, eğitim	05

#	Beceri (formdaki ifade özetle)	Değerlendiren ne bekler?	Bölüm
5	SB izlem kriterlerine göre **çocuk-ergen izlemi**	Büyüme-persentil, gelişim, görme-işitme, KB, diş, ergen görüşmesi	05
6	SB izlem kriterlerine göre **gebe/lohusa izlemi**	4 gebe izlemi, lohusa izlemleri, tehlike belirtileri	06
7	SB izlem kriterlerine göre **yaşlı/erişkin/kronik hastalıklı** birey izlemi	HT, DM, KOAH, obezite; yaşlı ölçekleri, düşme riski	07
8	Bireyden **yeterli sağlık öyküsü** alma ve **bireye özgü sağlık eğitimi planlama**	Sistematik öykü + eğitim planı	10, 11
9	Sağlık eğitimleri ve ASM uygulamalarında **OMAHA** sınıflama sistemini kullanma	Problem – girişim – değerlendirme (Bilgi/Davranış/Durum)	09
10	Kanser tarama programları için gerekli işlemler (**GGT** = gaitada gizli kan testi, **KKMM**, **HPV-SMEAR**) yapabilme/uygulayabilme/anlatabilme	Kit verme, numune talimatı, KKMM gösterip yaptırma, smear hazırlığı	08

3. FR.185 – İME Değerlendirme Formu (100 puan, 3 değerlendirme)

3.1 Puan dağılımı

Bölüm	Madde	Puan
A. Profesyonel Davranışlar	1–10 (her biri 2 puan)	**20**
B. Hemşirelik Sürecine Göre Değerlendirme		**40**
– Veri toplama ve tanılama	11 Bütüncül-sistematik veri toplama (4) · 12 Öncelikli, yeterli sayıda uygun tanı (4) · 13 Etiyoloji/ilişkili faktörler (4) · 14 Tanımlayıcı özellikler (4)	16
– Planlama	15 Amaç (4) · 16 Sonuç kriterleri (4) · 17 Bireye özgü girişimler (4)	12
– Uygulama	18 Girişimleri öncelik sırasına göre uygulama (4)	4
– Değerlendirme	19 Sonuç kriterlerine göre değerlendirme (4) · 20 Sonuca göre yeniden planlama (4)	8
C. Uygulama Alanında Öğrenci Değerlendirmesi ve Bakım Becerileri		**40**
	21 ASM'de hemşirelik girişimlerini doğru ve etkin yapma (aşı, kan alma, enjeksiyon, gebe/çocuk/yaşlı/kronik hasta izlemi) – **fotoğrafla kanıt**	8
	22 SB kriterlerine göre bebek, çocuk ve gebe izlemi (aşılar, ince/kaba motor gelişim, fiziksel gelişim, **bir sonraki ziyaretin planlanması**) – **fotoğrafla kanıt**	8
	23 ASM'de **kanser tarama** eğitimi – sağlık eğitim planı + en az **1 materyal**; **her öğrenci her hafta en az 15 kişi**; fotoğraflarla kanıt	8
	24 **Çocuk ve ergenlere** ihtiyaç duyulan konuda eğitim – eğitim planı + **en fazla 2 sayfalık içerik** + materyal; **haftada en az 15 kişi**; fotoğraf	8
	25 **Yetişkinlere** ihtiyaç duyulan konuda eğitim – eğitim planı + en fazla 2 sayfalık içerik + materyal; **haftada en az 15 kişi**; fotoğraf	8
Toplam		**100**

3.2 Bu formdan ne anlamalısın?

1. **Hemşirelik süreci 40 puan** → En az bir (tercihen her değerlendirme dönemi için bir) **bakım planı/vaka raporu** hazırlaman beklenir. Puan maddeleri sürecin her basamağına ayrı ayrı bölünmüş: tanıyı doğru yazıp etiyolojiyi ya da tanımlayıcı özellikleri unutursan o 4'er puanları kaybedersin. → Bölüm 10.
2. **Haftalık sayısal hedefler var:** Kanser tarama eğitimi, çocuk-ergen eğitimi ve yetişkin eğitimi için **ayrı ayrı her hafta en az 15 kişi** (yani haftada en az 45 kişiye eğitim). Bunu bir **eğitim kayıt çizelgesi** ile kanıtla (bkz. aşağıdaki şablon).

3. **"Bir sonraki ziyaretin planlanması"** ifadesi açıkça yazıyor → Her izlemin sonunda "bir sonraki izlem … tarihinde, … yapılacak" diyebilmelisin. → Bölüm 05, 06.
4. **İçerik sınırı:** Çocuk-ergen ve yetişkin eğitim içerikleri **en fazla 2 sayfa**. Uzun yazmak artı değil, kurala uymamak eksi.

3.3 I – II – III değerlendirme sütunları

Formda her madde için 3 sütun var: dönem boyunca **üç kez** (ör. dönem başı, ortası, sonu) değerlendirilirsin. Bu, **gelişimini** görmek içindir. İlk değerlendirmede aldığın geri bildirimi yazılı not al ve ikinci değerlendirmede o noktayı özellikle göster.

---

4. FR.186 – Saha Çalışması Değerlendirme Formu (100 puan)

4.1 Puan dağılımı

Bölüm	Madde	Puan
A. Profesyonel Davranışlar (20)	1–10 (her biri 2) – *Formül: (20×3÷3) → ASM + Okul + Toplum sürecinde ayrı ayrı puanlanır, üçünün ortalaması alınır*	**20**
B. Aile Sağlığı Merkezi (34)	11 SB izlem kriterlerine göre **bebek, çocuk, gebe ve lohusa izlemlerine katılmak** (aşılar, ince/kaba motor gelişim, fiziksel gelişim, sonraki ziyaretin planlanması)	10
	12 Saha çalışmasına çıkılan **her gün** gerekli görülen konuda **en az 1 eğitim** (fotoğraf + materyal; bireye özgü eğitim planı, uygulama, eğitimin değerlendirmesi)	8
	13 Saha çalışmasına çıkılan **her gün kanser tarama** konusunda **en az 1 eğitim** (fotoğraf + materyal; bireye özgü plan, uygulama, değerlendirme)	8
	14 Eğitimlerde **Omaha** sınıflama sistemini kullanma (problemin tanımı, hedef ve kategoriler, hemşirelik girişimleri, problemin değerlendirilmesi)	8
C. Okul Sağlığı Süreci (26)	15 Okulun **risk değerlendirmesini** yapmak ve buna uygun girişim planlamak	5
	16 **Öğrenci** sağlığına yönelik girişim (tarama, sağlık eğitimi, etkinlik planlama, risk belirleme, kronik hastalıklı öğrenci izlemi) – fotoğraf	6
	17 **Okul çalışanlarına** yönelik girişim (tarama, eğitim, risk belirleme, kronik hastalıklı çalışan izlemi) – fotoğraf	6
	18 Önceden hazırlanan eğitimin uygulanması (çalışan ve velilerle iletişim, zaman-süre belirleme), materyal kullanımı, eğitimin değerlendirilmesi	4
	19 Eğitimlerde **Omaha** kullanımı	5
D. Toplum Süreci (20)	20 **Valiliğe bağlı resmi kurum ve özel kuruluşlarda** sağlık sorunlarına ilişkin risk belirleme, sağlık eğitimi planlama ve girişimlerin uygulanması	20
Toplam		**100**

4.2 Bu formdan ne anlamalısın?

- **Omaha iki kez puanlanıyor** (ASM 8 + Okul 5 = 13 puan). FR.184'te de bir beceri. Omaha'yı mutlaka hatasız kullanabilmelisin. → Bölüm 09.
- **ASM'de her saha günü en az 2 eğitim** (1 genel konu + 1 kanser tarama). Her biri için *bireye özgü plan → uygulama → değerlendirme* üçlüsü istenir.
- **Okulda** risk değerlendirmesi tek başına bir puan kalemi; bir **kontrol listesi + risk matrisi** ile yaparsan hem sistematik hem kanıtlanabilir olur. → Bölüm 12.
- **Toplum süreci tek madde ama 20 puan**: Kurumda *veri toplama → risk/sorun belirleme → öncelik → eğitim planı → uygulama → değerlendirme* zincirini bir rapor halinde sun. → Bölüm 13.

5. Kanıt dosyası (portfolyo) – puanı güvenceye almanın yolu

Formlarda sık sık "**fotoğrafla kanıtlayarak**", "**eğitim planı**", "**materyal**" geçiyor. Değerlendiren kişi her şeyi göremeyebilir; **kanıt yoksa puan yok** varsay.

5.1 Haftalık kanıt dosyası içeriği

1. **Eğitim kayıt çizelgesi** (aşağıda şablon)
2. Her eğitim için **eğitim planı** (Bölüm 11'deki şablon)
3. Eğitim **içeriği** (≤2 sayfa) ve **materyal** (broşür, poster, maket fotoğrafı)
4. **Fotoğraflar** (izinli, kimliği gizlenmiş)
5. **Omaha kayıt formları** (her eğitim/izlem için)
6. İzlem notları (bebek/çocuk/gebe/lohusa/yaşlı – kimlik bilgisi olmadan)
7. Vaka raporu/bakım planı (hemşirelik süreci)
8. (Saha) Okul risk değerlendirme formu, toplum süreci raporu

5.2 Eğitim kayıt çizelgesi şablonu

Tarih	Eğitim türü (Kanser tarama / Çocuk-ergen / Yetişkin / Genel)	Konu	Kişi (baş harfler)	Yaş	Cinsiyet	Yöntem	Materyal	Değerlendirme (ön-son / geri gösterim)	Omaha formu no	Fotoğraf no
04.11	Kanser tarama	KKMM	A.Y.	42	K	Bireysel, gösterip yaptırma	Meme maketi + broşür	Geri gösterimde 7/8 basamak doğru	O-12	F-23

> Haftalık toplamı her hafta sonunda çizelgenin altına yaz: "Kanser tarama: 17 kişi, Çocuk-ergen: 15, Yetişkin: 16".

5.3 Fotoğraf ve kişisel veri (KVKK) kuralları – ÇOK ÖNEMLİ

- Fotoğraf çekmeden önce kişiden **sözlü (mümkünse yazılı) izin** al; ne için kullanılacağını açıkla.
- **Çocuklarda veli izni**, okulda ayrıca **okul idaresi izni** gerekir.
- Mümkünse **yüzü göstermeyen** açılar kullan (elin, materyalin, maketin, eğitim ortamının fotoğrafı). Yüz görünüyorsa kanıt dosyasına koymadan önce **buzla/gizle**.
- Hasta adı, TC kimlik no, adres, telefon, tahlil sonucu ekranı **asla** fotoğrafta görünmemeli. Bilgisayar ekranını (AHBS, e-Nabız) fotoğraflama.
- Fotoğrafları kişisel sosyal medyada paylaşma. Bu hem 6698 sayılı **KVKK**'ya hem de Hasta Hakları Yönetmeliği'ndeki mahremiyet ilkesine aykırıdır ve profesyonel davranış puanını doğrudan düşürür.

---

6. Puan kaybettiren en yaygın 20 hata

1. Formasız/eksik forma, yaka kartı yok, takı, uzun/ojeli tırnak.
2. Geç gelme, erken ayrılma, habersiz devamsızlık.
3. Hastaya kendini tanıtmadan işleme başlama; izin almama.
4. El hijyenini atlama (özellikle işlem öncesi ve eldiven çıkarıldıktan sonra).
5. Kimlik doğrulamadan aşı/ilaç uygulama.
6. Aşı öncesi kontrendikasyon sorgulamamak; aşı sonrası 15–30 dk gözlemi söylememek.
7. Bebek izleminde **baş çevresini** ölçmeyi, **persentile işlemeyi** unutmak.
8. İzlem sonunda **bir sonraki izlem tarihini** söyleyememek.

9. Gebe izleminde **tehlike belirtilerini** anlatmamak.
10. Hemşirelik tanısına **tıbbi tanı** yazmak ("Hipertansiyon" bir hemşirelik tanısı değildir).
11. Tanıda **etiyoloji** ya da **tanımlayıcı özellik** bölümünü boş bırakmak.
12. Ölçülemeyen sonuç kriteri yazmak ("Hasta bilgilenecek").
13. Girişimleri gerekçesiz, kalıp ve bireye özgü olmayan biçimde yazmak.
14. Değerlendirmede "amaca ulaşıldı" deyip kanıt göstermemek.
15. Eğitimde hedef kitleye uygun olmayan dil/materyal (yaşlıya küçük punto broşür, çocuğa slayt dolusu yazı).
16. Eğitim sonrası **değerlendirme yapmamak** (ön-son test/geri gösterim yok).
17. Omaha'da problem alanı ile problemi karıştırmak; Bilgi-Davranış-Durum puanlarını vermemek.
18. Haftalık "15 kişi" sayısını tutturamamak ya da kanıtlayamamak.
19. Okul risk değerlendirmesini gözlem notu düzeyinde bırakmak (matris/öncelik yok).
20. Gizlilik ihlali (fotoğraf, hasta bilgisi konuşma, ekran fotoğrafı).

---

7. Değerlendirmede sözlü soru gelirse – genel cevap iskeleti

> "Önce **kimlik** doğrulayıp kendimi tanıtırım ve **izin** alırım. **El hijyeni** sağlarım. **Öykü** alırım (…). **Ölçüm/muayene** yaparım (…). Bulguları **normal değerlerle karşılaştırırım** (…). Uygun **girişimi** yaparım (…). Bireye/aileye **eğitim** veririm (…). **Kayıt** ederim (AHBS/izlem formu). **Bir sonraki izlemi** planlarım (… tarihinde). Anormal bulgu varsa **hekime bildiririm/sevk** ederim."

Bu iskeleti hangi beceri sorulursa sorulsun içini doldurarak kullanabilirsin.

02 – Profesyonel Davranış, Mesleki İletişim ve Etik

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 2 · FR.185 madde 1–10 (20 puan) · FR.186 madde 1–10 (20 puan; ASM, okul ve toplum sürecinde ayrı ayrı puanlanıp ortalaması alınır)

> Profesyonel davranış puanı "en kolay alınan, en kolay kaybedilen" puandır. Bilgi gerektirmez, **disiplin** gerektirir. Her alanda (ASM, okul, kurum) sıfırdan değerlendirildiğini unutma.

1. Formdaki 10 madde ve değerlendirenin gözü

#	Madde	Gözlenen somut davranışlar (puan getirir)
1	Klinik/saha uygulama yönergesine uygun **forma düzeni**	Temiz-ütülü forma, yaka kartı, kapalı-temiz ayakkabı, saç toplu, tırnak kısa ve ojesiz, takı yok (en fazla düz alyans), sade makyaj, parfüm yok. Yanında: kalem, not defteri, saniyeli saat, (varsa) stetoskop, mezura, el antiseptiği
2	**Çalışma saatlerine** uyum	Mesaiden 10 dk önce hazır olma; mola sürelerine uyma; ayrılırken rehber hemşireye haber verme; devamsızlıkta önceden bilgi
3	Öğrenme ve araştırmaya **isteklilik**	Soru sorma, bilmediği konuyu not alıp ertesi gün araştırıp gelme, kaynak gösterebilme
4	Teorik bilgi eksiğini **tamamlayarak gelme**	O gün yapılacak izlemlere hazırlıklı gelme (ör. bugün aşı günü ise aşı takvimini, kontrendikasyonları bilmek)
5	Etkin rol almaya **isteklilik**	"Ben yapabilir miyim?" diye inisiyatif almak; köşede beklememek; boş zamanında bekleme salonunda eğitim yapmak
6	Uygulamanın gerektirdiği beceriye ilişkin **altyapı**	Laboratuvarda öğrenilen becerileri (enjeksiyon, KB ölçümü, el hijyeni) doğru ve güvenli yapmak
7	Uygulamaların **sorumluluğunu alma ve zamanında yapma**	Verilen görevi (ör. "saat 11'deki bebek izlemini sen yap") takip etmek, bitince geri bildirim vermek
8	**Problem çözme** becerisi	Beklenmeyen durumda (ör. aşıya gelen bebeğin ateşi var) sistemli düşünüp doğru kişiye bildirmek
9	Sorumluluk alabilme ve yerine getirme	Raporları, planları, kanıt dosyasını zamanında teslim etmek
10	**Mesleki iletişim** ilkelerine uyma (sağlık profesyonelleri, akranlar, öğretim elemanı, hasta/aile)	Saygılı hitap, kendini tanıtma, aktif dinleme, uygun ses tonu, çatışmayı profesyonel yönetmek, dedikodu/telefon kullanımı yok

2. Terapötik (etkili) iletişim

2.1 Her görüşmenin standart açılışı

1. Göz teması kur, gülümse, uygun mesafe (sosyal mesafe ~1–1,5 m; işlem sırasında yakın mesafeye geçeceğini söyle).
2. **"Merhaba, ben ... Üniversitesi hemşirelik öğrencisi .... Bugün hemşire ... Hanım ile birlikte çalışıyorum."**
3. Kişinin adını doğrula ve nasıl hitap edilmek istediğini sor.
4. Yapacağın işlemi/görüşmeyi ve süresini açıkla, **izin al**.
5. Mahremiyeti sağla (kapı, paravan, başka hastaların yanında özel soru sorma).

2.2 Kullanılacak teknikler

Teknik	Örnek
Açık uçlu soru	"Bebeğinizin beslenmesini anlatır mısınız?"

Teknik	Örnek
Aktif dinleme	Baş sallama, "hı-hı", araya girmeme
Yansıtma	"Bu durum sizi endişelendiriyor gibi görünüyor."
Yeniden ifade etme (paraphrase)	"Yani ilacı sabahları unutuyorsunuz, öyle mi?"
Açıklığa kavuşturma	"'Sık' derken günde kaç kez demek istiyorsunuz?"
Sessizlik	Duygusal anlarda konuşmaya alan bırakma
Özetleme	Görüşme sonunda ana noktaları toparlama
Öğret-geri al (teach-back)	"Evde anlatacak olsanız insülini nasıl yaparsınız, bana gösterir misiniz?"

2.3 İletişim engelleri (yapmayacakların)

Yargılamak ("Neden bu kadar geç getirdiniz?"), boş güvence ("Merak etmeyin, bir şey olmaz"), öğüt verme dili ("Siz kesinlikle şunu yapmalısınız"), konuyu değiştirmek, tıbbi jargon ("HbA1c'niz yüksek" yerine "3 aylık şeker ortalamanız yüksek"), aynı anda birden çok soru, telefonla ilgilenmek.

2.4 Özel gruplarla iletişim

Grup	Dikkat edilecekler
Çocuk	Göz hizasına in; gelişim düzeyine uygun dil; işlemi oyuncak/oyunla anlat; yalan söyleme ("acımayacak" deme, "biraz acıyabilir, hemen geçecek" de); seçenek sun ("hangi kolundan yapalım?")
Ergen	Mahremiyet: ebeveyn dışarıdayken de kısa görüşme; gizlilik sınırlarını açıkla (kendine/başkasına zarar riski, istismar durumunda gizlilik korunamaz); yargısız tutum; HEEADSSS çerçevesi (Bölüm 05)
Yaşlı	Yavaş-net konuş, bağırma; işitme cihazı/gözlük takılı mı kontrol et; yüzüne bakarak konuş; kısa cümleler; yazılı büyük puntolu materyal; "teyze/amca" yerine adıyla hitap (Ayşe Hanım)
Dil engeli / göçmen	Kurumun tercüman olanağını kullan; çocukları tercüman olarak kullanma; resimli materyal
Öfkeli birey	Sakin kal, dinle, duyguyu kabul et ("Uzun süre beklediğiniz için kızgınsınız, haklısınız"), çözüm odaklı ol, gerekirse sorumlu personele yönlendir
İşitme engelli	Yüzünü gör, dudak okumaya uygun konuş; yazılı iletişim
Görme engelli	Kendini tanıt, ne yaptığını sesli anlat, dokunmadan önce haber ver

2.5 Ekip içi iletişim – SBAR

Rehber hemşireye/hekime bir bulgu bildirirken:

- **S (Situation – Durum):** "4 aylık Ali bebeğin aşı öncesi ateşi 38,4 °C."
- **B (Background – Öykü):** "Dünden beri burun akıntısı var, beslenmesi iyi, ishal-kusma yok."
- **A (Assessment – Değerlendirme):** "Genel durumu iyi, solunum sayısı 42/dk, çekilme yok."
- **R (Recommendation – Öneri):** "Hekimin değerlendirmesini ve aşının ertelenip ertelenmeyeceğine karar vermesini öneriyorum."

---

3. Etik ilkeler ve hasta hakları

3.1 Temel etik ilkeler

İlke	Halk sağlığında örnek
Özerkliğe saygı	Aşıyı reddeden ebeveyne baskı yapmadan bilgilendirme ve kararı kayda geçirme

İlke	Halk sağlığında örnek
Yararlılık	Risk grubundaki kadını taramaya yönlendirme
Zarar vermeme	Kontrendikasyon sorgulamadan aşı yapmama
Adalet	Göçmen/yoksul bireye aynı nitelikte hizmet
Gizlilik / mahremiyet	Gebeliğini gizlemek isteyen kadının bilgisini paylaşmama
Doğruluk	Bilmediğin soruya "araştırıp/sorup döneceğim" demek
Sadakat	Verilen sözü (eğitim materyalini getirmek) tutmak

3.2 Bilmen gereken yasal çerçeve

- **6283 sayılı Hemşirelik Kanunu** ve **Hemşirelik Yönetmeliği (2011)** – Hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları; halk sağlığı hemşiresinin görevleri arasında: toplumun sağlık gereksinimlerini belirleme, koruyucu hizmetler, sağlık eğitimi, ev ziyaretleri, izlemler, aşılama, bulaşıcı hastalık kontrolüne katkı, okul ve işyeri sağlığı, kayıt-bildirim.
- **Hasta Hakları Yönetmeliği** – Bilgi alma, mahremiyet, rıza, reddetme hakkı, saygınlık.
- **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)** – Sağlık verisi "özel nitelikli kişisel veri"dir.
- **Aydınlatılmış onam** – Bilgilendirme + anlama + gönüllülük + yeterlilik. Çocukta veli/vasi; ergenin de görüşü alınır (asent).
- **Bildirim yükümlülükleri** – Çocuk istismarı/ihmali şüphesi ve kadına yönelik şiddet şüphesi durumunda yasal bildirim zorunluluğu vardır (TCK 280: sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi). Öğrenci olarak şüpheni **hemen rehber hemşire/hekime** iletirsin; kurum prosedürü işletilir. Bulaşıcı hastalık bildirimi kurum aracılığıyla yapılır.

---

4. Öğrenci olarak sınırların

- Her uygulamayı **rehber hemşire/öğretim elemanı gözetiminde** yap.
- Kendini güvende hissetmediğin bir işlemi yapma; "Bu işlemi daha önce gözetim altında yapmadım, önce izleyebilir miyim?" demek profesyonel bir davranıştır.
- Hata yaparsan (yanlış aşı, iğne batması, numune karışması) **saklama, hemen bildir.** İğne batmasında: yarayı akan su ve sabunla yıka, sıkma/emme yapma, bildir, kurum protokolü (HBV/HCV/HIV değerlendirmesi) uygulanır.
- Reçete yazamaz, hekim istemi olmadan ilaç öneremezsin; bilgi verirken "hekiminiz/hemşireniz ile görüşelim" çerçevesinde kal.

---

5. Kontrol listesi – her sabah

- ☐ Forma, yaka kartı, ayakkabı, saç, tırnak, takı
- ☐ Kalem, not defteri, saniyeli saat, mezura, el antiseptiği
- ☐ Günün planı: hangi izlemler, hangi eğitim, materyal hazır mı?
- ☐ Eğitim kayıt çizelgesi ve Omaha formları yanımda mı?
- ☐ Telefon sessizde, cebimde (fotoğraf yalnızca izinle ve kurallara uygun)
- ☐ Rehber hemşireye günaydın + "Bugün … yapmak istiyorum" planını paylaş

03 – ASM, Birinci Basamak Hizmetler ve Hizmet Verilen Toplumun Demografik Özellikleri

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 1 — "Bulunduğu kurumun hizmet verdiği toplumun demografik özelliklerini açıklayabilmesi (gebe, bebek, çocuk, ergen, yaşlı, kronik hastalıklı birey sayısı vb.), ASM'nin verdiği hizmetleri sayabilmesi/açıklayabilmesi"

> Uygulamanın **ilk haftası** bu bilgileri topla ve aşağıdaki tabloyu doldur. Değerlendiren kişi "ASM'nizin nüfusu kaç, kaç gebeniz var, en sık kronik hastalık hangisi?" diye sorduğunda ezbere cevap verebilmelisin.

---

1. Temel kavramlar

1.1 Sağlık hizmet basamakları

Basamak	Kurumlar	İşlev
Birinci basamak	Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)/İlçe Sağlık Müdürlüğü birimleri, KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Göçmen Sağlığı Merkezi, Ağız-Diş Sağlığı Merkezi, 112	Koruyucu hizmetler, sağlığı geliştirme, sık görülen hastalıkların tanı-tedavisi, sevk
İkinci basamak	Devlet hastaneleri, özel hastaneler	Yataklı tanı-tedavi
Üçüncü basamak	Eğitim-araştırma ve üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri	İleri uzmanlık gerektiren tanı-tedavi

1.2 Temel sağlık hizmetleri

- **Alma-Ata Bildirgesi (1978):** "2000 yılında herkes için sağlık" – Temel sağlık hizmetleri; toplum katılımı, sektörler arası işbirliği, uygun teknoloji, hakkaniyet.
- **Astana Bildirgesi (2018):** Temel sağlık hizmetlerinin evrensel sağlık kapsamının temeli olduğu yeniden vurgulandı.
- **Türkiye:** 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (1961) → sağlık ocakları; **Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)** → **Aile Hekimliği** (pilot Düzce 2005; tüm ülkede 2010).

1.3 Aile hekimliği sisteminin özellikleri

- Her vatandaş bir **aile hekimine kayıtlıdır** (kişi aile hekimini değiştirebilir).
- Bir aile hekimliği birimi = **1 aile hekimi + en az 1 Aile Sağlığı Elemanı (ASE)**.
- ASE olabilecek meslekler: **hemşire, ebe**, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni.
- Birden çok birim bir arada ise **Aile Sağlığı Merkezi (ASM)** olarak hizmet verir.
- Kayıtlı nüfusa yönelik **koruyucu hizmetler** (izlemler, aşı, taramalar) performans ölçütleriyle izlenir.

---

2. ASM'nin verdiği hizmetler (sayabilmen gereken liste)

Ezber için kısaltma: "KOR-TAN-İZ-TAR-EĞİT-DİĞER"

A. Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler

1. **Bağışıklama** – Genişletilmiş Bağışıklama Programı (bebek, çocuk, gebe Td, risk grupları) ve soğuk zincir yönetimi
2. **İzlemler**
   - Gebe izlemi (en az 4)

- Lohusa (doğum sonu) izlemi
- Bebek izlemi (0–1 yaş, 9 izlem)
- Çocuk izlemi (1–6 yaş) ve okul çağı/ergen izlemi
- Yaşlı izlemi ve kronik hastalık izlemi (Hastalık Yönetim Platformu – HYP)
- 15–49 yaş kadın izlemi (üreme sağlığı)

3. **Destek programları** – D vitamini ve demir profilaksisi (bebek), gebelere demir ve D vitamini desteği
4. **Taramalar**
   - Kanser taramaları: meme (KMM, mamografiye yönlendirme), serviks (HPV-DNA/smear), kolorektal (gaitada gizli kan)
   - Yenidoğan topuk kanı taramasının takibi (sonuç, tekrar örnek)
   - Kronik hastalık risk taramaları (HT, DM, obezite, KVH risk, KOAH, kronik böbrek hastalığı)
5. **Üreme sağlığı / aile planlaması** danışmanlığı ve yöntem uygulamaları (kondom, oral kontraseptif, RİA, enjektabl – merkezin olanağına göre)
6. **Sağlık eğitimi ve danışmanlık** – Emzirme, beslenme, sigara bırakma, sağlıklı yaşam, kaza önleme
7. **Bulaşıcı hastalıkların kontrolü** – Şüpheli olguların bildirimi, temaslı takibine katkı, verem hastalarında doğrudan gözetimli tedaviye (DGT) destek (bölge uygulamasına göre)

B. Tanı, tedavi ve rehabilitasyon

8. Poliklinik muayenesi, tanı, tedavi, **reçete**, kronik hastalık ilaç düzenlemesi
9. Laboratuvar numunesi alma (kan, idrar) ve sonuçların takibi; açlık kan şekeri, hemoglobin gibi hızlı testler
10. **Tedavi edici hemşirelik uygulamaları:** enjeksiyon (IM, SC, ID), pansuman, sütür alma, nebül, EKG, idrar stick
11. **Sevk** – Gerekli durumlarda ikinci/üçüncü basamağa; sevk sonrası geri bildirim takibi
12. **Acil müdahale** ve ilk yardım; 112 ile koordinasyon

C. Diğer hizmetler

13. **Ev ziyaretleri / evde bakım** – Yatağa bağımlı, yaşlı, engelli bireylerin izlemi (Evde Sağlık Hizmetleri birimiyle koordinasyon)
14. **Sağlık raporları** – Sürücü, iş/okul, spor vb. raporlar (mevzuata göre)
15. **Kayıt ve bildirim** – Doğum ve ölüm bildirimi, izlem kayıtları, e-Nabız'a veri aktarımı
16. **Gezici sağlık hizmeti** (kırsal, cezaevi, huzurevi gibi bağlı yerlere – bölgeye göre)
17. **Toplum sağlığına katkı** – Afet ve salgın dönemlerinde görevlendirme

> **Kayıt sistemleri:** Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) yazılımları, **e-Nabız**, Sağlık-Net, **Hastalık Yönetim Platformu (HYP)**. İzlemler bu sistemlere işlenir; performans buradan hesaplanır.

---

3. Aile Sağlığı Elemanının (hemşire/ebe) görevleri

1. Aile hekiminin verdiği görevleri yapmak, poliklinik hizmetlerine yardım
2. Gebe, lohusa, bebek, çocuk, ergen, yaşlı ve kronik hasta **izlemlerini** yapmak/yardım etmek
3. **Aşı** uygulamaları, aşı takibi, aşı reddi durumunda bilgilendirme, **soğuk zincirin** sürdürülmesi (ısı takip çizelgesi)
4. Tıbbi işlemler: enjeksiyon, pansuman, kan alma, EKG vb.
5. **Ev ziyaretleri** ve evde izlem
6. Sağlık eğitimi ve danışmanlık
7. **Kayıt** tutma, istatistik, bildirimler
8. Tıbbi malzeme, ilaç ve aşı stoklarının takibi; tıbbi atık yönetimi

9. Kanser taraması (smear/HPV, GGK) işlemleri ve yönlendirme
10. Kayıtlı kişilerin izlem çağrıları (telefon/SMS ile randevu hatırlatma)

---

4. Hizmet verilen toplumun demografik özellikleri

4.1 Hangi verileri toplamalısın? (doldurulacak şablon)

> Veriler: ASM'nin AHBS raporları, rehber hemşire, aile hekimi, izlem listeleri. **Kişisel veri değil, sayısal özet** topla.

Gösterge	ASM'de (sayı)	Oran (%)	Not
Toplam kayıtlı nüfus (birim/ASM)		100	Birim başına ortalama ~3000–4000 kişi
Kadın / Erkek			Cinsiyet oranı
0–1 yaş bebek			Bebek izlemi hedef nüfusu
1–4 (1–5) yaş çocuk			Çocuk izlemi
5–9 / 10–14 / 15–19 yaş			Okul çağı, ergen (10–19)
15–49 yaş kadın (doğurganlık çağı)			Üreme sağlığı, AP
Gebe			Gebe izlemi; riskli gebe sayısı ayrıca
Lohusa			Son 42 gün içinde doğum yapan
20–64 yaş erişkin			
65 yaş ve üzeri			Yaşlı nüfus oranı
85 yaş ve üzeri			"En yaşlı yaşlılar"
Hipertansiyon			En sık kronik hastalık genellikle HT'dir
Diyabet			
KOAH / astım			
Kalp-damar hastalığı			
Obezite			
Kanser tanılı			
Engelli / yatağa bağımlı			Evde sağlık
Göçmen / geçici koruma altındaki kişiler			Dil, aşı, gebe izlemi
Kanser tarama hedef nüfusu (40–69 K meme; 30–65 K serviks; 50–70 K+E kolorektal)			Bölüm 08
Aşılama hızları (bebek aşıları, KKK vb.)			

4.2 Nüfus piramidi nasıl yorumlanır?

- **Geniş tabanlı (üçgen) piramit:** Doğurganlık yüksek, genç nüfus → ana-çocuk sağlığı, aşı, AP öncelikli.
- **Arı kovanı/silindir:** Doğurganlık düşüyor, nüfus yaşlanıyor → kronik hastalık, yaşlı sağlığı öncelikli.
- **Ters piramit (tabanı dar):** Yaşlı nüfus yüksek, doğurganlık çok düşük.
- Türkiye'de doğurganlık son yıllarda belirgin düştü (TÜİK'e göre toplam doğurganlık hızı 2024'te yaklaşık **1,48**; nüfusun yenilenme düzeyi 2,1). Yaşlı nüfus oranı artıyor (%10'un üzerinde). **Güncel değerleri TÜİK'ten kontrol et.**

4.3 Bu verileri nasıl yorumlayıp sunarsın? (örnek konuşma)

> "Birimimizde 3.450 kayıtlı kişi var; %51'i kadın. 0–1 yaşta 38 bebek, 1–5 yaşta 190 çocuk izliyoruz. 15–49 yaş 870 kadın var; şu an 29 gebemiz izlemde, 4'ü riskli gebe. 65 yaş üstü nüfus %12 ile Türkiye ortalamasının üzerinde; bu nedenle kronik hastalık yükü yüksek: 410 hipertansif, 230 diyabetik kayıtlı. Bu yüzden ASM'de yaşlı ve kronik hasta izlemleri ile kolorektal ve meme kanseri taraması öncelikli hizmetlerdir. Eğitimlerimi de HT'de tuz kısıtlaması ve kanser taramaları üzerine planladım."

---

5. Sağlık göstergeleri ve formüller

> Değerlendirmede "Bebek ölüm hızı nasıl hesaplanır?" gibi sorular gelebilir. Paydaya dikkat!

Gösterge	Formül	Katsayı
Kaba doğum hızı	Yıl içindeki canlı doğum sayısı / Yıl ortası nüfus	× 1000
Genel doğurganlık hızı	Yıl içindeki canlı doğum / 15–49 yaş kadın nüfusu	× 1000
Toplam doğurganlık hızı (TDH)	Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca doğurması beklenen ortalama çocuk sayısı (yaşa özel doğurganlık hızlarının toplamı × 5 / 1000)	çocuk/kadın
Kaba ölüm hızı	Yıl içindeki ölüm / Yıl ortası nüfus	× 1000
Bebek ölüm hızı (BÖH)	Yıl içinde 1 yaş altı ölüm / Aynı yıldaki **canlı doğum**	× 1000
Neonatal ölüm hızı	0–27 günlük bebek ölümü / Canlı doğum	× 1000
Erken neonatal	0–6 gün ölüm / Canlı doğum	× 1000
Postneonatal ölüm hızı	28–364 gün ölüm / Canlı doğum	× 1000
Perinatal ölüm hızı	(Ölü doğum [≥22. hafta / ≥500 g] + İlk 7 gün ölüm) / (Ölü doğum + Canlı doğum)	× 1000
5 yaş altı ölüm hızı	0–4 yaş ölüm / Canlı doğum	× 1000
Anne ölüm oranı	Gebelik, doğum ve doğum sonrası 42 gün içinde gebelikle ilişkili nedenlerle ölen kadın / Canlı doğum	× **100.000**
Yaşa özel ölüm hızı	O yaş grubundaki ölüm / O yaş grubunun nüfusu	× 1000
Bağımlı nüfus oranı	(0–14 yaş + 65+ yaş) / 15–64 yaş	× 100
Yaşlı bağımlılık oranı	65+ / 15–64	× 100
Yaşlı nüfus oranı	65+ / Toplam nüfus	× 100
İnsidans hızı	Belli dönemde **yeni** olgu / Risk altındaki nüfus	× 1000 (vb.)
Prevalans hızı	Belli anda **tüm (eski+yeni)** olgular / Toplam nüfus	× 100 veya × 1000
Aşılama hızı	Aşılanan kişi / Hedef nüfus	× 100
İzlem kapsamı	İzlenen kişi / Hedef nüfus	× 100
Ortalama izlem sayısı	Toplam izlem / İzlenen kişi	—

Örnek hesap: ASM bölgesinde bir yılda 410 canlı doğum olmuş, 1 yaş altı 4 bebek ölmüş → BÖH = 4/410 × 1000 = **9,8 binde**.

Neden BÖH bu kadar önemli?

Bebek ölüm hızı, bir toplumun **sosyoekonomik düzeyinin ve sağlık hizmetlerinin** en duyarlı göstergelerinden biridir; anne sağlığı, beslenme, aşılama, çevre sağlığı ve sağlık hizmetine erişimin bir bileşkesidir.

6. ASM fiziki yapısı ve birimler (gözlemleyip anlatabilmen için)

- Bekleme salonu, muayene odaları, **aşı odası** (aşı buzdolabı, ısı takip çizelgesi, anafilaksi seti), müdahale/enjeksiyon odası, **gebe-bebek izlem odası** (bebek tartısı, infantometre, mezura, persentil eğrileri, Doppler), laboratuvar/numune alma, **kadın sağlığı/AP odası** (jinekolojik masa, spekulum, smear/HPV kitleri), tıbbi atık alanı, arşiv.
- Kontrol edebileceğin standartlar: el hijyeni noktaları, kesici-delici atık kutuları, tıbbi atık (kırmızı) ve evsel atık (siyah) ayrımı, acil müdahale seti, yangın tüpü, engelli erişimi.

7. Kendini test et

1. ASM'nde kaç kayıtlı kişi var; bebek, gebe, 65+ ve kronik hastalık sayıları neler?
2. ASM'nin verdiği hizmetlerden en az 12'sini say.
3. Bebek ölüm hızının paydası nedir? Anne ölüm oranının katsayısı nedir?
4. Prevalans ile insidans arasındaki fark nedir?
5. Bağımlı nüfus oranı nasıl hesaplanır? Bu oran ASM'nin hizmet önceliklerini nasıl etkiler?

04 – Birinci Basamakta İnvaziv İşlemler ve Aşılama

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 3 — "İnvaziv işlemleri gerçekleştirebilme, uygulanan girişimlerin etkilerini, beklenen sonuçlara ulaşma durumunu değerlendirebilme" · FR.185 madde 21 (aşı, kan alma, enjeksiyon – fotoğrafla kanıt) · FR.186 madde 11 (izlemlerde aşılar)

> Formdaki kritik ifade: "**etkilerini ve beklenen sonuçlara ulaşma durumunu değerlendirebilme**". Yani yalnızca iğneyi yapmak değil; **işlem sonrası değerlendirme** (yan etki gözlemi, ağrı, kanama, aşı sonrası 15–30 dk gözlem, hastaya ne zaman başvuracağını anlatma) de puanlanır.

---

1. Her invaziv işlemin ortak iskeleti (ezberle)

1. **Hazırlık:** İstemi/protokolü kontrol et (hangi ilaç/aşı, doz, yol, zaman).
2. **Kimlik doğrulama:** En az **iki tanımlayıcı** (ad-soyad + doğum tarihi / TC no). Bebekte ebeveyne sorarak.
3. **Kendini tanıt, açıkla, izin al** (aydınlatılmış onam).
4. **Öykü/kontrendikasyon sorgula:** Alerji, önceki doza reaksiyon, gebelik, kanama bozukluğu, antikoagülan, ateş.
5. **El hijyeni** (WHO 5 an) → **malzemeyi hazırla** → son kullanma tarihi, ilaç/aşı görünüşü, aşıda VVM kontrolü.
6. **Uygun pozisyon ve mahremiyet.**
7. **Asepsi:** Bölge antisepsisi (genellikle %70 alkol, merkezden dışa, **kurumasını bekle**).
8. **İşlem.**
9. **İşlem sonrası:** Kesici-deliciyi **kılıfını takmadan** kesici-delici atık kutusuna at; eldiveni çıkar, el hijyeni.
10. **Değerlendirme:** Lokal reaksiyon, ağrı, kanama, sistemik yanıt; aşıda **15–30 dk gözlem**.
11. **Eğitim:** Ne beklenir, ne zaman başvurulur, sonraki doz/izlem tarihi.
12. **Kayıt:** İşlem, ürün, seri/lot no, doz, yer, saat, yapan kişi, reaksiyon.

1.1 El hijyeninin 5 anı (WHO)

1. Hastaya temastan önce · 2) Aseptik işlemden önce · 3) Vücut sıvısıyla temas riskinden sonra · 4) Hastaya temastan sonra · 5) Hastanın çevresine temastan sonra.

- Alkol bazlı el ovalama: **20–30 sn**; su-sabunla yıkama: **40–60 sn** (gözle görülür kirlilikte su-sabun).
- **Eldiven el hijyeninin yerini tutmaz**; eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni yapılır.

1.2 İlaç uygulamanın doğruları

Doğru **hasta** · doğru **ilaç** · doğru **doz** · doğru **yol** · doğru **zaman** · doğru **kayıt** · doğru **eğitim** · ilacı **reddetme hakkı** · doğru **değerlendirme** · doğru **öykü/alerji** bilgisi.

1.3 Tıbbi atık yönetimi

Atık	Kap
Enfekte tıbbi atık (kanlı pamuk, eldiven)	**Kırmızı** tıbbi atık torbası
Kesici-delici (iğne, lanset, ampul)	**Kesici-delici atık kutusu** – ¾ dolunca kapatılır
Evsel atık	**Siyah** torba
Geri dönüştürülebilir (ambalaj, kâğıt)	**Mavi** torba/kutu

- İğneye **kılıf geri takılmaz** (gerekiyorsa tek el tekniği).

- **İğne batmasında:** Akan su ve sabunla yıka, sıkma/emme, antiseptik ovma yapma → hemen bildir → kurum protokolü (HBV, HCV, HIV risk değerlendirmesi, kayıt).

---

2. Enjeksiyon yolları – karşılaştırmalı tablo

	İntramüsküler (IM)	Subkutan (SC)	İntradermal (ID)
Açı	**90°**	**45°** (ince kişide) – **90°** (kalem iğnesi/yeterli yağ dokusu)	**10–15°** (neredeyse paralel), iğne ağzı yukarı
İğne (yaklaşık)	21–25 G; bebek uyluk 16–25 mm, erişkin deltoid ~25 mm (kiloya göre 25–38 mm)	23–25 G, 13–16 mm; insülin kalem iğnesi 4–6 mm	26–27 G, ~10 mm
Hacim	Deltoid ≤1 ml; ventrogluteal/vastus erişkinde 2–3 ml; bebek ≤0,5–1 ml	≤1 ml	0,05–0,1 ml
Örnek	Aşılar (altılı karma, KPA, Hep B, Hep A, Td), antibiyotik, B12	İnsülin, düşük molekül ağırlıklı heparin, KKK, suçiçeği	BCG, PPD (Mantoux)
Belirti	Kas içine; hızlı emilim	Yağ dokusuna; yavaş emilim	Kabarcık (papül) oluşmalı

2.1 IM enjeksiyon bölgeleri

Bölge	Yer bulma	Kimde
Ventrogluteal (en güvenli erişkin bölgesi)	Hastanın sağ kalçası için sol el: avuç **büyük trokanter** üzerine, işaret parmağı **spina iliaka anterior superior**'a, orta parmak iliak kristaya doğru açılır; işaret ile orta parmak arasındaki **V'nin ortası**	Erişkin ve çocuk; büyük sinir-damar yok
Vastus lateralis	Büyük trokanter ile diz kapağı arası **üçe bölünür**, **orta 1/3'ün anterolateral** yüzü	**Bebek ve küçük çocukta aşı için tercih edilen bölge**
Deltoid	Akromiyonun **2–3 parmak (2,5–5 cm) altı**, kasın en kalın yeri (üçgen)	Kas kitlesi yeterli çocuk (genellikle ≥3 yaş) ve erişkinde aşılar; küçük hacim
Dorsogluteal	**Siyatik sinir** ve büyük damar riski nedeniyle günümüzde önerilmez	—

IM basamakları: Bölgeyi seç → antisepsi, kurusun → cildi gerdir (Z tekniğinde yana çek) → iğneyi **hızlı ve tek hamlede 90°** sok → (aşılarda **aspirasyon önerilmez**; diğer ilaçlarda kurum protokolüne göre) → ilacı **yavaş** ver (~10 sn/ml) → 10 sn bekle → iğneyi giriş açısıyla çek → kuru pamukla bastır, **ovma** (özellikle Z tekniğinde ve aşıda) → değerlendir.

Z tekniği: Deri ve deri altını 2,5–3,5 cm yana çek, enjekte et, 10 sn bekle, iğneyi çıkar, deriyi bırak; ilacın deri altına sızmasını ve lekelenmeyi (ör. demir preparatları) önler.

2.2 Subkutan (insülin ve heparin)

- **İnsülin:** Karın (göbek çevresi ~5 cm hariç; en hızlı emilim), kolun arka-dış yüzü, uyluğun ön-dış yüzü, kalça. **Bölge içinde rotasyon** (lipohipertrofiyi önler; en az 1–2 cm aralık). Kalem iğnesinde 90°, 4 mm iğnede genellikle deri kıvrımı gerekmez; iğne **10 sn** bekletilip çıkarılır. Açılmış insülin oda ısısında (≤25–30 °C) yaklaşık **4 hafta** kullanılabilir; açılmamışlar buzdolabında (+2/+8 °C), **dondurulmaz**.
- **DMAH (ör. enoksaparin):** Karnın ön-yan yüzü, kıvrım tutulur, 90°, **aspirasyon yok, masaj yok**; kullanıma hazır enjektördeki hava kabarcığı çıkarılmaz. Morarma olabileceğini anlat.

2.3 İntradermal

- **BCG:** Üst kol, deltoid kasın insersiyo bölgesi; **<1 yaş 0,05 ml, ≥1 yaş 0,1 ml**. 3 aydan büyük bebeklere kurum protokolüne göre önce PPD yapılır.

- **Beklenen reaksiyon:** 2–3 haftada papül → püstül → küçük ülser → 2–3 ayda **skar**. Pansuman, antiseptik, krem uygulanmaz; sıkılmaz, üstü kapatılmaz; kendiliğinden iyileşir. Koltuk altında büyük, akıntılı lenf bezi → hekime.

- **PPD (Mantoux):** Ön kolun iç yüzü, 0,1 ml, kabarcık oluşmalı; **48–72 saatte endürasyon (sertlik) mm olarak** ölçülür (kızarıklık ölçülmez). Yorum yaş, BCG ve risk durumuna göre hekimce yapılır.

---

3. Kan alma ve diğer örnekler

3.1 Venöz kan alma

1. Kimlik, istem, tüpler, açlık durumu kontrolü (AKŞ için 8 saat açlık).
2. El hijyeni, eldiven.
3. Turnikeyi giriş yerinin **7–10 cm üstüne**; **1 dakikadan uzun** bırakma (hemokonsantrasyon). Yumruk sıkıp açtırma (potasyumu yükseltir).
4. Ven seçimi: **Antekübital fossa – medyan kübital ven** öncelikli; sonra sefalik, bazilik.
5. Antisepsi, kurusun; palpasyonla tekrar dokunma.
6. Veni alttan gerdir, iğne ucu yukarı, **15–30°** açıyla gir.
7. **Tüp sırası (CLSI):** Kan kültürü → **Mavi** (sitrat, koagülasyon) → **Kırmızı/Sarı** (serum, jelli) → **Yeşil** (heparin) → **Mor** (EDTA, hemogram, HbA1c) → **Gri** (florür, glukoz).
   - Ezber: "**K**ültür **M**avi **K**ırmızı **Y**eşil **M**or **G**ri" → "**Kim Ki Yer Mor Gülü**" gibi bir cümle uydur.
8. Katkılı tüpleri **5–10 kez nazikçe alt-üst** et (çalkalama → hemoliz).
9. **Turnikeyi iğneyi çıkarmadan önce aç**; kuru pamukla 2–3 dk bastır (kol düz, bükmeden).
10. Tüpleri hasta yanında etiketle.
11. Değerlendir: hematom, baş dönmesi (vazovagal senkop → yatır, bacakları kaldır).

3.2 Kapiller kan şekeri (glukometre)

- Elleri ılık suyla yıkat/ısıt, **parmak ucunun yan yüzü**, alkol kullanılırsa tamamen kurusun (alkol sonucu bozar), lanset, (kurum/cihaz önerisine göre) ilk damlayı sil, **sağma yapma** (doku sıvısı karışır), şeride damlat, sonucu kaydet.
- Normal: AKŞ 70–99 mg/dl; tokluk 2. saat <140 mg/dl. **<70 mg/dl hipoglisemi** (Bölüm 07: 15-15 kuralı).

3.3 Topuk kanı (Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı)

- **Ne taranır:** Fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, spinal müsküler atrofi (SMA) (program genişleyebilir – kurumda kontrol et).
- **Zaman:** Bebek **beslenmeye başladıktan sonra, doğumdan 48 saat sonra**, ideal olarak taburculuk öncesi/3–5. günler. Erken alınanlar, prematüreler, transfüzyon yapılanlar, sonucu şüpheli olanlar için **tekrar örnek** istenebilir — ASM bu takibi yapar.
- **Yer:** Topuğun **lateral veya medial plantar yüzü** (arka kavis ve orta bölgeden **alınmaz** → kalkaneus/osteomiyelit riski).
- **Basamaklar:** Topuğu ılık bezle 3–5 dk ısıt → alkol, **tamamen kurusun** → lanset (≤2 mm) → **ilk damlayı sil** → büyük damla oluşturup kartın **tek yüzünden** daireye değdir, daire **tek seferde** dolsun; **iki yüzden de kan geçtiğini kontrol et** → tüm daireleri doldur → kartı **yatay, oda ısısında, güneşten uzak 3–4 saat** kurut → bilgileri eksiksiz yaz → gönder.
- **Hatalar:** Sağma/sıkma, kartı topuğa bastırma, üst üste damlatma, ıslak kartı zarflama, eksik bilgi.

3.4 Diğer

- **İdrar stick:** Orta akım idrar, şeridi batırıp fazlasını kenara sıyır, süreye uy, kutudaki renk skalasıyla oku.

- **Pansuman:** Aseptik teknik, **temizden kirliye**, yarayı değerlendir (boyut, renk, akıntı, koku, ödem, ısı → enfeksiyon belirtileri). Sütür alma: istemle, bir uç kaldırılıp cilde en yakın yerden kesilir, cilt dışı kısım içeri çekilmeden çıkarılır.

---

4. Aşılama

4.1 Türkiye ulusal aşı takvimi (Genişletilmiş Bağışıklama Programı)

> **14 Nisan 2025'ten itibaren** beşli karma (DaBT-İPA-Hib) yerine **altılı karma (DaBT-İPA-Hib-HepB)** kullanılmaya başlandı; bu nedenle ayrı **1. ay Hepatit B dozu kaldırıldı**. Daha önce doğmuş çocukların kartlarında eski takvimi görebilirsin. ASM'deki güncel takvim afişini mutlaka kontrol et.

Zaman	Aşılar
Doğumda	Hepatit B (tekli)
2. ay sonu	**BCG**, **Altılı karma 1**, **KPA 1** (konjuge pnömokok)
4. ay sonu	**Altılı karma 2**, **KPA 2**
6. ay sonu	**Altılı karma 3**, **OPA 1** (ağızdan polio)
12. ay sonu	**KPA rapel**, **KKK 1** (kızamık-kızamıkçık-kabakulak), **Suçiçeği**
18. ay sonu	**Karma aşı rapeli** (kaynaklarda altılı karma olarak geçiyor; ASM'de kullanılan ürünü kontrol et), **OPA 2**, **Hepatit A 1**
24. ay sonu	**Hepatit A 2**
48. ay	**KKK 2**, **DaBT-İPA** (dörtlü) rapel
13 yaş (8. sınıf)	**Td**
Erişkin	Td: 5 doz tamamlandıktan sonra **10 yılda bir** rapel

Eski takvim (2025 öncesi doğanlar için): Hep B 0–1–6. ay; beşli karma (DaBT-İPA-Hib) 2–4–6–18. ay. Geri kalanlar aynı.

Annesi HBsAg pozitif bebek: Doğumda (ilk saatlerde) **Hepatit B aşısı + HBIG** (farklı ekstremitelere); kurum protokolüne göre ek doz (1. ay) ve sonrasında serolojik kontrol.

Özel durumlar ve risk grubu aşıları (hekim kararıyla): İnfluenza (65 yaş üstü, kronik hastalar, gebeler, sağlık çalışanları), pnömokok (65+, risk grupları), Hepatit B (riskli erişkinler), kuduz profilaksisi (riskli temas sonrası). **HPV aşısı** — ulusal programa alınacağı açıklanmıştı ancak bu notun hazırlandığı tarihte rutin takvimde yer almadığı bildiriliyor; ASM'de durumu sor.

4.2 Aşıların uygulama özellikleri

Aşı	Tip	Yol / Yer	Doz
Hepatit B	İnaktif (rekombinant)	IM – bebek uyluk anterolateral	0,5 ml (çocuk)
BCG	**Canlı**	**ID** – üst kol deltoid insersiyosu	<1 yaş 0,05 ml
Altılı karma	İnaktif + toksoid	IM – uyluk anterolateral	0,5 ml
KPA	Konjuge	IM – uyluk (büyük çocukta deltoid)	0,5 ml
OPA	**Canlı**	**Ağızdan 2 damla**	—
KKK	**Canlı**	**SC** (ürüne göre IM)	0,5 ml
Suçiçeği	**Canlı**	**SC**	0,5 ml
Hepatit A	İnaktif	IM	0,5 ml (çocuk)
DaBT-İPA	İnaktif	IM	0,5 ml

Aşı	Tip	Yol / Yer	Doz
Td	Toksoid	IM – deltoid	0,5 ml

- Aynı gün birden çok enjeksiyon: farklı ekstremiteler; aynı uyluğa yapılacaksa aralarında **en az 2,5 cm**.
- **Canlı aşılar** (KKK, suçiçeği) aynı gün yapılmadıysa aralarında **en az 4 hafta** olmalı. İnaktif aşılar için aralık kuralı yok.
- **OPA'yı kusarsa** (≈10 dk içinde) doz tekrarlanabilir.
- **Prematüre bebekler** gestasyon yaşına göre değil **kronolojik (takvim) yaşına** göre aşılanır.

4.3 Gebelikte ve doğurganlık çağında Td

Doz	Zaman
Td1	Gebeliğin **4. ayında** ya da ilk temasta (aşılanmamış gebe)
Td2	Td1'den **en az 4 hafta** sonra
Td3	Td2'den **en az 6 ay** sonra
Td4	Td3'ten **en az 1 yıl** sonra
Td5	Td4'ten **en az 1 yıl** sonra
Rapel	5 doz tamamlandıktan sonra **10 yılda bir**

- Önceden aşılanmış kadında kaldığı dozdan devam edilir (doz tekrarlanmaz). Amaç: **maternal ve neonatal tetanozun önlenmesi**.

4.4 Soğuk zincir

- Aşılar **+2 °C ile +8 °C** arasında saklanır.
- Aşı buzdolabı ısısı **günde en az 2 kez (sabah-akşam)** okunur ve **ısı takip çizelgesine** kaydedilir (dijital kayıtçı varsa kontrol edilir).
- **Donmaya hassas aşılar** (Hep B, altılı/dörtlü karma, Td, KPA, Hep A): dondurucu/soğutucu yüzeyle temas etmemeli. Donma şüphesinde **çalkalama (shake) testi** – donmuş aşıda çökelme hızlıdır; kullanılmaz.
- **Isıya hassas** aşılar (OPA, KKK, BCG, suçiçeği): ışık ve sıcaktan korunur.
- Buzdolabının **kapı rafları ve sebzeliği aşı için kullanılmaz**; alt bölüme ısıyı dengelemek için **su şişeleri** konur; dolapta yiyecek-içecek bulunmaz.
- **VVM (aşı flakon monitörü):** İç kare dış halkadan açıksa kullanılabilir; aynı ya da koyuysa kullanılmaz.
- **Açılmış çok dozlu flakon:** Sulandırılan canlı aşılar (BCG, KKK) **6 saat içinde ya da seans sonunda** atılır. Koruyuculu sıvı aşılar (ör. OPA, Td) uygun koşullarda **28 güne** kadar kullanılabilir (açılış tarihi flakona yazılır). Kurum talimatına uy.
- **Elektrik kesintisinde** buzdolabı kapağı açılmaz; ısı izlenir; uzun sürerse aşılar soğuk taşıma kabına alınır.
- **Aşı taşıma kabı:** Buz aküleri dondurucudan çıkarılıp yüzeyinde su damlacıkları oluşana kadar **koşullandırılır** (aşıların donmasını önlemek için).

4.5 Kontrendikasyonlar – gerçek ve yanlış

Gerçek kontrendikasyonlar

- Aynı aşının önceki dozundan sonra ya da aşı bileşenine **anafilaksi**.
- Boğmaca içeren aşıdan sonraki 7 gün içinde başka nedene bağlanamayan **ensefalopati** → boğmaca bileşeni verilmez.
- **Canlı aşılar: Gebelik**, **ağır bağışıklık yetmezliği** (kemoterapi, yüksek doz kortikosteroid, konjenital immün yetmezlik vb.).

Önlem (erteleme) gerektiren durumlar

- Orta-ağır **akut hastalık** (ateşli veya ateşsiz) → iyileşince aşılanır.
- Yakın zamanda **kan ürünü/immünglobulin** alımı → canlı parenteral aşılar (KKK, suçiçeği) ertelenir.

Yanlış kontrendikasyonlar (aşı ertelenmez!)

- Hafif akut hastalık (hafif ishal, hafif üst solunum yolu enfeksiyonu, düşük ateş)
- Antibiyotik kullanımı, iyileşme dönemi
- **Prematürite**, düşük doğum ağırlığı (kronolojik yaşa göre aşılanır)
- **Emzirme**; annenin gebe olması; evde gebe bulunması
- Aşı dışı alerjiler, astım, egzama
- Ailede aşı reaksiyonu ya da **ailede havale** öyküsü
- Yenidoğan sarılığı, malnütrisyon, stabil nörolojik hastalık

4.6 Aşı sonrası istenmeyen etkiler (ASİE/ASİO)

Tür	Örnek	Ne yaparsın?
Lokal	Ağrı, kızarıklık, şişlik	Soğuk uygulama, gerekirse hekim önerisiyle ağrı kesici
Sistemik hafif	Ateş, huzursuzluk, iştahsızlık	Bol sıvı, ince giydirme, ateş ölçümü; hekim önerisi
KKK sonrası	**7–12. günlerde** ateş, hafif döküntü	Bilgilendir; beklenen olabilir
BCG	Lenfadenit, büyük apse	Hekime yönlendir
Ciddi	**Anafilaksi**, febril konvülsiyon, hipotonik-hiporesponsif epizod, ensefalopati	Acil müdahale, hekime haber, **ASİE bildirimi**

- Her aşıdan sonra kişi **en az 15 dk** (anafilaksi öyküsü/risk varsa **30 dk**) ASM'de bekletilir.
- Ciddi ASİE'ler kurum aracılığıyla **ASİE bildirim formu** ile bildirilir; kayıt tutulur.

4.7 Anafilaksi yönetimi (aşı odasında)

- **Belirtiler:** Dakikalar içinde ürtiker/yaygın kızarıklık, dudak-dil şişmesi, hırıltı, stridor, solunum sıkıntısı, hipotansiyon, solukluk, bilinç kaybı.
- **Yap:** Yardım çağır/**112** → hastayı **sırtüstü yatır, bacakları kaldır** (solunum sıkıntısında yarı oturur) → **Adrenalin (1/1000, 1 mg/ml) 0,01 mg/kg IM, uyluk anterolateral** (çocukta en fazla 0,3 mg; erişkinde en fazla 0,5 mg) → yanıt yoksa **5–15 dk** sonra tekrar → hava yolu, oksijen, vital takip → ilk müdahale hekim yönetiminde.
- Aşı odasında **anafilaksi seti** (adrenalin, enjektör, airway, ambu) bulunmalı ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.

4.8 Bebek aşılamada ağrıyı azaltma

- Emzirirken ya da ebeveyn kucağında **dik pozisyonda** uygulama
- Emzirme mümkün değilse oral tatlı çözelti (kurum protokolüne göre)
- **Aspirasyonsuz, hızlı** enjeksiyon
- Birden çok enjeksiyonda **en ağrılı aşıyı en sona** bırakma
- Dikkat dağıtma (oyuncak, şarkı); büyük çocukta nefes egzersizi

4.9 Aşı sonrası ebeveyn eğitimi (söylemen gerekenler)

1. Hangi aşının yapıldığı, neye karşı koruduğu

2. Beklenen yan etkiler ve süresi; enjeksiyon yerine **soğuk** uygulama, ovmama
3. Ateşte yapılacaklar; **acil başvuru** gerektiren durumlar (yüksek ateş, havale, solunum sıkıntısı, sürekli tiz ağlama, bilinç değişikliği, yaygın döküntü)
4. **Bir sonraki aşı/izlem tarihi** ve aşı kartının saklanması

4.10 Aşı reddi

- Kaygıları **yargılamadan dinle**, yanlış bilgileri kanıtla düzelt; aşının yararını ve hastalığın risklerini anlat.
- Ret kararı devam ederse kurum prosedürüne göre **aşı ret formu** düzenlenir ve kayıt edilir.
- Sonraki her izlemde aşı yeniden önerilir; iletişim kanalı açık tutulur.

---

5. "Değerlendirebilme" kısmı – işlem sonrası değerlendirme örnekleri

İşlem	Beklenen sonuç	Değerlendirme kriteri
Aşı	Komplikasyonsuz uygulama, koruyuculuk	15–30 dk gözlemde reaksiyon yok; ebeveyn yan etkileri ve sonraki tarihi doğru anlatıyor (teach-back)
IM ilaç	İlacın beklenen etkisi	Ağrının azalması (ör. ağrı skoru 7→3), lokal komplikasyon yok
İnsülin	Kan şekeri kontrolü	Öğün öncesi 80–130 mg/dl; hipoglisemi belirtisi yok; hasta bölge rotasyonunu doğru gösteriyor
Kan alma	Uygun örnek	Hemoliz yok, doğru tüp sırası, hematom yok
Topuk kanı	Geçerli örnek	Daireler tam dolu, iki yüzde kan, kart kuru; tekrar örnek gerekmedi
Pansuman	Yara iyileşmesi	Kızarıklık-akıntı azalıyor, enfeksiyon belirtisi yok

---

6. Kendini test et

1. Vastus lateralis bölgesini nasıl bulursun? Neden bebeklerde tercih edilir?
2. Güncel aşı takviminde 2., 4., 6., 12., 18., 24., 48. ay ve 13 yaşta hangi aşılar var?
3. Bir bebeğin hafif burun akıntısı ve 37,6 °C ateşi var. Aşı yapılır mı?
4. Buzdolabı termometresi sabah +10 °C gösteriyor. Ne yaparsın?
5. Topuk kanı neden topuğun ortasından alınmaz?
6. Venöz kanda tüp sırası nedir? EDTA'lı tüp hangi renk, ne için?
7. Anafilakside adrenalin dozu ve uygulama yeri nedir?

05 – Yenidoğan, Bebek, Çocuk ve Ergen İzlemi

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 4 (yenidoğan/bebek izlemi) ve 5 (çocuk-ergen izlemi) — "İzlem basamaklarını eksiksiz ve doğru şekilde değerlendirebilme/açıklayabilme" · FR.185 madde 22 · FR.186 madde 11 ("aşılar, ince/kaba motor gelişim, fiziksel gelişim vb. değerlendirilmesi, **bir sonraki ziyaretin planlanması**")

> Dayanak: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, **Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri** (2018). İzlem gün aralıkları kaynaklara göre küçük farklılık gösterebilir; ASM'deki izlem tablosunu kontrol et.

1. İzlem takvimi

1.1 Bebek izlemleri (0–1 yaş) – en az 9 izlem

İzlem	Zaman	Nerede / Not
1	**Doğumda**	Hastanede (aile hekimi bu izlemden sorumlu değil; sonuçlarını takip eder)
2	**İlk hafta / ilk 10 gün** (yenidoğan izlemi; çoğu kaynakta 1.–10. gün aralığı)	Ev ziyareti ya da ASM; topuk kanı kontrolü, sarılık, göbek, emzirme
3	**15. gün** (2.–4. hafta)	Doğum ağırlığına dönüş kontrolü
4	**41. gün** (30.–59. gün)	Kalça USG sonucu, 2. ay aşılarına hazırlık
5	**2. ay**	BCG, altılı karma 1, KPA 1
6	**3. ay**	Baş kontrolü, sosyal gülümseme
7	**4. ay**	Altılı karma 2, KPA 2; **demir desteği başlangıcı**
8	**6. ay**	Altılı karma 3, OPA 1; **tamamlayıcı beslenmeye geçiş**
9	**9. ay**	Emekleme, tutunarak kalkma; anemi değerlendirmesi

1.2 Çocuk izlemleri (1–6 yaş) – 7 izlem (6 yaşa kadar toplam 16 izlem)

Zaman	Öne çıkanlar
12. ay	KPA rapel, KKK 1, suçiçeği; yürüme, ilk kelimeler; D vit/demir desteğinin bitişi
18. ay	Karma aşı rapeli, OPA 2, Hep A 1; bağımsız yürüme; dil gelişimi; otizm açısından gözlem
24. ay	Hep A 2; iki kelimelik cümle; diş sağlığı
30. ay	Dil, tuvalet eğitimi, davranış
36. ay (3 yaş)	**Kan basıncı ölçümüne başlama**; görme (ambliyopi/şaşılık)
48. ay (4 yaş)	KKK 2, DaBT-İPA; görme taraması; okul öncesi hazırlık
60. ay (5 yaş)	Okula hazırlık, işitme-görme, diş

1.3 Okul çağı ve ergen izlemleri

- **6–19 yaş: yılda 1 izlem.**
- 13 yaşta **Td** aşısı.
- Ergen (10–19 yaş) izlemlerinde **HEEADSSS** psikososyal görüşmesi, puberte (Tanner), ruh sağlığı, risk davranışları.

2. Her izlemde izlenecek basamaklar (izlem iskeleti)

> Değerlendiren kişi "izlem basamaklarını **eksiksiz** say" diyebilir. Bu 12 basamağı sırayla söyle:

1. **Hazırlık:** Önceki izlem kaydını incele (aşı, ölçümler, sorunlar), malzemeyi hazırla (tartı, infantometre/boy ölçer, mezura, persentil eğrisi, termometre, ışık kaynağı, oyuncak/küp – gelişim için).
2. **Karşılama, kimlik doğrulama, kendini tanıtma, izin.**
3. **El hijyeni**; ortamın ısısı (bebek soyulacak: sıcak ortam, ~24–26 °C).
4. **Öykü (anneden/bakım verenden):**
   - Son izlemden beri genel durum, hastalık, başvuru, ilaç
   - **Beslenme** (yalnız anne sütü mü, kaç kez, gece, mama, ek gıda, su)
   - **Boşaltım** (günde ıslak bez sayısı, dışkı rengi-sıklığı)
   - **Uyku** (süre, pozisyon, nerede uyuyor)
   - Ağlama, huzursuzluk, kusma
   - D vitamini ve demir kullanımı
   - Aşılardan sonra reaksiyon
   - Ailenin endişesi (**"Bebeğinizle ilgili sizi endişelendiren bir şey var mı?"**)
   - Annenin durumu (emzirme, duygu durumu – postpartum depresyon!)
   - Ev ortamı, sigara dumanı, kaza riskleri
5. **Fizik muayene (baştan aşağıya):** Genel görünüm, renk (sarılık, siyanoz, solukluk), **fontaneller**, gözler (**kırmızı refle**, akıntı, şaşılık), kulak, ağız (pamukçuk, dil bağı), boyun, göğüs, kalp sesi (hekimle), karın, **göbek**, genital bölge (inmemiş testis, hipospadias, labial yapışıklık), **kalça** (abdüksiyon kısıtlılığı, cilt kıvrımı asimetrisi, bacak boyu farkı), sırt-omurga (sakral çukur, kıl), ekstremiteler, cilt (döküntü, pişik, morluk – **istismar şüphesi**), refleksler.
6. **Büyüme ölçümleri:** Ağırlık, boy, **baş çevresi** → **persentil eğrisine işle** → önceki ölçümlerle karşılaştır.
7. **Gelişim değerlendirmesi:** Kaba motor, ince motor, dil, sosyal-duygusal (kilometre taşları tablosu) – Bakanlığın **Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR)** kullanılıyorsa onunla.
8. **Taramalar** (yaşa göre): topuk kanı sonucu, işitme taraması sonucu, kalça USG, kırmızı refle/görme, anemi, KB (≥3 yaş).
9. **Aşılar:** Takvime göre; önce kontrendikasyon sorgula; aşı sonrası gözlem.
10. **Profilaksi:** D vitamini, demir desteği (başlatma/sürdürme/bitirme).
11. **Eğitim/danışmanlık (yaşa özgü):** Beslenme, uyku güvenliği, kaza önleme, gelişimi destekleme (oyun, konuşma, kitap okuma), diş sağlığı, hijyen, tehlike belirtileri.
12. **Kayıt ve sonraki izlemin planlanması:** AHBS/izlem formuna işle, **bir sonraki izlem tarihi ve o izlemde ne yapılacağı** (ör. "15 gün sonra 2. ay aşıları") aileye söylenir/yazılır. Anormal bulgu varsa **hekime bildirim/sevk**.

---

3. Yenidoğan değerlendirmesi

3.1 Normal değerler

Parametre	Normal
Doğum ağırlığı	2500–4000 g (<2500 g düşük doğum ağırlığı; >4000 g makrozomi)
Boy	~48–53 cm
Baş çevresi	~33–35 cm (göğüs çevresinden 1–2 cm büyük)
Kalp tepe atımı	**120–160/dk**
Solunum	**30–60/dk** (≥60 takipne)

Parametre	Normal
Vücut ısısı (aksiller)	**36,5–37,5 °C**
Apgar (1. ve 5. dk)	7–10 normal; 4–6 orta depresyon; 0–3 ağır depresyon

Apgar kriterleri: Kalp hızı, solunum çabası, kas tonusu, refleks irritabilite, renk (her biri 0–2).

3.2 Fizyolojik durumlar (normal kabul edilen)

- **Fizyolojik kilo kaybı:** Doğum ağırlığının **%7–10'u**; **10–14. günde** doğum ağırlığına döner. (%10'dan fazla kayıp ya da 2. haftada dönmeme → emzirme değerlendirmesi, hekime.)
- **Fizyolojik sarılık: 2–3. günde** başlar, 7–10 günde (anne sütü sarılığında daha uzun) kaybolur.
  - **Patolojik sarılık uyarıları: İlk 24 saatte** başlayan sarılık, avuç içi-ayak tabanına yayılan, 2 haftadan uzun süren, **açık renkli (beyazımsı) dışkı-koyu idrar**, emmeme, letarji → **hemen hekime**.
- **Mekonyum:** İlk 24–48 saatte çıkar; sonra geçiş dışkısı, anne sütü alanlarda sarı-yumuşak dışkı.
- **Göbek kordonu: 5–15 günde** düşer. **Kuru göbek bakımı** (temiz ve kuru tut, bezin üst kenarını göbeğin altına katla; rutin antiseptik/alkol gerekmez – kurum uygulamasına uy). Kızarıklık, kötü koku, akıntı → enfeksiyon (omfalit) → hekime.
- Milia, mongol lekesi, eritema toksikum, yalancı menstrüasyon (kız bebek), meme şişliği (her iki cins) — zararsızdır.

3.3 Fontaneller

- **Arka fontanel: ~6–8 haftada (2 ay)** kapanır.
- **Ön fontanel: ~12–18 ayda** kapanır.
- Çökük fontanel → **dehidratasyon**; kabarık/gergin fontanel → **kafa içi basınç artışı** (menenjit vb.) — acil.

3.4 Primitif refleksler

Refleks	Nasıl	Kaybolma
Arama (rooting)	Yanağa dokununca başı o tarafa çevirir	3–4 ay
Emme	Ağza giren nesneyi emer	3–4 ay (istemli emmeye dönüşür)
Moro	Ani ses/düşme hissinde kolları açıp kapar	**4–6 ay**
Avuç içi yakalama	Avuca dokununca kavrar	3–4 ay
Ayak tabanı yakalama	Ayak tabanına dokununca parmaklar kıvrılır	9–12 ay
Asimetrik tonik boyun	Baş bir yana dönünce o taraf kol-bacak uzar ("eskrimci")	4–6 ay
Adım atma (stepping)	Dik tutup ayak yere değince adım atar	~2 ay
Babinski	Taban dış kenarı çizilince başparmak yukarı, diğerleri yelpaze	**12–24 ay**

> Refleksin **olmaması** ya da **asimetrisi** (ör. Moro'da tek kol hareket etmiyor → brakiyal pleksus yaralanması/klavikula kırığı) ve **zamanında kaybolmaması** anormaldir.

3.5 Yenidoğan taramaları

Tarama	Zaman / Nasıl	ASM'nin rolü
Topuk kanı (Fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, SMA)	Beslenme başladıktan sonra, 48. saatten sonra (taburcu öncesi/3–5. gün)	Alınıp alınmadığını, sonucunu, **tekrar örnek** gerekip gerekmediğini kontrol
İşitme taraması (OAE/ABR)	Taburculuk öncesi / ilk 1 ay	Sonucu kontrol; "kaldı" ise sevk. **1-3-6 kuralı:** 1. ayda tarama, 3. ayda tanı, 6. ayda müdahale

Tarama	Zaman / Nasıl	ASM'nin rolü
Gelişimsel kalça displazisi	Her izlemde fizik muayene (Ortolani-Barlow yenidoğanda, sonra abdüksiyon kısıtlılığı); **kalça USG ~4–6. hafta**	USG'ye yönlendirme ve sonuç takibi
Kırmızı refle (göz)	Her izlemde; ışık tutulunca iki gözde eşit kırmızı yansıma	**Beyaz refle (lökokori)** → katarakt/retinoblastom → acil sevk
Prematüre retinopatisi	Prematürelerde göz hekimi	Kontrolleri hatırlatma
Kritik konjenital kalp hastalığı (puls oksimetre)	Doğum sonrası (uygulandığı yerlerde)	Sonucu sorma

4. Büyüme

4.1 Ölçüm teknikleri

- **Ağırlık:** Kalibre edilmiş bebek tartısı, **çıplak** bebek (ya da kuru bez ile – düşülür), her zaman aynı tartı; büyük çocukta hafif giysi, ayakkabısız.
- **Boy: 2 yaş altı yatarak** (infantometre; baş sabit, dizler düz, ayak tabanı 90°, iki kişiyle); **2 yaş üstü ayakta** (stadiometre; topuk-kalça-kürek kemikleri-baş arkası duvara değiyor, Frankfurt düzlemi).
- **Baş çevresi: Esnemeyen mezura**, **kaşların hemen üstü – oksipital çıkıntının en belirgin yeri**, en geniş çevre, 2–3 ölçümün en büyüğü. Özellikle **ilk 2–3 yaşta** her izlemde.

4.2 Normal büyüme kuralları (ezber)

Parametre	Kural
Ağırlık	**4–5 ayda 2 katına**, **1 yaşta 3 katına**, ~2,5 yaşta 4 katına çıkar. İlk 3 ayda haftada ~150–200 g alım
Boy	1 yaşta doğum boyunun **1,5 katı (~75 cm)**; **4 yaşta 2 katı (~100 cm)**
Baş çevresi	İlk 3 ay **ayda ~2 cm**, 4–6 ay **ayda ~1 cm**, 6–12 ay **ayda ~0,5 cm**; 1 yaşta ~**45–47 cm**
Diş	İlk süt dişi **6–8 ay** (alt orta kesiciler); 20 süt dişi ~**2,5–3 yaşta** tamamlanır; ilk daimi diş ~**6 yaş**

4.3 Persentil eğrisi yorumu

- Ölçümü yaşa göre doğru eğriye (kız/erkek ayrı; WHO büyüme standartları ya da kurumda kullanılan eğri) işle.
- **3–97. persentil** arası genelde normal kabul edilir; **en önemlisi büyüme hızının (eğrinin) izlenmesidir.**
- **Sevk/dikkat:** <3. ya da >97. persentil; **iki ana persentil çizgisini kesen** düşüş/yükseliş; baş çevresinin hızlı artışı (hidrosefali şüphesi) ya da durması (mikrosefali).
- WHO z-skor: Yaşa göre boy < −2 SD → **bodurluk** (kronik malnütrisyon); boya göre ağırlık < −2 SD → **zayıflık/akut malnütrisyon**; > +2 SD → fazla kilo/obezite riski.
- Çocuk ve ergende BKİ persentili: **≥85 fazla kilolu, ≥95 obez**, <5 zayıf.

5. Gelişim – kilometre taşları

Yaş	Kaba motor	İnce motor	Dil	Sosyal-duygusal
1 ay	Yüzüstü başını kısa süre kaldırır	Elleri çoğunlukla yumruk	Gırtlaktan sesler	Yüze bakar
2 ay	Yüzüstü başını 45° kaldırır	Eller açılmaya başlar	**Agulama**	**Sosyal gülümseme**
3–4 ay	**Baş kontrolü** tam; kollarıyla göğsünü kaldırır	Elleri orta hatta birleştirir, nesneye uzanır (4 ay)	Sesli güler (kahkaha)	Annesini tanır

Yaş	Kaba motor	İnce motor	Dil	Sosyal-duygusal
4–6 ay	Yüzüstünden sırtüstüne (4–5 ay), sırtüstünden yüzüstüne döner (5–6 ay)	Avucuyla kavrar, ağzına götürür	Ses taklidi, ünlüler	Aynadaki görüntüye güler
6–7 ay	**Desteksiz oturur**	**Elden ele nesne aktarır**	Heceler (ba-ba)	Yabancıyı ayırt etmeye başlar
9 ay	**Emekler, tutunarak ayağa kalkar**	**Kaba kıskaç** (başparmak-diğer parmaklar)	"Ma-ma, da-da" (anlamsız)	**Yabancı kaygısı**, "ce-e" oyunu, bay-bay
12 ay	Tutunarak yürür / ilk adımlar (12–15 ay)	**İnce kıskaç** (başparmak-işaret parmağı)	**1–2 anlamlı kelime**	Basit komutu anlar, işaret eder
15 ay	Bağımsız yürür	2 küpü üst üste koyar	3–5 kelime	Taklit
18 ay	Koşmaya çalışır, desteğe tutunarak merdiven	3–4 küp kule, karalama, kaşık kullanımı	~10–20 kelime, vücut parçalarını gösterir	Paralel oyun
24 ay	Koşar, topa vurur, merdiveni tek tek çıkar	6 küp kule, sayfa çevirir	**İki kelimelik cümle**, ~50+ kelime	Taklit oyunu, "ben/benim"
3 yaş	Üç tekerlekli bisiklet, ayak değiştirerek merdiven çıkma	**Daire çizer**, 9 küp	3–4 kelimelik cümle, adını söyler, yabancılar konuşmasının çoğunu anlar	Sırasını bekler, arkadaş oyunu başlar
4 yaş	Tek ayak üstünde sıçrar	**Artı (+)** çizer, makasla keser	Hikâye anlatır, renkleri söyler	İşbirlikçi oyun
5 yaş	Ayak değiştirerek sekme, ip atlamaya başlama	**Üçgen** çizer, harf yazmaya başlar	Akıcı konuşma	Kurallı oyun

Gelişimsel "kırmızı bayraklar" (sevk)

- **Herhangi bir yaşta** önceden kazanılmış becerinin **kaybı** (gerileme)
- 2 ayda sosyal gülümseme yok; 4 ayda baş kontrolü yok
- 6 ayda nesneye uzanmıyor; 9 ayda desteksiz oturamıyor
- 12 ayda işaret etme/bay-bay yok, ismine dönmüyor; **16 ayda tek kelime yok**; **24 ayda iki kelimelik anlamlı cümle yok**
- 18 ayda yürümüyor
- Sürekli tek el kullanımı (1 yaştan önce el tercihi → hemipleji?)
- Göz teması kurmama, ortak dikkat yok → **otizm spektrum bozukluğu** şüphesi (18–24 ayda tarama araçları ile değerlendirme)

---

6. Beslenme

6.1 Anne sütü ve emzirme

- **İlk 6 ay yalnızca anne sütü** (su dahil başka bir şey verilmez); 6. aydan sonra tamamlayıcı besinlerle birlikte **2 yaş ve sonrasına kadar** emzirme.
- Doğumdan sonra **ilk 1 saat içinde** emzirmeye başlama; ten tene temas.
- **İstendiğinde (yaklaşık 8–12 kez/gün)** emzirme; gece emzirmesi süt üretimini artırır.
- **Doğru tutuş:** Bebeğin kulak-omuz-kalça hizası düz bir çizgide, karnı annenin karnına dönük, burnu meme başı hizasında, anne bebeği memeye getirir (memeyi bebeğe değil).

- **Doğru kavrama (4 bulgu): Ağız geniş açık**, **alt dudak dışa dönük**, **çene memeye değiyor**, **areolanın üst kısmı alttakinden daha fazla görünür**; yanaklar dolgun (çukurlaşma yok), yavaş-derin emme ve yutma sesi; meme başında ağrı yok.
- **Yeterli süt aldığının göstergeleri:** Günde **≥6 ıslak bez** (ilk haftadan sonra), sarı-yumuşak dışkı, emzirme sonrası rahatlama, **düzenli kilo alımı**.
- **Sağılmış süt saklama (genel öneri):** Oda ısısında ~4 saat, buzdolabında ~4 gün, derin dondurucuda ~6 ay (ideal). Mikrodalgada ısıtılmaz; çözülen süt yeniden dondurulmaz.

6.2 Tamamlayıcı beslenme (6. aydan itibaren)

- Demirden zengin besinler (et, yumurta sarısı, baklagiller), sebze-meyve püresi; kıvamı ve çeşitliliği yaşla artır.
- **Her yeni besini tek tek**, 2–3 gün arayla dene (alerji gözlemi).
- **1 yaştan önce: Bal verilmez** (botulizm), **inek sütü içecek olarak verilmez** (demir eksikliği, böbrek yükü), **tuz ve şeker eklenmez**.
- Boğulma riski: Bütün fındık-fıstık, üzüm, sert parçalar (≤4–5 yaşta dikkat).
- 1 yaştan sonra aile sofrasına katılım; meyve suyu yerine meyvenin kendisi.

6.3 D vitamini ve demir desteği (Sağlık Bakanlığı programları)

	Kime	Ne zaman	Doz
D vitamini ("D Vitamini Profilaksi Programı")	Tüm bebekler	**Doğumdan (ilk günlerden) 1 yaşın sonuna kadar** (risk varsa daha uzun)	**400 IU/gün** (genellikle **3 damla**)
Demir ("Demir Gibi Türkiye")	Term bebekler	**4. ayın başından 12. ayın sonuna kadar**	**1 mg/kg/gün** elementer demir
Demir (riskli bebek)	Prematüre/düşük doğum ağırlıklı	Daha erken ve daha yüksek dozda	Hekim önerisiyle

- Demir: Aç karnına/öğün arası, mümkünse C vitaminli besinle; **dişleri boyayabilir** (diş fırçalama/su), dışkı koyulaşabilir; **sütle birlikte verilmez**.
- **Anemi taraması:** Kurum uygulamasına göre **9–12. aylar** civarında hemoglobin/hematokrit ile.

---

7. Güvenlik ve sağlığı koruma eğitimleri

7.1 Ani bebek ölümü sendromunu önleme (her izlemde söyle)

- Bebeği **sırtüstü** yatır (yüzüstü ve yan yatırma değil)
- **Sert, düz yatak**; yatakta **yastık, yorgan, yumuşak oyuncak, yan tampon yok**
- İlk aylarda **aynı odada ama ayrı yatakta** uyusun
- Evde/araçta **sigara dumanı yok**
- **Aşırı ısıtma ve sıkı kundak yok**
- **Emzirme** koruyucudur; düzenli aşılama
- Uykuda emzik kullanımı (emzirme oturduktan sonra) koruyucu olabilir

7.2 Yaşa göre kaza önleme

Yaş	Riskler	Öneriler
0–6 ay	Düşme (alt değiştirme masası), boğulma, yanık (biberon ısıtma), sallanan bebek sendromu	Bebeği yüksek yerde yalnız bırakma; **asla sarsma** (ağlamayla baş etme yolları anlat)
6–12 ay	Yabancı cisim aspirasyonu, düşme, sıcak sıvı yanıkları	Küçük nesneleri kaldır, merdivene kapı, sıcak içecekleri yukarıda tut

Yaş	Riskler	Öneriler
1–3 yaş	**Zehirlenme** (ilaç, deterjan), boğulma (su kovası, küvet), pencere/balkondan düşme, elektrik	İlaç-temizlik malzemesini kilitli dolapta; **suyun yanında asla yalnız bırakma**; pencere kilidi; priz koruyucu
3–6 yaş	Trafik, oyun alanı, suda boğulma	Araç koltuğu, yaya güvenliği, kask
Tüm yaşlar	Araç kazası	**Yaşa ve kiloya uygun çocuk oto koltuğu** (bebeklerde arkaya bakan)

- **Zehirlenmede:** Kusturmaya çalışma, **114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** / **112**.

7.3 Ağız-diş sağlığı

- İlk diş çıkmadan önce dişeti nemli temiz bezle silinir.
- İlk dişle birlikte yumuşak fırça; **3 yaş altında pirinç tanesi**, **3–6 yaş bezelye tanesi** kadar florürlü diş macunu (kurum/diş hekimi önerisi), günde 2 kez, ebeveyn yardımıyla.
- **Biberonla uyutma yok** (biberon çürüğü); şekerli içecek kısıtlaması; ilk diş hekimi ziyareti ilk dişle/1 yaş civarında.

7.4 Ekran ve uyku

- **2 yaş altında ekran önerilmez** (görüntülü aile görüşmesi hariç); **2–5 yaş en fazla 1 saat/gün**, nitelikli içerik ve ebeveyn eşliğinde.
- Uyku düzeni, yatak odasında ekran yok.

7.5 Gelişimi destekleme önerileri

Bebekle konuşma, şarkı söyleme, **kitap okuma**, karın üstü zamanı (tummy time – uyanıkken gözetim altında), yaşa uygun oyuncaklar, birlikte oyun, olumlu disiplin.

---

8. Bebekte tehlike belirtileri (aileye her izlemde öğret)

Hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalı:

- Emememe/içememe, **her şeyi kusma**
- **Havale (konvülsiyon)**
- Uyuşukluk, uyandırmakta güçlük, bilinç değişikliği
- **Hızlı solunum** (2 ay altı ≥60/dk; 2–12 ay ≥50/dk; 1–5 yaş ≥40/dk), göğüs içe çekilmesi, inleme, morarma
- **3 ay altında ≥38 °C ateş** ya da hipotermi (<35,5 °C)
- İlk 24 saatte ya da avuç/tabana yayılan sarılık, açık renkli dışkı
- Göbekte kızarıklık-akıntı-koku
- Kanlı ishal, çökük fontanel, ağlarken gözyaşı olmaması (dehidratasyon)
- Kabarık fontanel, ense sertliği, solmayan döküntü (peteşi)

---

9. Çocuk ve okul çağı izleminde öne çıkanlar

- **Büyüme:** Boy, kilo, **BKİ persentili** (obezite!), baş çevresi (ilk 2–3 yıl).
- **Görme:** 3–5 yaşta ambliyopi ve şaşılık değerlendirmesi (kapama testi, Hirschberg ışık refle testi, yaşa uygun görme eşeli); okul çağında Snellen. Göz kırpıştırma, kitabı yakın tutma, başı eğme → sevk.
- **İşitme:** Konuşma gecikmesi, seslere tepkisizlik, sık orta kulak enfeksiyonu.
- **Kan basıncı: 3 yaşından itibaren yılda bir**; yaş-cinsiyet-boy persentiline göre değerlendirilir.
- **Diş:** Çürük, diş hekimi kontrolü.

- **Beslenme:** Kahvaltı, şekerli içecek, sebze-meyve, fast food; fiziksel aktivite (**5–17 yaş günde en az 60 dk orta-şiddetli**).
- **Psikososyal:** Okul uyumu, akran ilişkileri, zorbalık, ekran süresi, uyku.
- **İhmal ve istismar belirtileri:** Açıklanamayan/tutarsız öyküyle morarma (özellikle yürümeyen bebekte, kulak, boyun, gövde), farklı iyileşme evrelerinde yaralar, sigara yanığı, sık kaza, büyüme geriliği, hijyen eksikliği, aşırı korku/içe kapanma, yaşına uygun olmayan cinsel bilgi/davranış → **gizlice, hemen** rehber hemşire/hekime bildir (yasal bildirim zorunluluğu).

---

10. Ergen izlemi

10.1 HEEADSSS psikososyal görüşmesi

Harf	Alan	Örnek soru
H – Home	Ev	"Evde kimlerle yaşıyorsun? Ailenle aran nasıl?"
E – Education/Employment	Okul/iş	"Okulda dersler, arkadaşlar nasıl? Hiç zorbalığa uğradın mı?"
E – Eating	Beslenme	"Kilonla ilgili ne düşünüyorsun? Öğün atlıyor musun?"
A – Activities	Aktiviteler	"Boş zamanında ne yaparsın? Günde kaç saat ekran?"
D – Drugs	Madde	"Arkadaşların arasında sigara/alkol kullanan var mı? Ya sen?"
S – Sexuality	Cinsellik	"Bu konuda soru sormak istediğin bir şey var mı?" (yaşa uygun, mahremiyet içinde)
S – Suicide/Depression	Duygu durumu	"Son zamanlarda kendini sık sık üzgün ya da umutsuz hissettin mi? Kendine zarar vermeyi düşündün mü?"
S – Safety	Güvenlik	"Kendini güvende hissediyor musun? Kemer/kask kullanıyor musun? İnternette tanımadığın biriyle görüştün mü?"

> **Gizlilik:** Ergenle bir bölüm ebeveyn dışarıdayken görüşülür; "Konuştuklarımız aramızda kalır; ancak senin ya da başkasının güvenliği tehlikedeyse bunu paylaşmam gerekir" diye açıklanır.

10.2 Puberte

- **Tanner evreleri** (1–5): kızlarda meme ve pubik kıllanma, erkeklerde genital ve pubik kıllanma.
- Kızlarda ilk bulgu **meme tomurcuklanması (telarş)**, ortalama 10–11 yaş; **menarş** ortalama **12–13 yaş**. Erkeklerde ilk bulgu **testis büyümesi**, ortalama 11–12 yaş.
- **Erken puberte:** Kızlarda **8 yaşından önce**, erkeklerde **9 yaşından önce** bulgu → sevk.
- **Gecikmiş puberte:** Kızlarda **13 yaşına**, erkeklerde **14 yaşına** kadar bulgu yok → sevk.

10.3 Ergende öncelikli sağlık konuları

Akne, menstrüel sorunlar (dismenore, düzensizlik), **skolyoz** (Adams öne eğilme testi), obezite/yeme bozuklukları, demir eksikliği anemisi (özellikle kızlar), sigara-alkol-madde, ekran/dijital bağımlılık, siber zorbalık, depresyon-intihar riski, uyku sorunları, kazalar, cinsel sağlık ve istismardan korunma, **13 yaşta Td**.

---

11. Örnek: "4 aylık bebek izlemini anlat" sorusuna model cevap

> "Önce önceki kayıtları incelerim: 2. ay aşıları yapılmış mı, kilo seyri nasıl. Anneyi ve bebeği karşılar, kendimi tanıtıp izin alırım, el hijyeni sağlarım. Öyküde beslenmeyi (yalnız anne sütü mü, günde kaç kez), ıslak bez sayısını, uykuyu ve uyku pozisyonunu, D vitamini kullanımını, 2. ay aşısından sonra reaksiyon olup olmadığını, annenin endişelerini

> ve duygu durumunu sorarım. Bebeği soyup baştan aşağı muayene ederim: ön fontanel açık ve düz mü, kırmızı refle, kalça abdüksiyonu, cilt. Ağırlık, boy ve baş çevresini ölçüp persentile işlerim; doğum ağırlığının yaklaşık 2 katına yaklaşmış olması beklenir. Gelişimde baş kontrolü tam mı, elleri orta hatta birleştiriyor mu, nesneye uzanıyor mu, sesli gülüyor mu bakarım; Moro refleksi azalmaya başlamıştır. Kontrendikasyon sorgulayıp **altılı karma 2. doz ve KPA 2. dozu** yaparım; 15–30 dk gözlerim. **Demir desteğini başlatırım** (1 mg/kg/gün), D vitaminine devam. Eğitimde: 6. aya kadar yalnız anne sütü, sırtüstü uyku, dönmeye başlayacağı için yüksek yerde yalnız bırakmama, aşı sonrası bakım, demirin dişleri boyayabileceği. Kayıt ederim ve **bir sonraki izlemin 6. ayda** olduğunu, o izlemde altılı karma 3. doz ve OPA yapılacağını ve ek gıdaya başlanacağını söylerim. Anormal bulgu olursa hekime bildiririm."

---

12. Kendini test et

1. 0–1 yaşta kaç izlem var; zamanları neler?
2. Bebeğin ağırlığı kaçıncı ayda 2 katına, kaçıncı ayda 3 katına çıkar?
3. Baş çevresi nasıl ölçülür? İlk 3 ayda ayda kaç cm artar?
4. Moro refleksi ne zaman kaybolur? Asimetrik Moro neyi düşündürür?
5. 9 aylık bebekte beklenen kaba ve ince motor beceriler neler?
6. D vitamini ve demir profilaksisi ne zaman başlar, ne zaman biter, dozları nedir?
7. Ani bebek ölümü sendromunu önlemek için aileye ne söylersin?
8. Erken puberte kızlarda ve erkeklerde hangi yaş sınırıyla tanımlanır?
9. HEEADSSS'in her harfi neyi ifade eder?

06 – Gebe ve Lohusa (Doğum Sonu) İzlemi

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 6 — "SB izlem kriterleri doğrultusunda gebe/lohusa izlemi yapabilme (izlem basamaklarını eksiksiz ve doğru)" · FR.185 madde 21–22 · FR.186 madde 11

> Dayanak: T.C. Sağlık Bakanlığı **Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi** ve **Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi** (2014/2018). İzlem aralıkları kaynaklarda küçük farklılık gösterebilir; ASM'nin kullandığı izlem formunu kontrol et.

BÖLÜM A – GEBE İZLEMİ

1. İzlem takvimi – riskli olmayan gebede en az 4 izlem

İzlem	Gebelik haftası	Öne çıkan işlemler
1. izlem	**İlk 14 hafta içinde** (14. haftadan sonra ilk kez saptanan gebede, haftası ne olursa olsun "ilk izlem" sayılır)	Ayrıntılı öykü, risk değerlendirmesi, TDT hesabı, fizik muayene, ilk laboratuvar, folik asit, Td, eğitim
2. izlem	**18–24. haftalar**	Fundus, FKS, fetal hareket, KB-kilo, ayrıntılı USG, **demir desteği** başlamış mı, **24–28. hafta OGTT** planlama
3. izlem	**28–32. haftalar**	Preeklampsi belirtileri, fetal hareket sayımı, Hb kontrolü, Rh(−) ise değerlendirme, doğuma hazırlık
4. izlem	**36–38. haftalar**	Prezentasyon (Leopold), doğum belirtileri, doğum yeri planı, emzirme ve doğum sonu dönem hazırlığı, AP danışmanlığı

- **Risk varlığında ya da kadının isteğiyle izlem sayısı artırılır.**
- İlk izlemin en az ~30 dk sürmesi önerilir (ayrıntılı öykü ve danışmanlık).

2. Gebe izleminin basamakları

1. **Hazırlık:** Önceki kayıtlar, izlem formu, tansiyon aleti, tartı, mezura, Doppler/fetoskop, idrar stick, tehlike belirtileri broşürü.
2. **Karşılama, kimlik, kendini tanıtma, izin, mahremiyet.**
3. **Öykü**
   - **Kişisel:** Yaş, eğitim, meslek, sosyal güvence, eş desteği, sigara-alkol-madde, şiddet öyküsü (yalnızken sor)
   - **Obstetrik: Gravida / Parite / Abortus / Yaşayan** (ör. G3 P1 A1 Y1), önceki doğum şekilleri (sezaryen?), ölü doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi, doğum sonu kanama, doğum aralığı
   - **Bu gebelik: Son adet tarihi (SAT)**, adet düzeni, planlı mı, bulantı-kusma, kanama, ağrı, fetal hareketler
   - **Tıbbi:** Kronik hastalıklar (HT, DM, kalp, böbrek, tiroid, epilepsi), ameliyatlar, kan grubu, alerji, kullanılan ilaçlar
   - **Aile öyküsü:** Diyabet, HT, genetik hastalık, çoğul gebelik, akraba evliliği
   - **Aşı:** Td durumu
4. **Hesaplamalar:** Gebelik haftası ve **tahmini doğum tarihi (TDT)**.
5. **Fizik muayene ve ölçümler:** Boy, kilo (**BKİ**), **KB**, nabız, ödem, anemi bulguları (solukluk), meme muayenesi, (≥12 hf) **fundus yüksekliği**, **FKS**, (≥28 hf) **Leopold manevraları**, varis.
6. **Laboratuvar ve USG** (izleme göre, aşağıdaki tablo).
7. **Risk değerlendirmesi** (risk varsa hekime/ikinci basamağa sevk).
8. **Destekler:** Folik asit, demir, D vitamini.
9. **Bağışıklama:** Td (aşılık durumuna göre).

10. **Eğitim/danışmanlık:** Beslenme, sık yakınmalar, **tehlike belirtileri**, emzirme hazırlığı, doğum yeri, AP.
11. **Kayıt ve bir sonraki izlemin planlanması.**

3. Hesaplamalar

- **Naegele kuralı: TDT = SAT + 7 gün − 3 ay + 1 yıl**
  - Örnek: SAT 10.03.2026 → 17.03.2026 → −3 ay → **17.12.2026**
- **Gebelik haftası:** SAT'tan bugüne geçen gün / 7.
- Gebelik süresi ~**280 gün (40 hafta)**. <37 hf **erken doğum**; 37–42 hf **term**; >42 hf **post-term**.

4. Fizik muayene detayları

4.1 Fundus yüksekliği

Hafta	Fundus
12	Simfiz pubisin hemen üstünde palpe edilir
16	Simfiz ile göbek arasının ortası
20–22	**Göbek hizası**
36	Ksifoid çıkıntının hemen altı (en yüksek)
40	Baş angaje olunca biraz aşağı iner

- **McDonald:** 20–36. haftalar arasında simfiz-fundus mesafesi (cm) ≈ gebelik haftası (±2 cm). Haftadan **>2–3 cm küçük** → gelişme geriliği/oligohidramniyos; **büyük** → makrozomi, polihidramniyos, çoğul gebelik → hekime.

4.2 Fetal kalp sesi ve hareketler

- **FKS:** Doppler ile ~10–12. haftadan, Pinard/fetoskop ile ~18–20. haftadan duyulur; **normal 110–160/dk**.
- **İlk fetal hareket:** İlk gebelikte ~18–20. hafta, daha önce doğum yapmışlarda ~16–18. hafta.
- **28. haftadan sonra hareket sayımı:** Bebeğin aktif olduğu bir saatte sayım; **2 saatte 10 hareketten az** ya da hareketlerde belirgin azalma → **hemen başvuru**.

4.3 Leopold manevraları (≥28. hafta)

1. **1. manevra:** Fundusta hangi kısım var? (Baş: sert-yuvarlak-hareketli; makat: yumuşak-düzensiz)
2. **2. manevra:** Fetüsün sırtı hangi tarafta? (FKS'nin en iyi duyulacağı yer)
3. **3. manevra (Pawlick):** Prezente kısım ne, angaje mi?
4. **4. manevra:** Baş pelvise girmiş mi (angajman), fleksiyon durumu

4.4 Kan basıncı ve ödem

- Gebelikte **≥140/90 mmHg** hipertansiyon. **20. haftadan sonra** yeni başlayan HT + **proteinüri** (ya da organ tutulumu) → **preeklampsi**. **≥160/110** → ağır, acil.
- Yüz ve ellerde ödem, ani kilo artışı (haftada >1 kg), baş ağrısı, görme bulanıklığı, epigastrik/sağ üst kadran ağrısı → preeklampsi uyarısı.
- Ayak bileğinde akşam artan, dinlenmeyle azalan ödem çoğunlukla fizyolojiktir.

4.5 Kilo alımı (gebelik öncesi BKİ'ye göre – IOM)

Gebelik öncesi BKİ	Önerilen toplam kilo alımı
<18,5 (zayıf)	12,5–18 kg
18,5–24,9 (normal)	11,5–16 kg

Gebelik öncesi BKİ	Önerilen toplam kilo alımı
25–29,9 (fazla kilolu)	7–11,5 kg
≥30 (obez)	5–9 kg

5. Laboratuvar ve taramalar

Test	Zaman	Not
Hemoglobin/Hematokrit	İlk izlem, 3. trimester (ve gerektikçe)	Gebelikte **anemi: Hb <11 g/dl** (2. trimesterde <10,5)
Kan grubu ve Rh	İlk izlem	**Rh(−)** anne: indirekt Coombs; hekim protokolüne göre **28. hafta civarında** ve doğum sonrası (bebek Rh+ ise **72 saat içinde**) **anti-D immünglobulin**
Tam idrar tetkiki / idrarda protein	İlk izlem ve sonraki izlemler (özellikle 20. hafta sonrası)	Asemptomatik bakteriüri tedavi edilir (piyelonefrit ve erken doğum riski); proteinüri → preeklampsi
Açlık kan şekeri	İlk izlem	Pregestasyonel diyabeti saptamak için
75 g OGTT	**24–28. haftalar**	Gestasyonel diyabet: açlık **≥92**, 1. saat **≥180**, 2. saat **≥153** mg/dl değerlerinden biri (tek basamaklı test; bazı merkezler iki basamaklı 50 g yükleme kullanır)
HBsAg ve diğer enfeksiyon testleri	Kurum protokolüne göre	Bebeğe HBIG gereksinimi açısından önemli
USG	İlk trimester (gebelik haftası, kalp atımı), **18–22. hf ayrıntılı USG**	
Kromozomal tarama (isteğe bağlı)	İkili test **11–14. hf**; üçlü/dörtlü test **15–20. hf**	Danışmanlık verilerek

6. Destek programları

Destek	Ne zaman	Doz
Folik asit	Gebelik planlanıyorsa en az 1 ay (tercihen 3 ay) önceden, **ilk 12 hafta boyunca**	**400 mikrogram/gün** (nöral tüp defekti öyküsünde hekim daha yüksek doz önerir)
Demir (Gebelere Demir Destek Programı)	**Gebeliğin 4. ayından (16. hafta)** itibaren gebelik boyunca ve **doğum sonrası 3. ayın sonuna kadar**	40–60 mg elementer demir/gün (anemi varsa tedavi dozu – hekim)
D vitamini (Gebelere D Vitamini Destek Programı)	**12. haftadan sonra** başlanıp **doğum sonrası 6. ayın sonuna kadar**	**1200 IU/gün**

Demir eğitimi: Aç karnına ya da öğün arasında; **portakal suyu gibi C vitamini kaynağıyla**; **çay, kahve, süt ve kalsiyumla birlikte alma** (en az 1–2 saat ara); dışkı siyahlaşabilir (normal); kabızlık yapabilir (lif ve sıvı).

7. Riskli gebelik kriterleri (sevk/yakın izlem)

- Yaş **<18 ya da >35**
- Çok doğum yapmış olmak (grand multipar), **iki gebelik arası <2 yıl**
- Önceki gebelikte: ölü doğum, tekrarlayan düşük, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, **preeklampsi**, doğum sonu kanama, **sezaryen**, konjenital anomali
- **Kronik hastalık:** HT, DM, kalp, böbrek, tiroid, epilepsi, astım, psikiyatrik hastalık
- Bu gebelikte: **kanama**, **çoğul gebelik**, anormal geliş, **Rh uyuşmazlığı**, **anemi (Hb <11)**, gestasyonel diyabet, HT/preeklampsi, fetal gelişme geriliği, amniyon sıvısı anomalisi, enfeksiyon
- BKİ **<18,5 ya da ≥30**, boy <145 cm

- Sigara-alkol-madde, şiddete maruziyet, sosyal destek yokluğu, yoksulluk, göçmen/dil engeli

8. Gebelikte tehlike belirtileri (her izlemde anlat!)

Bu belirtilerden biri varsa hemen hastaneye başvurulmalı:

1. **Vajinal kanama**
2. **Şiddetli baş ağrısı**, **bulanık görme**, gözlerde kararma
3. **Mide üstü (epigastrik) ağrı**
4. **Yüzde, ellerde ani şişme**
5. **Havale (konvülsiyon)**, bilinç kaybı
6. **Ateş** (≥38 °C), titreme
7. **Bebek hareketlerinin azalması/durması**
8. **Su gelmesi** (amniyon sıvısı)
9. **Zamanından önce düzenli kasılmalar** (37. haftadan önce)
10. Şiddetli, sürekli kusma; idrar yaparken yanma + ateş; nefes darlığı; şiddetli karın ağrısı

9. Gebelikte sık yakınmalar ve öneriler

Yakınma	Öneri
Bulantı-kusma (ilk trimester)	Az ve sık yemek; sabah kalkmadan kuru kraker; yağlı-baharatlı ve kokulu yiyeceklerden kaçınma; sıvıyı öğün arası alma. **Şiddetli, kilo kaybı ve idrar azalması** → hiperemezis → hekime
Mide yanması (pirozis)	Az-sık öğün; yemekten sonra 2–3 saat yatmama; yatağın baş tarafını yükseltme; asitli-yağlı yiyecek ve çayı azaltma
Kabızlık	Lifli besin, **günde 8–10 bardak su**, yürüyüş; demirin kabızlık yapabileceğini bil
Hemoroid	Kabızlığı önleme, uzun süre oturmama, ılık oturma banyosu
Bacak krampları	Germe egzersizi (ayak ucunu kendine çekme), yeterli kalsiyum, bacakları dinlendirme
Varis, ayak ödemi	Bacakları yükseltme, uzun süre ayakta/oturur kalmama, bacak bacak üstüne atmama, gerekirse varis çorabı
Bel ağrısı	Doğru postür, düz/alçak topuklu ayakkabı, yük kaldırırken dizleri bükme, uygun egzersiz
Sık idrara çıkma	Normaldir (ilk ve son trimester); **yanma, ateş, kanlı idrar** varsa İYE → hekime
Uykusuzluk / sırtüstü yatınca baş dönmesi	**Sol yana yatma** (vena kava basısını önler – supin hipotansiyon), yastık desteği
Diş eti kanaması	Ağız hijyeni, diş hekimi kontrolü (gebelikte diş tedavisi yapılabilir)

10. Gebelikte sağlıklı yaşam eğitimi

- **Beslenme:** Çeşitli, dengeli; 2. trimesterde günlük ~340 kcal, 3. trimesterde ~450 kcal ek enerji ("iki kişilik yemek" yanlıştır); protein, demir, kalsiyum, folat kaynakları; günde 8–10 bardak su.
- **Kaçınılacaklar:** Alkol (hiç güvenli miktar yok), sigara (pasif dahil), **çiğ/az pişmiş et ve yumurta**, **pastörize edilmemiş süt ve peynir** (listeria), yıkanmamış sebze-meyve, cıvası yüksek büyük balıklar; kafeini sınırla (~200 mg/gün ≈ 2 fincan kahve).
- **İlaç:** Hekime danışmadan ilaç/bitkisel ürün kullanmama.
- **Egzersiz:** Kontrendikasyon yoksa haftada ~150 dk orta şiddette (yürüyüş, yüzme, gebe pilatesi); karın üstü ve düşme riski olan sporlardan kaçınma.
- **Seyahat:** Emniyet kemeri – kucak kayışı karnın **altından**, kalçalar üzerinden; uzun yolculukta 1–2 saatte bir mola, bacak hareketleri.

- **Hijyen ve enfeksiyondan korunma:** El yıkama, kedi kumu temizlememe (toksoplazma).
- **Doğuma hazırlık:** Gebe okulu/doğuma hazırlık sınıfları, doğum çantası, doğum yeri ve ulaşım planı.

Doğum başladığının belirtileri

- **Düzenli, giderek sıklaşan ve şiddetlenen** ağrılı kasılmalar (ilk doğumda ~5 dakikada bir, bir saattir devam eden)
- **Kanlı nişan** (kanlı mukus tıkacının gelmesi)
- **Su gelmesi** → kasılma olmasa da **hemen** hastaneye

BÖLÜM B – LOHUSA (DOĞUM SONU) İZLEMİ

11. Lohusalık ve izlem takvimi

- **Lohusalık:** Doğumdan sonraki **6 hafta (42 gün)**.
- Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberine göre: **İlk 24 saat** hastanede izlem (normal doğumda en az 24 saat, sezaryende en az 48 saat hastanede kalış önerilir); taburculuktan sonra **42. güne kadar** sağlık kuruluşunda ya da evde izlemler.
- Taburculuk sonrası birinci basamakta **en az 3 izlem** yapılır; ders kitaplarında sık geçen zamanlama:
  - **1. izlem: 2.–5. gün**
  - **2. izlem: 13.–17. gün (≈ 2. hafta)**
  - **3. izlem: 30.–42. gün (≈ 4–6. hafta)**

> Bazı kaynaklar bunu "ilk 24 saat, 2. hafta, 4–6. hafta" şeklinde verir. ASM'deki izlem formunu kontrol et ve **bebek izlemleri ile aynı günlere denk getirmeye** çalış (anne-bebek birlikte izlenir).

12. Lohusa izleminin basamakları

1. **Öykü:** Doğum şekli ve tarihi, doğumda komplikasyon (kanama, epizyotomi, yırtık), taburculuk durumu; şu anki yakınmalar (ağrı, kanama, ateş, idrar-dışkılama, meme sorunları, uyku); emzirme; duygu durumu; destek sistemi.
2. **Vital bulgular: Ateş** (24 saat sonrası ≥38 °C → enfeksiyon şüphesi), **nabız** (taşikardi → kanama/enfeksiyon), **KB** (postpartum preeklampsi!), solunum.
3. **Memeler:** Kolostrum/süt, meme başı çatlağı, angorjman, kızarıklık-sertlik-ağrı (mastit).
4. **Uterus (involüsyon) – fundus yüksekliği ve kıvamı:**
   - Doğumdan hemen sonra **göbek hizası/biraz altı**, sert ve kontrakte
   - İlk 12 saatte göbek hizasına ya da biraz üstüne çıkabilir
   - Sonra **günde ~1 cm (1 parmak)** aşağı iner
   - **~10–14. günde** karından palpe edilmez; ~6 haftada gebelik öncesi boyutuna döner
   - **Yumuşak, gevşek uterus** → atoni/kanama riski → fundus masajı, mesaneyi boşaltma, emzirme, hemen hekime
5. **Loşia:** | Tür | Süre | Görünüm | |---|---|---| | **Rubra** | 1.–3./4. gün | Kırmızı, kanlı, küçük pıhtılar olabilir | | **Serosa** | 4.–10. gün | Pembe-kahverengi, sulu | | **Alba** | 10. günden 2–6. haftaya | Sarımsı-beyaz |
   - **Kötü koku** → enfeksiyon; **miktarın artması, büyük pıhtılar, rubranın geri dönmesi** → kanama/plasenta artığı → hekime.
6. **Perine/epizyotomi – REEDA: R**edness (kızarıklık), **E**dema (ödem), **E**cchymosis (ekimoz), **D**ischarge (akıntı), **A**pproximation (yara kenarlarının birleşmesi). Hemoroid.
7. **Sezaryen yarası:** Kızarıklık, akıntı, açılma, ağrı; pansuman ve hijyen.
8. **Mesane ve bağırsak:** İdrar retansiyonu/inkontinans, idrarda yanma; kabızlık.

9. **Bacaklar:** Tek taraflı ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı → **derin ven trombozu** şüphesi (Homans bulgusu tek başına güvenilir değil) → acil.
10. **Duygu durumu:**
    - **Lohusa hüznü (baby blues):** Kadınların büyük bölümünde, **2.–3. günde** başlar, ağlamaklılık, duygusal dalgalanma; **2 hafta içinde kendiliğinden geçer.** Destek ve dinlenme.
    - **Doğum sonrası depresyon:** Belirtiler **2 haftadan uzun**, işlevsellik bozuluyor, bebeğe ilgisizlik, umutsuzluk, uyku-iştah bozukluğu → **hekime yönlendir.** Tarama: **Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği** (10 madde; Türkçe geçerlilik çalışmasında **≥13 puan** risk olarak kabul edilir).
    - **Doğum sonrası psikoz:** Nadir; ilk haftalarda halüsinasyon, sanrı, ajitasyon, bebeğe zarar düşüncesi → **acil**.
11. **Beslenme, dinlenme, destekler:** Emziren anneye ek ~500 kcal/gün, susadıkça su; **demir (doğum sonrası 3. ay sonuna kadar)** ve **D vitamini (6. ay sonuna kadar)** devam.
12. **Aile planlaması danışmanlığı.**
13. **Eğitim:** Perine hijyeni (önden arkaya temizlik, ped değişimi sık, el yıkama), Kegel egzersizleri, emzirme, bebek bakımı, tehlike belirtileri, cinsel yaşam (loşia bitip perine iyileştikten sonra, genellikle ~4–6 hafta; çift hazır olduğunda), Rh(−) ise anti-D yapıldı mı.
14. **Kayıt ve sonraki izlem.**

13. Doğum sonu tehlike belirtileri (lohusaya öğret)

1. **Ani artan kanama** (1 saatte bir pedi tamamen ıslatacak kadar) ya da büyük pıhtılar
2. **Ateş ≥38 °C**, titreme
3. **Kötü kokulu akıntı**, şiddetli alt karın ağrısı
4. **Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, havale** (doğum sonu preeklampsi/eklampsi)
5. **Nefes darlığı, göğüs ağrısı** (pulmoner emboli)
6. **Bacakta tek taraflı ağrı, şişlik, kızarıklık** (DVT)
7. **Memede kızarık, sıcak, ağrılı alan + ateş** (mastit/apse)
8. Epizyotomi/sezaryen yarasında açılma, akıntı
9. İdrar yaparken yanma, idrar yapamama
10. **Kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri**, derin umutsuzluk

14. Emzirme sorunları ve çözümleri

Sorun	Nedeni	Ne önerirsin?
Meme başı ağrısı/ çatlağı	En sık **yanlış kavrama**	Kavramayı düzelt (Bölüm 05); emzirme sonrası birkaç damla sütü meme başına sürüp kurutma; emzirmeyi daha az ağrıyan memeden başlatma; sabun/alkol kullanmama
Angorjman (memelerde aşırı dolgunluk)	3.–5. günlerde süt gelişi, seyrek emzirme	**Sık ve etkili emzirme**, gerekirse emzirme öncesi biraz süt sağma; **emzirme öncesi ılık**, **sonrası soğuk** uygulama
Tıkalı süt kanalı	Memenin bir bölümünün yeterince boşalmaması	O memeden sık emzirme, farklı pozisyonlar, nazik masaj; sıkı sütyen giymeme
Mastit	Tıkanıklık ± enfeksiyon; ateş, kızarıklık, ağrı	**Emzirmeye devam**, dinlenme, sıvı; **hekime yönlendirme**
"Sütüm yetmiyor" algısı	Çoğu zaman algı	Yeterlilik göstergelerini anlat (ıslak bez, kilo alımı); sık emzirme, gece emzirme; biberon/emzik ve mama ile takviyeden kaçınma
Çalışan anne	İşe dönüş	Süt sağma ve saklama, süt izni hakları

15. Doğum sonu aile planlaması

- **Laktasyonel amenore yöntemi (LAM): Üç koşul birlikte** sağlanırsa (1) bebek **6 aydan küçük**, (2) **tam ya da tama yakın emzirme** (gece dahil, aralar uzun değil), (3) **adet kanaması başlamamış** → yüksek koruma. Koşullardan biri bozulursa başka yönteme geçilir.
- **Emziren annede** östrojen içermeyen yöntemler tercih edilir: kondom, **bakırlı RİA**, progestinli yöntemler (hap, enjeksiyon, implant – zamanlama hekim/AP birimiyle).
- **Kombine oral kontraseptifler** süt miktarını azaltabileceğinden emziren annede genellikle **ilk 6 ayda önerilmez**; emzirmeyen annede tromboz riski nedeniyle **ilk 3 hafta** (risk faktörü varsa 6 hafta) kullanılmaz.
- **Bakırlı RİA:** Doğumdan sonraki **48 saat içinde** ya da **4. haftadan sonra** takılabilir.
- Gebelikler arası en az **2 yıl** (doğum ile bir sonraki gebelik arası en az 24 ay) bırakılması önerilir.

---

16. Örnek: "28 haftalık gebe izlemini anlat" – model cevap

> "Kayıtlarını incelerim (önceki KB, kilo, Hb, OGTT planı). Karşılayıp kendimi tanıtır, izin alırım. Öyküde baş ağrısı, görme bozukluğu, ödem, kanama, su gelmesi, kasılma ve **bebek hareketlerini** sorarım; demir ve D vitamini kullanımını, beslenme ve uykusunu sorgularım. KB, kilo ölçerim, ödemi değerlendiririm; fundus yüksekliğini ölçerim (~28 ± 2 cm beklerim), Doppler ile FKS'yi dinlerim (110–160/dk). Leopold manevralarına başlayabilirim. İdrarda protein bakarım. Hb sonucu ve 24–28. hafta OGTT sonucunu kontrol ederim; Rh(–) ise anti-D planını hekime hatırlatırım. Td durumunu kontrol ederim. Eğitimde **fetal hareket sayımını** (2 saatte en az 10 hareket), **tehlike belirtilerini**, sol yana yatmayı, demirin doğru kullanımını ve emzirme hazırlığını anlatırım. Kaydeder, **bir sonraki izlemin 36–38. haftalarda** olduğunu, risk belirtisi varsa beklemeden gelmesini söylerim."

---

17. Kendini test et

1. Gebe izlemleri kaç tane ve hangi haftalarda?
2. SAT 25.01.2026 ise TDT nedir? (Cevap: 01.11.2026)
3. Fundus 20–22. haftada nerededir? McDonald kuralı nedir?
4. Gebelikte anemi Hb sınırı nedir? Demir ve D vitamini desteği ne zaman başlar, ne zaman biter?
5. 24–28. hafta OGTT eşik değerleri nelerdir?
6. Gebelikteki 10 tehlike belirtisini say.
7. Doğum sonu 5. günde fundus nerede olmalı? Loşia hangi tipte olmalı?
8. Lohusa hüznü ile doğum sonu depresyonu nasıl ayırt edersin?
9. LAM'ın 3 koşulu nedir?

07 – Erişkin, Yaşlı ve Kronik Hastalığı Olan Birey İzlemi

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 7 — "SB izlem kriterleri doğrultusunda yaşlı/erişkin/kronik hastalığı olan birey izlemi yapabilme" · FR.185 madde 21 (yaşlı izlemi, kronik hasta izlemi)

> Aile hekimliğinde kronik hastalıkların taranması ve izlemi **Hastalık Yönetim Platformu (HYP)** üzerinden yürütülür: hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler risk, obezite, KOAH, kronik böbrek hastalığı ve yaşlı sağlığı modülleri. Klinik hedefler ulusal ve uluslararası rehberlere (TEMD, ESH, GOLD vb.) dayanır.

---

1. Kronik hasta izleminin genel iskeleti

1. Kayıtları incele (tanılar, ilaçlar, son ölçümler, tahliller, hedefler).
2. Karşıla, kimlik, izin.
3. **Öykü:** Yakınmalar, ilaçlar (adı-dozu-saati, **uyum**, yan etkiler, bitkisel ürünler), diyet, fiziksel aktivite, sigara-alkol, uyku, stres, son başvurular, komplikasyon belirtileri.
4. **Ölçümler: KB**, nabız, **boy-kilo-BKİ**, **bel çevresi**, kan şekeri (glukometre), gerekiyorsa SpO_2, ayak muayenesi.
5. **Tahlil takibi:** HbA1c, lipidler, kreatinin/eGFR, idrarda albümin, Hb.
6. **Risk değerlendirmesi:** Kardiyovasküler risk, komplikasyon taraması (göz, ayak, böbrek).
7. **Eğitim:** Hastalık, ilaç, yaşam tarzı, öz-izlem, komplikasyon belirtileri.
8. **Aşılar:** İnfluenza, pnömokok, Td.
9. **Kanser taramaları** (yaş uygunsa – Bölüm 08).
10. **Kayıt, hedef belirleme, sonraki izlem**; hedefe ulaşılamadıysa hekime bildir.

---

2. Hipertansiyon

2.1 Doğru kan basıncı ölçümü (adım adım – mutlaka bil!)

1. Ölçümden **30 dk önce** sigara, kafein, egzersiz yok; mesane boş.
2. **5 dk** sessiz ortamda oturarak dinlenme.
3. Sırt destekli oturma, **ayaklar yerde, bacaklar çaprazlanmamış**; ölçüm sırasında **konuşma yok**.
4. Kol çıplak (sıkan giysi yok), **kalp hizasında** ve desteklenmiş.
5. **Uygun boyutta manşon**: şişirilebilir kısım kol çevresinin ~%80'ini sarmalı; dar manşon değeri **yüksek**, geniş manşon **düşük** gösterir.
6. Manşonun alt kenarı antekübital çukurun **2–3 cm üstünde**, ortası brakiyal arter üzerinde.
7. (Manuel ölçümde) Önce radyal nabız kaybolana kadar şişirip tahmini sistolik değeri bul, sonra bunun **20–30 mmHg üstüne** şişir; **saniyede 2–3 mmHg** hızla indir. İlk duyulan ses (Korotkoff 1) sistolik, seslerin kaybolduğu nokta (Korotkoff 5) diyastolik.
8. **1–2 dk arayla 2–3 ölçüm**, ortalaması alınır.
9. **İlk değerlendirmede iki koldan** ölç; yüksek olan kol sonraki ölçümlerde kullanılır (kollar arası >10–15 mmHg fark → hekime).
10. Yaşlı ve diyabetlilerde **ortostatik hipotansiyon** için ayakta 1 ve 3. dk ölçümü (sistolikte ≥20 veya diyastolikte ≥10 mmHg düşüş).

2.2 Sınıflama (ofis ölçümü, mmHg – ESH)

Kategori	Sistolik		Diyastolik
Optimal	<120	ve	<80
Normal	120–129	ve/veya	80–84
Yüksek normal	130–139	ve/veya	85–89
Evre 1 HT	140–159	ve/veya	90–99
Evre 2 HT	160–179	ve/veya	100–109
Evre 3 HT	**≥180**	ve/veya	**≥110**

- **Ev ölçümünde** ≥135/85 hipertansif kabul edilir.
- Genel tedavi hedefi çoğu hastada **<140/90**, tolere ediliyorsa daha düşük (hekim belirler).
- **≥180/110 + baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, görme bozukluğu, nörolojik bulgu** → **hipertansif acil** → hemen hekime/112.

2.3 Yaşam tarzı önerileri (eğitim içeriği)

- **Tuz <5 g/gün** (≈1 silme çay kaşığı): sofraya tuzluk koymama, turşu-salamura-hazır gıda-ekmek tuzuna dikkat, baharat-limonla lezzetlendirme.
- **DASH tipi beslenme:** Sebze-meyve, tam tahıl, az yağlı süt ürünü; doymuş yağ ve şekeri azaltma.
- **Kilo verme** (her ~1 kg kayıp KB'yi ~1 mmHg düşürür), bel çevresini azaltma.
- **Fiziksel aktivite:** Haftada **en az 150 dk orta şiddette** (tempolu yürüyüş), haftada 2 gün kas güçlendirme.
- **Sigarayı bırakma**, alkolü sınırlama/bırakma.
- **İlaç uyumu:** İlaçları her gün aynı saatte, kendini iyi hissetse de bırakmadan; unutmayı önlemek için ilaç kutusu/alarm.

---

3. Diyabet

3.1 Tanı ve tarama

Test	Diyabet	Prediyabet
Açlık plazma glukozu (≥8 saat açlık)	**≥126 mg/dl**	100–125 (bozulmuş açlık glukozu)
75 g OGTT 2. saat	**≥200 mg/dl**	140–199 (bozulmuş glukoz toleransı)
HbA1c	**≥%6,5**	%5,7–6,4
Rastgele glukoz + klasik belirtiler	**≥200 mg/dl**	—

- Klasik belirtiler: **poliüri, polidipsi, polifaji, açıklanamayan kilo kaybı**, yorgunluk, bulanık görme, yara iyileşmesinde gecikme, sık enfeksiyon.
- Tarama: Fazla kilolu/obez ve ek risk faktörü (aile öyküsü, HT, dislipidemi, gestasyonel diyabet öyküsü, hareketsizlik) olanlarda erken; risk yoksa orta yaştan itibaren periyodik (rehberler arasında yaş eşiği değişir – kurum/HYP uygulamasına uy).

3.2 Genel hedefler (kişiye göre hekim belirler)

- **HbA1c <%7** (yaşlı/kırılgan bireyde daha esnek, ör. <%7,5–8)
- Öğün öncesi kan şekeri **80–130 mg/dl**, öğünden sonra 2. saat **<180 mg/dl**
- KB <130–140/80–90, LDL hedefleri risk düzeyine göre

3.3 Hipoglisemi – "15-15 kuralı"

- Belirtiler: Terleme, titreme, çarpıntı, açlık, baş dönmesi, sinirlilik, bulanık görme, konfüzyon, bilinç kaybı.
- **Kan şekeri <70 mg/dl** ve bilinç açık → **15 g basit karbonhidrat** (½ su bardağı meyve suyu, 3–4 kesme şeker, 1 yemek kaşığı bal) → **15 dk sonra yeniden ölç** → hâlâ <70 ise tekrarla → düzelince bir sonraki öğün uzaksa kompleks karbonhidrat (ekmek, bisküvi).
- **Bilinç kapalı** → ağızdan bir şey verilmez → **112**, (eğitimli kişi varsa) glukagon.

3.4 Diyabetik ayak bakımı (eğitim)

1. **Her gün ayakları** (tabanı aynayla) kontrol et: yara, kızarıklık, nasır, çatlak, renk değişikliği.
2. **Ilık suyla** yıka (suyun sıcaklığını elle değil dirsekle/termometreyle kontrol et), **parmak aralarını iyice kurula**.
3. Kuru cilde nemlendirici (parmak aralarına değil).
4. **Tırnakları düz kes**, köşeleri yuvarlatma; nasırı kendin kesme.
5. **Çıplak ayakla yürüme**, sıcak su torbası/soba ile ısıtma yapma.
6. Dikişsiz pamuklu çorap, ayağı sıkmayan geniş burunlu ayakkabı; giymeden önce içini kontrol et.
7. Küçük bir yara bile olsa beklemeden sağlık kuruluşuna başvur.

- Sağlık çalışanı: Yılda en az bir kez **monofilament** ile duyu testi, nabızlar, deformite.

3.5 İnsülin ve glukometre eğitimi

- Bölge rotasyonu, kalem iğnesini her uygulamada değiştirme, enjeksiyondan sonra 10 sn bekleme (Bölüm 04).
- Açılmamış insülin buzdolabında (dondurulmaz); kullanımdaki kalem oda ısısında ~4 hafta.
- Hipoglisemi belirtileri ve 15-15 kuralı; hasta günü kuralları (hastalıkta insülini bırakmama, sık ölçüm, sıvı alımı, hekime danışma).
- **Teach-back** ile hastaya gösterip yaptırma.

3.6 Komplikasyon taramaları (yılda en az bir)

Göz dibi muayenesi (retinopati), idrarda albümin ve eGFR (nefropati), ayak muayenesi (nöropati, arter hastalığı), lipid profili, KB her vizitte, diş muayenesi.

---

4. Obezite ve kardiyometabolik risk

BKİ (kg/m²)	Sınıf
<18,5	Zayıf
18,5–24,9	Normal
25–29,9	Fazla kilolu (hafif şişman)
30–34,9	Obez – sınıf I
35–39,9	Obez – sınıf II
≥40	Obez – sınıf III (morbid)

- **BKİ = Ağırlık (kg) / Boy² (m²)** — Örnek: 82 kg, 1,65 m → 82 / 2,72 = **30,1** (obez sınıf I).
- **Bel çevresi** (kaburga alt kenarı ile iliak kristanın orta noktası, ekspiryum sonunda): **Kadında ≥80 cm** risk artışı, **≥88 cm** belirgin risk; **erkekte ≥94 cm** risk artışı, **≥102 cm** belirgin risk (WHO).
- **Bel/kalça oranı:** Kadında >0,85, erkekte >0,90 abdominal obezite.
- **Kardiyovasküler risk faktörleri:** Yaş, erkek cinsiyet, sigara, HT, diyabet, dislipidemi, obezite, hareketsizlik, ailede erken KVH öyküsü, kronik böbrek hastalığı. 10 yıllık risk hekim tarafından risk skorlarıyla (SCORE2 vb.) hesaplanır.

- **Sağlıklı beslenme:** Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) önerileri; tabak modeli – tabağın yarısı sebze-meyve, dörtte biri tam tahıl, dörtte biri protein kaynağı; süt ürünü; su; şekerli içecek ve işlenmiş gıdayı azaltma; tuz <5 g.

Kalp krizi ve inme uyarı belirtileri (eğitimde anlat)

- **Kalp krizi:** Göğüste baskı/sıkışma, kola-çeneye-sırta yayılan ağrı, soğuk terleme, nefes darlığı, bulantı → **112** (diyabetlide ve kadında belirtiler atipik olabilir).
- **İnme – BE-FAST: B**alance (denge kaybı), **E**yes (görme kaybı), **F**ace (yüzde kayma), **A**rm (kolda güçsüzlük), **S**peech (konuşma bozukluğu), **T**ime (zaman – hemen **112**).

---

5. KOAH ve astım

- **KOAH:** En önemli risk faktörü **sigara** (biyomas yakıt, mesleki toz da). Belirtiler: kronik öksürük, balgam, efor dispnesi. Tanı spirometri ile.
- **Eğitim:**
  - **Sigarayı bırakma** (en etkili girişim)
  - **İnhaler tekniği** (en sık hata!):
    - *Ölçülü doz inhaler (MDI):* Kapağı aç, **çalkala**, tamamen nefes ver, ağızlığı dudaklarla kavra, **yavaş ve derin nefes alırken** bir kez bas, nefesi **~10 sn tut**, yavaşça ver; ikinci puf için ~30–60 sn bekle. Koordinasyon zorsa **spacer (aralık odacığı)**.
    - *Kuru toz inhaler:* Çalkalanmaz; cihaza nefes verilmez; **hızlı ve güçlü** nefes alınır; nefes tutulur.
    - **Kortikosteroid** inhalerden sonra **ağzı çalkalama** (ağız mantarını önler).
  - Pursed-lip (büzük dudak) solunumu, diyafragmatik solunum
  - Alevlenme belirtileri (artan nefes darlığı, balgamın artması/renginin değişmesi, ateş) → hekime
  - **İnfluenza (yıllık) ve pnömokok aşıları**
- **Sigara bırakma – 5A yaklaşımı: A**sk (sor – her vizitte), **A**dvise (net öneri), **A**ssess (bırakmaya istekli mi – transteorik aşama), **A**ssist (destek: plan, bırakma tarihi, ilaç tedavisi için hekim, **ALO 171** Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakma poliklinikleri), **A**rrange (takip randevusu).

---

6. Yaşlı sağlığı ve yaşlı izlemi

6.1 Temel kavramlar

- **65 yaş ve üzeri** yaşlı kabul edilir (65–74 genç yaşlı, 75–84 orta yaşlı, 85+ ileri yaşlı).
- **Geriatrik sendromlar:** Düşmeler, idrar inkontinansı, **deliryum**, demans, depresyon, **polifarmasi**, malnütrisyon, bası yarası, kırılganlık (frailty), uyku bozuklukları, duyusal kayıplar (görme-işitme).

6.2 Kapsamlı geriatrik değerlendirme – kullanılan ölçekler

Alan	Ölçek	Yorum (özet)
Temel günlük yaşam aktiviteleri (yıkanma, giyinme, tuvalet, transfer, kontinans, beslenme)	**Katz GYA İndeksi**	Bağımlılık düzeyi
Enstrümantal GYA (telefon, alışveriş, yemek hazırlama, ev işi, çamaşır, ulaşım, ilaç, para yönetimi)	**Lawton-Brody EGYA**	Bağımsız yaşam kapasitesi
Bilişsel durum	**Mini Mental Durum Testi (MMSE)**	30 üzerinden; genellikle **<24** bilişsel bozukluk şüphesi (eğitim düzeyine göre uyarlanır)
Depresyon	**Geriatrik Depresyon Ölçeği (kısa form, 15 madde)**	**≥5** depresyon şüphesi

Alan	Ölçek	Yorum (özet)
Beslenme	**Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA)**	Malnütrisyon / risk
Düşme riski / mobilite	**Kalk ve Yürü Testi (Timed Up and Go)**	Sandalyeden kalk, 3 m yürü, dön, otur: **≥12–14 sn** düşme riski
Bası yarası riski	**Braden Ölçeği**	Puan düştükçe risk artar (≤18 risk)
Bakım veren yükü	**Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği**	Bakım verenin desteğe ihtiyacı

6.3 Düşmeleri önleme (en sık eğitim konularından)

- **Risk faktörleri:** Önceki düşme, kas güçsüzlüğü, denge-yürüme bozukluğu, görme sorunu, **çoklu ilaç (sedatif, antihipertansif, diüretik)**, ortostatik hipotansiyon, idrar aciliyeti, demans, uygun olmayan ayakkabı, ev ortamı tehlikeleri.
- **Ev güvenliği:** Kaygan halıları kaldır/kaydırmaz yap; **yeterli aydınlatma**, gece lambası (yatak odası → tuvalet yolu); banyoda **tutunma barı** ve kaydırmaz paspas; merdivende küpeşte; eşikleri kaldır; sık kullanılan eşyaları el seviyesine al; kablolar yürüme yolunda olmasın.
- **Kişisel:** Yataktan **yavaş kalkma** (önce oturup 1–2 dk bekle), kaymaz tabanlı kapalı ayakkabı/terlik, gözlük ve işitme cihazının kullanımı, **denge ve kuvvet egzersizleri**, D vitamini ve kalsiyum (hekim), ilaçların gözden geçirilmesi, gerekirse baston/yürüteç.
- Düştüğünde nasıl kalkacağını ve yardım çağıracağını (telefonu yakın tutma) öğret.

6.4 Polifarmasi ve akılcı ilaç kullanımı

- **≥5 ilaç** kullanımı polifarmasi olarak kabul edilir; etkileşim, yan etki, düşme ve uyumsuzluk riski.
- **Hemşirenin rolü:** Tüm ilaçları (reçetesiz, bitkisel dahil) "**ilaç poşeti**" yöntemiyle gözden geçirme; ilaç listesi hazırlama; **haftalık ilaç kutusu**; büyük puntolu yazılı talimat; yaşlılarda uygunsuz olabilecek ilaçlar (**Beers kriterleri**) açısından hekime bildirme.
- Antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle kullanılması, artan ilaçların atılması (ilaç atık kutusu).

6.5 Diğer yaşlı izlemi konuları

- **İnkontinans:** Mahremiyetle sor; pelvik taban egzersizleri, tuvalet programı, cilt bakımı.
- **Beslenme:** Protein ve sıvı yeterliliği (susama hissi azalır – dehidratasyon), diş/protez sorunları, yalnız yaşayanlarda yetersiz beslenme.
- **Sıcak çarpması ve hipotermi** riski; yazın bol sıvı, serin ortam.
- **Yaşlı ihmali/istismarı:** Açıklanamayan yaralar, hijyen eksikliği, ilaçların verilmemesi, ekonomik sömürü → bildir.
- **Sosyal izolasyon ve yalnızlık:** Sosyal destek kaynakları, gündüzlü bakım, yaşlı merkezleri.
- **Evde sağlık hizmetleri:** Yatağa bağımlı yaşlılar için hastaneye bağlı evde sağlık birimlerine yönlendirme.
- **Aşılar: Yıllık influenza**, **pnömokok**, Td (10 yılda bir).

---

7. Erişkine yönelik koruyucu hizmetler (özet tablo)

Hizmet	Kime	Sıklık
KB ölçümü	Tüm erişkinler	En az yılda bir (risk varsa daha sık)
BKİ, bel çevresi	Tüm erişkinler	Her izlemde
Kan şekeri taraması	Risk faktörü olanlar / yaş kriteri	Kurum/HYP protokolüne göre
Lipid profili	KVH riski olanlar	Hekim önerisi
Kanser taramaları	Meme 40–69 K; Serviks 30–65 K; Kolorektal 50–70 K+E	Bölüm 08

Hizmet	Kime	Sıklık
Td	Tüm erişkinler	10 yılda bir
İnfluenza	65+, kronik hastalar, gebeler, sağlık çalışanları	Her yıl (sonbahar)
Pnömokok	65+, risk grupları	Hekim önerisi
Sigara sorgulama	Herkes	Her başvuruda

8. Örnek: "68 yaşında hipertansif ve diyabetik birey izlemi" – model cevap

> "Kayıtlarını incelerim: ilaçları, son HbA1c ve KB değerleri. Kendimi tanıtır, izin alırım. Öyküde baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ayaklarda uyuşma-yara, hipoglisemi atakları, ilaçlarını nasıl kullandığını (uyum, unutma), diyetini (tuz, ekmek, tatlı), yürüyüş yapıp yapmadığını, sigara kullanımını sorarım. Doğru teknikle 2 kez KB ölçer ortalamasını alırım; ayakta ölçümle ortostatik hipotansiyonu değerlendiririm; kilo, BKİ, bel çevresi ve parmak ucu kan şekeri ölçerim; ayaklarını incelerim. Kalk ve Yürü testi ile düşme riskini, gerekirse GYA ölçeklerini uygularım. Eğitimde tuz kısıtlaması, ilaç uyumu, 15-15 kuralı, ayak bakımı ve düşmeleri önleme konularını, öğret-geri al yöntemiyle anlatırım. Influenza ve pnömokok aşısını, kolorektal kanser taramasını (50–70 yaş) kontrol ederim. Bulguları kaydedip hedef dışı değerleri hekime bildiririm ve bir sonraki izlem tarihini belirlerim."

9. Kendini test et

1. Doğru KB ölçümünün 10 basamağını say. Dar manşon değeri nasıl etkiler?
2. Evre 1, 2, 3 HT sınırları nelerdir?
3. Diyabet tanı kriterleri nelerdir? HbA1c hedefi genel olarak kaçtır?
4. 15-15 kuralını anlat.
5. Diyabetik ayak bakımında 7 öneri say.
6. MDI kullanımında en sık hatalar neler?
7. Yaşlıda düşme riskini hangi testle değerlendirirsin? Evde hangi önlemleri önerirsin?
8. Polifarmasi nedir? Hemşire ne yapar?

08 – Kanser Tarama Programları ve Eğitimleri

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 10 — "Kanser tarama programları için gerekli işlemleri (**GGT, KKMM, HPV-SMEAR**) yapabilme/uygulayabilme/anlatabilme" · FR.185 madde 23 (kanser tarama eğitimi: plan + en az 1 materyal, **haftada en az 15 kişi**, fotoğraf) · FR.186 madde 13 (her saha günü en az 1 kanser tarama eğitimi)

> **GGT** = **G**aitada **G**izli kan **T**esti · **KKMM** = **K**endi **K**endine **M**eme **M**uayenesi · **KMM** = Klinik Meme Muayenesi · **HPV** = İnsan papilloma virüsü · **KETEM** = Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi

---

1. Tarama nedir, neden yapılır?

- **Tarama:** Belirti vermeyen (asemptomatik) sağlıklı görünen kişilerde hastalığı **erken evrede** ya da **kanser öncüsü lezyon** aşamasında bulmak için uygulanan testler. **İkincil koruma** örneğidir.
- **İyi bir tarama programının özellikleri (Wilson-Jungner ölçütlerinden):** Hastalık önemli bir sağlık sorunu olmalı; erken evresi tanınabilir olmalı; etkili tedavisi bulunmalı; test basit, ucuz, güvenilir, kabul edilebilir olmalı; maliyet-etkili ve sürekli olmalı.
- **Türkiye'de ulusal (toplum tabanlı) tarama programı olan 3 kanser: Meme, serviks (rahim ağzı), kolorektal (kalın bağırsak).**
- Hizmet sunan yerler: **KETEM**'ler, **ASM**'ler, mobil tarama araçları. Hedef nüfus SMS ve ASM çağrılarıyla davet edilir. Tarama hizmetleri **ücretsizdir**.

2. Ulusal kanser tarama standartları (özet tablo – ezberle)

Kanser	Hedef grup	Test	Sıklık
Meme	**40–69 yaş kadınlar**	**Mamografi** (+ klinik meme muayenesi)	**2 yılda bir**
	Tüm yetişkin kadınlar (genellikle 20 yaştan itibaren)	**KKMM** (meme farkındalığı)	**Ayda bir**
Serviks	**30–65 yaş kadınlar**	**HPV-DNA testi** (+ smear/sitoloji)	**5 yılda bir**
Kolorektal	**50–70 yaş kadın ve erkekler**	**Gaitada gizli kan testi (GGT)**	**2 yılda bir**
		Kolonoskopi	**10 yılda bir**

> Ezber cümlesi: "**Meme 40'ta başlar, 2 yılda bir; Rahim 30'da başlar, 5 yılda bir; Bağırsak 50'de başlar, 2 yılda bir.**"

---

3. Meme kanseri

3.1 Bilmen gerekenler

- Kadınlarda **en sık görülen kanser**.
- **Risk faktörleri:** Kadın cinsiyet, ileri yaş, **birinci derece akrabada meme/over kanseri**, BRCA1/2 mutasyonu, kendisinde daha önce meme kanseri, **erken menarş (<12)**, **geç menopoz (>55)**, hiç doğum yapmamış olmak ya da **ilk doğumun 30 yaşından sonra** olması, **emzirmemek**, uzun süreli hormon replasman tedavisi, menopoz sonrası **obezite**, **alkol**, fiziksel hareketsizlik, göğüse radyoterapi öyküsü.
- **Koruyucu etkenler:** Emzirme, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı kilo, alkol kullanmama.

3.2 Meme kanserinin uyarı belirtileri

- Memede ya da koltuk altında **ele gelen kitle/sertlik**

- Memenin boyut veya şeklinde **yeni asimetri**
- Ciltte **çekinti**, **portakal kabuğu görünümü**, kızarıklık, ısı artışı
- Meme başında **yeni çekilme** ya da yön değişikliği
- Meme başından **kendiliğinden, özellikle kanlı akıntı**
- Meme başı ve çevresinde **egzama benzeri kabuklanma/yara** (Paget)
- Koltuk altında şişlik

3.3 KKMM – kendi kendine meme muayenesi (gösterip yaptırmalısın!)

Ne zaman?

- Adet gören kadın: **adet kanamasının bitiminden sonraki 5.–7. günler** (memeler en az hassas ve ödemsizdir).
- Menopozdaki, gebe, emziren, adet düzensizliği olan ya da histerektomili kadın: **her ayın aynı günü** (ör. ayın 1'i).

1. aşama – Ayna karşısında bakma (inspeksiyon) Bel hizasına kadar soyunarak, iyi ışıkta, dört pozisyonda bakılır:

1. Kollar iki yanda serbest
2. Kollar başın üstünde
3. Eller belde, kalçaya bastırarak göğüs kasları kasılı
4. Hafifçe öne eğilmiş

Bakılacaklar: Boyut-şekil asimetrisi, ciltte çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık, meme başında çekilme-yön değişikliği, yara, kabuklanma, akıntı izi.

2. aşama – Elle muayene (palpasyon)

- **Yatarak** (ve/veya duşta, ıslak-sabunlu ciltte): Muayene edilecek memenin tarafındaki omuz altına küçük bir yastık/katlanmış havlu, **o taraftaki kol başın altında**; böylece meme dokusu göğüs duvarına yayılır.
- **Karşı elin işaret, orta ve yüzük parmaklarının iç yüzleri (pulpaları)** ile, parmaklar düz ve bitişik.
- **Bozuk para büyüklüğünde küçük dairesel hareketler**.
- Her noktada **üç basınç düzeyi**: hafif (cilt altı), orta (meme dokusunun ortası), derin (göğüs duvarına yakın).
- **Muayene paterni:** En etkili olanı **dikey şeritler** (çim biçer gibi yukarı-aşağı); alternatif: dairesel (dıştan meme başına doğru) veya saat yönünde radyal.
- **Sınırlar:** Yukarıda **köprücük kemiği**, aşağıda **meme altı kıvrımı**, içte **göğüs kemiği (sternum)**, dışta **koltuk altı orta çizgisi** — **koltuk altı** ve memenin **üst-dış kadranından koltuk altına uzanan kuyruk kısmı** mutlaka muayene edilir (tümörler en sık **üst dış kadranda** görülür).
- **Meme başı:** Gözle değerlendir; kendiliğinden gelen akıntı önemlidir (rutin sıkmaya gerek yoktur).
- Aynı işlem diğer meme için tekrarlanır.

Bulgu olursa: Panik yapmadan, **beklemeden** ASM'ye/KETEM'e başvurulmalı. Memedeki kitlelerin çoğu iyi huyludur, ancak değerlendirme hekim tarafından yapılmalıdır.

> **Eğitim ipucu:** KKMM'yi **meme maketi** üzerinde göster, sonra kadından **maket üzerinde ya da giyinik olarak kendi üzerinde pozisyonları göstermesini** iste (geri gösterim/teach-back). Değerlendirmeyi basamak kontrol listesiyle yap ("8 basamaktan 7'si doğru").

3.4 Klinik meme muayenesi ve mamografi

- **KMM:** Sağlık profesyoneli tarafından yapılan muayene (hekim/eğitimli hemşire-ebe).

- **Mamografi hazırlığı:** O gün koltuk altı ve memelere **deodorant, pudra, krem sürülmemeli** (kalsifikasyon gibi görünebilir); mümkünse adetten sonraki hafta (daha az ağrılı); önceki mamografiler getirilir; meme protezi/implant varsa bildirilir; kısa süreli sıkıştırma hissi olacağı anlatılır.

---

4. Serviks (rahim ağzı) kanseri

4.1 Bilmen gerekenler

- Neredeyse tüm serviks kanserlerinin nedeni **yüksek riskli HPV** (özellikle tip **16 ve 18**) enfeksiyonudur. Enfeksiyon çoğunlukla kendiliğinden geçer; **kalıcı enfeksiyon** yıllar içinde öncü lezyon ve kansere ilerleyebilir → bu yüzden tarama ile **öncü lezyon aşamasında** yakalanıp tedavi edilebilir; **önlenebilir bir kanserdir**.
- **Risk faktörleri:** Erken yaşta cinsel ilişki, çok sayıda eş (kendisinin veya eşinin), **sigara**, bağışıklık sistemi baskılanması (HIV vb.), çok doğum, uzun süreli oral kontraseptif kullanımı, cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar, **taramaya hiç katılmamış olmak**.
- **Korunma: HPV aşısı** (birincil koruma), **düzenli tarama** (ikincil koruma), kondom kullanımı (riski azaltır), sigarayı bırakma.
- **Uyarı belirtileri: İlişki sonrası kanama**, adet dışı ya da **menopoz sonrası kanama**, kötü kokulu/kanlı akıntı, kasık-pelvik ağrı.

4.2 HPV-DNA / smear öncesi hazırlık (kadına anlat)

- **48 saat öncesinden**: cinsel ilişki, **vajinal duş**, tampon, vajinal ilaç/krem/fitil **kullanılmamalı**.
- **Adet kanaması sırasında alınmaz**; adet bittikten birkaç gün sonra uygun bir gün seçilir.
- İşlemden önce mesane boşaltılır.
- İşlem **kısa sürer, genellikle ağrısızdır**; hafif bir rahatsızlık ve sonrasında hafif lekelenme olabilir.

4.3 Örnek alma sırasında hemşirenin rolü

1. Hedef yaş ve son tarama tarihini kontrol et; davet et, hazırlık talimatı ver.
2. Kadını karşıla, kimlik, işlemi anlat, **kaygısını azalt**, onam al.
3. **Mahremiyet:** Kapı kapalı, paravan, örtü; tercihen kadın sağlık çalışanı; istenirse refakatçi.
4. Malzeme: Uygun boy **spekulum**, **servikal fırça (cytobrush)/spatula**, **sıvı bazlı sitoloji tüpü** (ya da lam + fiksatif), eldiven, ışık, etiket, istem formu.
5. **Litotomi pozisyonu**; ılık spekulum, işlem sırasında ne yapıldığını açıklama, nefes egzersizi.
6. Alınan örneğin **hemen ve doğru etiketlenmesi**, formun eksiksiz doldurulması, laboratuvara uygun koşulda gönderilmesi.
7. İşlem sonrası: Sonucun nasıl/ne zaman öğrenileceğini söyle; **sonucun takibi** ve gerekirse ileri tetkike (kolposkopi) yönlendirme.

- Genel takip: **HPV negatif → 5 yıl sonra tekrar tarama**; HPV pozitif → sitoloji/genotip sonucuna göre hekim/KETEM ileri değerlendirme planlar.

---

5. Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri

5.1 Bilmen gerekenler

- Kadın ve erkekte sık görülen kanserlerden; çoğu **poliplerden** yıllar içinde gelişir → polipler taramayla yakalanıp alınabilir.

- **Risk faktörleri: 50 yaş üstü**, ailede kolorektal kanser/polip öyküsü, kişide polip ya da **inflamatuvar bağırsak hastalığı** (ülseratif kolit, Crohn), **kırmızı ve işlenmiş et** ağırlıklı beslenme, **düşük lif**, **obezite**, **hareketsizlik**, **sigara, alkol**, tip 2 diyabet.
- **Koruyucu:** Lifli beslenme (sebze, meyve, tam tahıl, baklagil), fiziksel aktivite, sağlıklı kilo, işlenmiş eti sınırlama, sigara-alkolden uzak durma, tarama.
- **Uyarı belirtileri: Dışkılama alışkanlığında değişiklik** (ishal-kabızlık), **dışkıda kan/rektal kanama**, siyah dışkı, açıklanamayan **demir eksikliği anemisi**, **kilo kaybı**, karın ağrısı, dışkı çapında incelme, tam boşalamama hissi.

5.2 Gaitada gizli kan testi (GGT) – kit verme ve numune talimatı

> Ülkemizde tarama programında **immünokimyasal** test (FIT/iFOBT) kullanılır; bu test insan kanına özgü olduğu için **özel diyet kısıtlaması gerektirmez**. Yine de kitin üretici talimatına uy.

Kiti verirken anlatacakların (adım adım):

1. Tüpün üzerine **ad-soyad ve numune tarihini** yaz (ya da barkodu kontrol et).
2. Dışkının **idrar ve tuvalet suyuyla karışmaması** için klozet içine temiz bir kâğıt/plastik kap/gazete yerleştir ya da temiz bir kaba dışkıla.
3. Tüpün kapağını çevirerek aç; kapağa bağlı **çubuğu dışkının farklı yerlerine** batır/sürt (çubuğun uç kısmındaki oluklar dışkıyla kaplanacak kadar – fazla almaya gerek yok).
4. Çubuğu tüpe geri yerleştir ve **kapağı sıkıca kapat**; tüpü çalkalama/açma.
5. Numuneyi **en kısa sürede** (kitin önerdiği sürede, genellikle 1–2 gün içinde) ASM'ye getir; o sürede **serin ve güneş almayan bir yerde** sakla.
6. **Numune alınmaması gereken durumlar: Adet kanaması** süresince (ve bitiminden sonraki birkaç gün), **kanayan hemoroid** ya da makattan kanama, idrarda kan olduğunda → numune ertelenir.

Sonuç:

- **Negatif** → 2 yıl sonra tekrar (hedef yaş aralığında).
- **Pozitif** → **kolonoskopiye yönlendirilir.** Kişiye "pozitif sonuç **kanser demek değildir**; polip, hemoroid gibi başka nedenlerle de olabilir, ama mutlaka ileri inceleme gerekir" diye açıkla ve kolonoskopiye gitmesini takip et.

---

6. Diğer kanserlerde erken tanı/farkındalık

Konu	Öneri
Testis kendi muayenesi	Özellikle **15–35 yaş** erkekler, **ayda bir, ılık duştan sonra** (skrotum gevşek); her testis başparmak ile diğer parmaklar arasında nazikçe yuvarlanır; testisin arkasındaki epididim normal yapıdır; **sert kitle, büyüme, ağırlık hissi** → hekime
Cilt kanserleri (ABCDE)	Benlerde **A**simetri, düzensiz **B**ordür (kenar), **C**olor (renk farklılığı), **D**iameter (çap >6 mm), **E**volving (değişim) → hekime. Güneşten korunma: 10.00–16.00 arası güneşe çıkmama, şapka-gözlük, güneş kremi
Prostat	Toplum tabanlı rutin tarama programı yoktur; 50 yaş üstü erkekler (risk varsa daha erken) PSA testinin yarar ve zararları konusunda hekimiyle görüşerek karar verir
Akciğer	En önemli korunma **sigarayı bırakma**; uzun süreli kronik öksürük, kanlı balgam, açıklanamayan kilo kaybı → hekime
Ağız	İyileşmeyen yara, beyaz/kırmızı lekeler; sigara-alkol riski; diş hekimi kontrolü

Kanserin genel uyarı işaretleri

Uzun süren öksürük/ses kısıklığı · Yutma güçlüğü, hazımsızlık · Bağırsak ya da mesane alışkanlığında değişiklik · Olağandışı kanama/akıntı · Memede ya da vücudun başka yerinde kitle · İyileşmeyen yara · Bende/siğilde belirgin değişiklik · Açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk.

Avrupa Kanserle Mücadele Kodu (4. baskı) – 12 öneri (eğitimde kullanılabilir)

1. Sigara/tütün kullanma. 2. Evini ve işyerini dumansız tut. 3. Sağlıklı kiloda ol. 4. Günlük yaşamında fiziksel olarak aktif ol, oturarak geçen süreyi azalt. 5. Sağlıklı beslen (tam tahıl, baklagil, sebze-meyve; yüksek kalorili gıda, şekerli içecek, işlenmiş et ve kırmızı eti sınırla; tuzu azalt). 6. Alkolü sınırla, en iyisi hiç içme. 7. Güneşten korun, solaryuma girme. 8. İşyerinde kanserojen maddelere karşı korun. 9. Evindeki radon düzeyini öğren. 10. Kadınlar için: emzir; hormon replasman tedavisini sınırla. 11. Çocuklarına **Hepatit B** ve **HPV** aşılarını yaptır. 12. **Tarama programlarına katıl** (kolorektal, meme, serviks).

---

7. Kanser tarama eğitimini planlamak (FR.185/23 ve FR.186/13 için)

7.1 Hedef kitleyi doğru seç

- ASM bekleme salonundaki **40–69 yaş kadın** → meme (KKMM + mamografi daveti)
- **30–65 yaş kadın** → serviks (HPV taraması)
- **50–70 yaş kadın ve erkek** → kolorektal (GGT kiti)
- Gençler/hedef yaş dışı → KKMM/TKM farkındalığı, HPV aşısı, kanserden korunma (yaşam tarzı)

7.2 Önerilen eğitim akışı (bireysel, 8–12 dk)

1. **Tanışma ve gereksinim belirleme (1–2 dk):** "Daha önce mamografi/smear/gaitada gizli kan testi yaptırdınız mı? En son ne zaman?" (→ ön değerlendirme, Omaha Bilgi-Davranış puanı)
2. **Bilgi (3–4 dk):** Kanserin önemi, risk faktörleri, erken tanının yaşam kurtardığı, ulusal programın kimleri ne sıklıkla taradığı, ücretsiz olduğu, nereye başvurulacağı.
3. **Beceri (3–4 dk):** KKMM'yi maket üzerinde gösterme → kişiye yaptırma; ya da GGT kitinin kullanımını gösterme.
4. **Engelleri konuşma (1–2 dk):** Korku, utanç, "bende belirti yok", zaman, ulaşım → çözüm (randevu ayarlama, aynı gün kit verme, kadın sağlık çalışanı).
5. **Değerlendirme ve kapanış (1 dk):** Soru-cevap, geri gösterim, **eyleme dönüştürme** (kit aldı mı, randevu aldı mı?) → Omaha'ya kayıt.

7.3 Materyal önerileri

- **Meme maketi** (en etkili materyal)
- Tek sayfalık, büyük puntolu, resimli **broşür** (KKMM basamakları resimli)
- GGT kiti örneği
- "Hangi tarama kime, ne sıklıkla?" tablolu **mini poster/kart**

7.4 Değerlendirme yöntemleri

- KKMM için **basamak kontrol listesi** ile geri gösterim
- 3–5 soruluk **ön test – son test** (ör. "Meme kanseri taraması hangi yaşlarda yapılır?")
- **Davranış çıktısı:** Kit alan/mamografi randevusu alan/HPV testine yönlendirilen kişi sayısı

> Örnek eğitim planı ve Omaha kaydı için: Bölüm 11 ve Bölüm 09.

---

8. Kendini test et

1. Türkiye'de ulusal taraması olan 3 kanser hangisi; hedef yaşlar ve sıklıklar nedir?
2. KKMM ne zaman yapılır? Menopozdaki kadın ne zaman yapmalı?
3. KKMM'de inspeksiyonun 4 pozisyonu nedir? Palpasyonda hangi parmak bölümü, kaç basınç düzeyi, hangi patern kullanılır?
4. Meme tümörleri en sık hangi kadranda görülür?
5. HPV testi/smear öncesi kadına hangi hazırlık talimatlarını verirsin?
6. GGT kitinin kullanımını adım adım anlat. Hangi durumlarda numune alınmaz?
7. GGT pozitif çıkan kişiye ne söylersin?
8. Avrupa Kanserle Mücadele Kodu'ndan 6 öneri say.

09 – OMAHA Sınıflama Sistemi

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 9 (sağlık eğitimleri ve ASM uygulamalarında Omaha kullanma) · FR.186 madde 14 (ASM eğitimlerinde Omaha – **8 puan**) ve madde 19 (okul eğitimlerinde Omaha – **5 puan**)

> FR.186'daki tanım, Omaha'yı nasıl yazman gerektiğini söylüyor: "**Omaha sınıflama listesi ile problemin tanımı, hedef ve kategoriler, hemşirelik girişimleri ve girişimler ile problemin değerlendirilmesi.**" Yani her eğitim/izlem için: **(1) Problem → (2) Girişim (kategori + hedef) → (3) Değerlendirme (Bilgi-Davranış-Durum)** yazacaksın.

---

1. Omaha Sistemi nedir?

- ABD'de **Omaha Ziyaretçi Hemşireler Derneği** tarafından toplum/halk sağlığı hemşireliği uygulamaları için geliştirilmiş, **araştırmaya dayalı, standart bir sınıflama sistemidir** (Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmıştır).
- **Birey, aile ve toplum** düzeyinde kullanılabilir; ev ziyareti, ASM, okul, işyeri gibi tüm halk sağlığı alanlarına uygundur.
- **Hemşirelik süreciyle ilişkisi:**

Omaha bileşeni	Hemşirelik sürecindeki karşılığı
1. Problem Sınıflama Şeması	Veri toplama ve **tanılama**
2. Girişim Şeması	**Planlama** ve **uygulama**
3. Problem Değerlendirme Ölçeği	**Değerlendirme** (başlangıçta, ara dönemde ve sonda puanlama)

---

2. Bileşen 1 – Problem Sınıflama Şeması

4 alan (domain) – 42 problem. Her problem iki **niteleyici (modifier)** ve **belirti/bulgular** ya da **risk faktörleri** ile tanımlanır.

2.1 Alanlar ve problemler

I. Çevresel Alan (4 problem)

Kişinin/ailenin/toplumun yaşadığı fiziksel ortam ve kaynaklar

1. **Gelir**
2. **Sanitasyon** (temizlik/hijyenik koşullar)
3. **Konut** (yaşam alanı)
4. **Komşuluk/İşyeri güvenliği**

II. Psikososyal Alan (12 problem)

Davranış, duygu, iletişim, ilişkiler ve gelişim örüntüleri 5. Toplumsal kaynaklarla iletişim 6. Sosyal temas (sosyal ilişki) 7. Rol değişikliği 8. Kişilerarası ilişki 9. Manevi (spiritüel) durum 10. Yas 11. **Ruh sağlığı** 12. Cinsellik 13. **Bakım verme/Ebeveynlik** 14. İhmal 15. İstismar 16. **Büyüme ve gelişme**

III. Fizyolojik Alan (18 problem)

Yaşamı sürdüren işlevler ve süreçler 17. İşitme 18. Görme 19. Konuşma ve dil 20. **Ağız sağlığı** 21. Biliş (bilişsel durum) 22. Ağrı 23. Bilinç 24. **Deri (cilt)** 25. Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu 26. **Solunum** 27. **Dolaşım** 28. Sindirim-hidrasyon 29. Bağırsak fonksiyonu 30. Üriner fonksiyon 31. Üreme fonksiyonu 32. **Gebelik** 33. **Doğum sonu (Postpartum)** 34. **Bulaşıcı/Enfeksiyöz durum**

IV. Sağlıkla İlgili Davranışlar Alanı (8 problem)

Sağlığı sürdürme ve geliştirmeye yönelik davranış örüntüleri 35. **Beslenme** 36. Uyku ve dinlenme örüntüsü 37. **Fiziksel aktivite** 38. **Kişisel bakım** 39. **Madde kullanımı** (sigara, alkol, madde) 40. **Aile planlaması** 41. **Sağlık bakımı denetimi** (sağlık hizmetlerini kullanma, koruyucu bakım/taramaları yaptırma, sağlık bakım planına uyum) 42. **İlaç rejimi**

> **Ezber:** "**4 – 12 – 18 – 8 = 42**" (Çevre 4, Psikososyal 12, Fizyolojik 18, Davranış 8). Kalın yazılanlar halk sağlığı uygulamasında en sık kullanacakların. Not: Numaralar burada sayma kolaylığı içindir; Omaha'nın resmi problem kodları farklı olabilir.

2.2 Niteleyiciler (modifiers)

a) Kapsam – Kimin problemi?

- **Birey · Aile · Toplum** (ör. bir sınıf, okul, huzurevi, mahalle)

b) Durum – Problemin düzeyi? | Niteleyici | Ne zaman seçilir? | Ne yazılır? | |---|---|---| | **Sağlığın geliştirilmesi** | Risk ya da belirti yok; kişi bilgisini/davranışını geliştirmek **istiyor** | İlgi/istek ifadesi | | **Potansiyel (Olası)** | Belirti yok ama **risk faktörleri var** | **Risk faktörleri** | | **Gerçek (Mevcut)** | Bir ya da daha fazla **belirti/bulgu var** | **Belirti/bulgular** (Omaha listesinden) |

2.3 Belirti/bulgu örnekleri (Omaha listesine benzer ifadeler)

Problem	Örnek belirti/bulgular
Dolaşım	Anormal kan basıncı değerleri, ödem, göğüs ağrısı, nabız düzensizliği
Beslenme	Boya göre ağırlık normalin üstünde/altında, dengesiz beslenme, önerilen beslenme planına uymama, hiperglisemi/hipoglisemi
Fiziksel aktivite	Sedanter yaşam biçimi, yaşa/sağlık durumuna uygun olmayan egzersiz türü/miktarı
Sağlık bakımı denetimi	Rutin/koruyucu sağlık bakımını (tarama, izlem) almıyor, tedavi planına uymuyor, belirtileri değerlendirmiyor
İlaç rejimi	Önerilen dozu/takvimi izlemiyor, yan etkileri tanımıyor, ilaçları uygun saklamıyor
Madde kullanımı	Sigara/tütün kullanıyor, alkol kötüye kullanımı
Ağız sağlığı	Çürük, diş eti kanaması, ağız bakımını yetersiz yapıyor
Bakım verme/ebeveynlik	Çocuğun fiziksel/duygusal gereksinimlerini karşılamada güçlük, yaşa uygun beklentiler konusunda bilgi eksikliği
Doğum sonu	Emzirmede güçlük, doğum sonu değişikliklerle baş etmede güçlük, anormal kanama/akıntı
Bulaşıcı/enfeksiyöz durum	Ateş, enfeksiyon, (potansiyelde risk faktörü: yetersiz el hijyeni, aşı eksikliği)
Konut	Kaygan halılar, yetersiz aydınlatma, güvensiz merdiven, dağınık yaşam alanı

3. Bileşen 2 – Girişim Şeması

Girişim = Kategori + Hedef (target) + Bireye özgü bilgi

3.1 Dört kategori

Kategori	Ne içerir?	Örnek
1. Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık	Bilgi verme, beceri öğretme, karar vermeye destek, sorumluluk almayı cesaretlendirme	KKMM'yi öğretme, tuz kısıtlamasını anlatma
2. Tedaviler ve işlemler	Belirti/bulguları ve risk faktörlerini önlemeye, azaltmaya yönelik teknik hemşirelik uygulamaları	Aşı yapma, pansuman, enjeksiyon, kan şekeri ölçümü (tedavi amacıyla), emzirmede kavramayı düzeltme
3. Vaka yönetimi	Koordinasyon, savunuculuk, sevk/yönlendirme, kaynak bulma	Hekime/KETEM'e/diyetisyene yönlendirme, randevu alma, sosyal hizmete bağlama
4. Gözetim (Sürveyans/ İzlem)	Belirli durumu/ilerlemeyi izlemek için ölçme, gözlem, değerlendirme	KB'yi izleme, bebeğin kilo alımını izleme, bir sonraki ziyarette KKMM yapıp yapmadığını kontrol

3.2 Halk sağlığında en sık kullanılan hedefler (toplam 75 hedef vardır)

Hedef (Türkçe)	(İngilizce)	Kullanım örneği
Anatomi/fizyoloji	anatomy/physiology	Meme yapısı, süt yapımı
Davranış değişikliği	behavior modification	Sigara bırakma planı
Bağlanma	bonding/attachment	Anne-bebek etkileşimi
Bakım verme/ebeveynlik becerileri	caretaking/parenting skills	Bebek bakımı, banyo
Baş etme becerileri	coping skills	Kronik hastalıkla yaşam
Diyet yönetimi	dietary management	Tuz, şeker, kalori
Pansuman/yara bakımı	dressing change/wound care	Diyabetik ayak yarası
Egzersizler	exercises	Yürüyüş, Kegel, denge
Aile planlaması bakımı	family planning care	Doğum sonu yöntem
Besleme işlemleri	feeding procedures	Emzirme tekniği, ek gıda
Genetik	genetics	Aile öyküsü
Büyüme/gelişim bakımı	growth/development care	Persentil, kilometre taşları
Enfeksiyondan korunma önlemleri	infection precautions	El yıkama
Laboratuvar bulguları	laboratory findings	HbA1c, Hb
Tıbbi/dental bakım	medical/dental care	Hekime, diş hekimine yönlendirme
İlaç etkileri/yan etkileri	medication action/side effects	Demir, antihipertansif
İlaç uygulama	medication administration	İnsülin, inhaler
İlaç düzenleme/hazırlama	medication set-up	Haftalık ilaç kutusu
Hareketlilik/transfer	mobility/transfers	Yaşlıda yataktan kalkma
Diyetisyen bakımı	nutritionist care	Diyetisyene yönlendirme
Diğer toplum kaynakları	other community resources	KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezi
Kişisel hijyen	personal hygiene	Perine hijyeni, diş fırçalama
Gevşeme/solunum teknikleri	relaxation/breathing techniques	Stres, KOAH
Dinlenme/uyku	rest/sleep	Uyku hijyeni

Hedef (Türkçe)	(İngilizce)	Kullanım örneği
Güvenlik	safety	Kaza önleme, düşme
Tarama işlemleri	screening procedures	Mamografi, HPV, GGT, KKMM
Hastalık/yaralanma bakımı	sickness/injury care	Ateşli çocukta bakım
Belirti/bulgular – zihinsel/duygusal	signs/symptoms-mental/emotional	Doğum sonu depresyon belirtileri
Belirti/bulgular – fiziksel	signs/symptoms-physical	Gebelikte tehlike belirtileri, KB
Cilt bakımı	skin care	Bası yarası önleme
Örnek (numune) toplama	specimen collection	GGT numunesi
Uyarılma/besleyici bakım	stimulation/nurturance	Bebeğin gelişimini destekleme
Stres yönetimi	stress management	Öğretmenlerde stres
Madde kullanımını bırakma	substance use cessation	Sigara bırakma
Malzemeler	supplies	Sabun, kâğıt havlu temini
Destek grubu / Destek sistemi	support group / support system	Emzirme destek grubu, aile desteği
İyilik hali	wellness	Sağlıklı yaşam

4. Bileşen 3 – Problem Değerlendirme Ölçeği (Sonuçlar için)

Her problem **üç boyutta**, **1–5 arası** (Likert) puanlanır. 1 en olumsuz, 5 en olumlu.

Puan	Bilgi (Kişinin bilgiyi hatırlama ve yorumlama yeteneği)	Davranış (Duruma/amaca uygun gözlenebilir yanıt ve eylemler)	Durum (Belirti/bulgular açısından kişinin hali)
1	Bilgisi yok	Hiç uygun değil	Aşırı/çok ciddi belirti-bulgu
2	Az (minimal) bilgi	Nadiren uygun	Ciddi belirti-bulgu
3	Temel bilgi	Tutarsız (bazen uygun)	Orta düzeyde belirti-bulgu
4	Yeterli bilgi	Genellikle uygun	Az (minimal) belirti-bulgu
5	Üstün (çok iyi) bilgi	Sürekli (her zaman) uygun	Belirti-bulgu yok

- **Ne zaman puanlanır? Başlangıçta** (ilk görüşme/eğitim öncesi), **ara değerlendirmede** ve **sonda** (eğitim/izlem bitiminde ya da sonraki ziyarette). İstenirse **hedeflenen (beklenen) puan** da yazılır.
- **Nasıl karar veririm?**
  - **Bilgi:** Ön test/soru-cevap ile (ör. 5 sorudan 1 doğru → 2; 5'te 5 → 5)
  - **Davranış:** Gözlem ya da beyan ile (ör. "KKMM'yi hiç yapmamış" → 1; "yaptığını gösterdi ama ayda bir yapmıyor" → 3)
  - **Durum:** Belirti/bulguların şiddeti (ör. KB 165/100 → 2; 145/92 → 3; 132/84 → 4)
- **Davranış ölçümü için zaman gerekir:** Tek oturumluk eğitimde davranışı "eğitim sırasında gösterdiği uygulama" ya da "kişinin niyet/plan beyanı" ile değerlendirebilir; **bir sonraki ziyarette** gerçek davranışı kontrol edersin (Gözetim kategorisi).

5. Omaha kayıt şablonu (her eğitim/izlem için doldur)

```
OMAHA KAYIT FORMU                    Tarih: ____   Yer: ASM / Okul / Kurum
Birey/Grup: (baş harfler, yaş, cinsiyet ya da grup tanımı)

1) PROBLEM
   Alan        : _____________________ (Çevresel / Psikososyal / Fizyolojik / Sağlıkla ilgili
davranışlar)
   Problem     : _____________________
   Kapsam      : Birey / Aile / Toplum
   Durum       : Sağlığın geliştirilmesi / Potansiyel / Gerçek
   Belirti-bulgular (gerçek) ya da risk faktörleri (potansiyel):
     - ...
     - ...

2) GİRİŞİMLER (Kategori – Hedef – Bireye özgü bilgi)
   Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – [hedef] – ne anlatıldı/öğretildi
   Tedaviler ve işlemler                    – [hedef] – ne uygulandı
   Vaka yönetimi                           – [hedef] – nereye/kime yönlendirildi
   Gözetim                                 – [hedef] – neyi, ne zaman izleyeceksin

3) PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
              Başlangıç   Son (eğitim sonrası/sonraki ziyaret)   Hedef
   Bilgi        __              __                                __
   Davranış     __              __                                __
   Durum        __              __                                __
   Açıklama: (puanları neye dayanarak verdin? ön-son test, geri gösterim, ölçüm)
```

---

6. Doldurulmuş örnekler

Örnek 1 – ASM: Kanser tarama eğitimi (KKMM + mamografi)

Birey: A.Y., 46 yaşında kadın. Hiç KKMM yapmamış, hiç mamografi çektirmemiş; "Bende bir şikâyet yok, gerek yok" diyor. Annesinde 58 yaşında meme kanseri öyküsü var.

Bölüm	İçerik
Alan	Sağlıkla İlgili Davranışlar
Problem	Sağlık bakımı denetimi
Kapsam / Durum	Birey / **Gerçek**
Belirti-bulgular	Rutin/koruyucu sağlık bakımını (meme kanseri taraması) almıyor; KKMM yapmıyor; tarama hakkında yanlış inanç ("şikâyet yoksa gerek yok")
Girişimler	**Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – Tarama işlemleri:** Ulusal meme taraması (40–69 yaş, 2 yılda bir mamografi), KKMM'nin zamanı ve basamakları maket üzerinde gösterildi, kendisine yaptırıldı · **– Anatomi/fizyoloji:** Meme yapısı, kadranlar · **– Belirti/bulgular–fiziksel:** Meme kanserinin uyarı belirtileri · **Vaka yönetimi – Diğer toplum kaynakları:** KETEM'den mamografi randevusu alındı · **Gözetim – Tarama işlemleri:** 1 ay sonra telefonla/ziyarette KKMM yapıp yapmadığı ve mamografi sonucu kontrol edilecek
Değerlendirme	**Bilgi:** 2 → 4 (ön testte 5 sorudan 1, son testte 4 doğru) · **Davranış:** 1 → 3 (KKMM'yi maket üzerinde 8 basamağın 7'sini doğru gösterdi, mamografi randevusu aldı; düzenli uygulama henüz yok) · **Durum:** 3 → 4 (taramaya yönlendirildi) · **Hedef:** B5 D5 Du5

Örnek 2 – ASM: Hipertansiyonu olan yetişkine tuz kısıtlaması eğitimi

Birey: M.K., 58 yaşında erkek, 3 yıldır HT; KB 156/96 mmHg; ilaçlarını "kendini iyi hissettiğinde" bırakıyor; turşu-salamura tüketiyor, yemeğe tadına bakmadan tuz ekliyor.

Bölüm	İçerik
Problem 1	Fizyolojik alan – **Dolaşım** – Birey – Gerçek. Belirti: Anormal kan basıncı değerleri (156/96)
Problem 2	Sağlıkla ilgili davranışlar – **İlaç rejimi** – Birey – Gerçek. Belirti: Önerilen ilaç takvimine uymuyor
Girişimler	**Sağlık eğitimi – Diyet yönetimi:** Günlük tuz <5 g, gizli tuz kaynakları, etiket okuma, baharatla lezzetlendirme · **– İlaç etkileri/yan etkileri:** İlacın düzenli kullanılma gerekçesi · **– Belirti/bulgular–fiziksel:** Hipertansif acil belirtileri · **Tedaviler ve işlemler – Belirti/bulgular–fiziksel:** Doğru teknikle KB ölçümü · **Vaka yönetimi – Tıbbi bakım:** Hekime bilgi verildi; **– Diyetisyen bakımı / Diğer toplum kaynakları:** Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi · **Gözetim – Belirti/bulgular–fiziksel:** 2 hafta sonra KB kontrolü; ilaç uyumu takibi
Değerlendirme	**Bilgi:** 2 → 4 · **Davranış:** 2 → 3 (tuzluğu sofradan kaldıracağını, ilaç kutusu kullanacağını söyledi) · **Durum:** 2 → 2 (ilk görüşmede KB değişmez; sonraki izlemde yeniden puanlanacak) · Hedef: B5 D4 Du4

Örnek 3 – Okul: İlkokul 2. sınıfta el hijyeni eğitimi (toplum düzeyi)

Grup: 2-B sınıfı, 28 öğrenci. Gözlem: Teneffüs sonrası öğrencilerin çoğu elini yıkamadan yemek yiyor; tuvalet lavabolarında sabun yok; son 2 haftada sınıfta 6 ishal/üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle devamsızlık.

Bölüm	İçerik
Problem 1	Fizyolojik alan – **Bulaşıcı/Enfeksiyöz durum** – **Toplum** (2-B sınıfı) – **Potansiyel**. Risk faktörleri: Yetersiz el hijyeni, kalabalık sınıf, sabun bulunmaması
Problem 2	Çevresel alan – **Sanitasyon** – Toplum (okul) – Gerçek. Belirti: Tuvalet lavabolarında sabun ve kâğıt havlu yok
Girişimler	**Sağlık eğitimi – Enfeksiyondan korunma önlemleri:** El yıkamanın önemi ve zamanları; **– Kişisel hijyen:** 7 adımda el yıkama (şarkı eşliğinde 20 sn), ultraviyole/boya ile "mikrop" gösterimi · **Tedaviler ve işlemler – Enfeksiyondan korunma önlemleri:** Her öğrenciye uygulamalı el yıkama yaptırıldı · **Vaka yönetimi – Malzemeler:** Okul idaresiyle görüşülerek lavabolara sıvı sabun ve kâğıt havlu konuldu · **Gözetim – Enfeksiyondan korunma önlemleri:** 1 hafta sonra teneffüs sonrası el yıkama gözlemi; devamsızlık sayısının izlenmesi
Değerlendirme (grup)	**Bilgi:** 2 → 4 (el yıkama zamanlarını sorduğumuzda öğrencilerin çoğu doğru cevapladı) · **Davranış:** 2 → 4 (28 öğrencinin 24'ü 7 adımı doğru uyguladı) · **Durum:** 3 → 4 · Sanitasyon durumu: 2 → 5 (sabun sağlandı)

Örnek 4 – Bebek/lohusa izlemi: Emzirmede güçlük

Birey: Z.T., 24 yaşında, ilk doğum, 6. gün. Meme başlarında çatlak ve ağrı; bebek her emzirmede 5 dk sonra bırakıyor; "sütüm yetmiyor" diyerek 2 gündür mama eklemiş.

Bölüm	İçerik
Problem	Fizyolojik alan – **Doğum sonu** – Birey – Gerçek. Belirti: Emzirmede güçlük, meme başı çatlakları, ağrı
Girişimler	**Sağlık eğitimi – Besleme işlemleri:** Doğru tutuş ve kavrama belirtileri, sık emzirme · **– Anatomi/fizyoloji:** Süt yapımı (arz-talep), yeterli süt belirtileri · **Tedaviler ve işlemler – Besleme işlemleri:** Emzirme sırasında kavrama düzeltildi; **– Cilt bakımı:** Emzirme sonrası sütü meme başına sürüp kurutma · **Vaka yönetimi – Destek grubu:** Emzirme danışmanına yönlendirme · **Gözetim – Büyüme/gelişim bakımı:** 15. gün izleminde bebeğin kilo alımı; **– Besleme işlemleri:** emzirme gözlemi
Değerlendirme	**Bilgi:** 2 → 4 · **Davranış:** 2 → 4 (doğru kavramayı sağladı, 4 bulgunun 4'ü gözlendi) · **Durum:** 2 → 3 (ağrı azaldı, çatlaklar iyileşmede) · 15. gün: bebek doğum ağırlığına ulaştı → Durum 4

Örnek 5 – Yaşlı izlemi: Düşme riski

Birey: H.D., 78 yaşında kadın, yalnız yaşıyor; son 6 ayda 1 kez düşmüş; Kalk ve Yürü testi 16 sn; evde kaygan halılar, koridorda aydınlatma yetersiz; 6 farklı ilaç kullanıyor.

Bölüm	İçerik
Problem 1	Fizyolojik – **Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu** – Birey – Gerçek. Belirti: Denge bozukluğu, yürüme güçlüğü, düşme öyküsü
Problem 2	Çevresel – **Konut** – Birey – Gerçek. Belirti: Kaygan halılar, yetersiz aydınlatma
Problem 3	Sağlıkla ilgili davranışlar – **İlaç rejimi** – Birey – Potansiyel. Risk faktörü: 6 ilaç (polifarmasi)
Girişimler	**Sağlık eğitimi – Güvenlik:** Ev düzenlemesi (halıları kaldırma, gece lambası, banyoya tutunma barı); **– Egzersizler:** Denge-kuvvet egzersizleri; yataktan yavaş kalkma · **Vaka yönetimi – Tıbbi bakım:** İlaçların gözden geçirilmesi için hekime bildirim; **– Dayanıklı tıbbi ekipman:** Baston/tutunma barı temini; **– Destek sistemi:** Komşu/yakın ile günlük iletişim · **Gözetim – Güvenlik:** 2 hafta sonra ev ziyaretinde düzenlemeler kontrol edilecek
Değerlendirme	**Bilgi:** 2 → 4 · **Davranış:** 1 → 3 (halıları kaldırdı, gece lambası henüz yok) · **Durum:** 2 → 3

---

7. Sık yapılan Omaha hataları

1. **Problem yerine tıbbi tanı yazmak:** "Hipertansiyon" ✗ → "Dolaşım – Gerçek – anormal KB değerleri" ✓
2. **Alanı problemle karıştırmak:** "Problem: Fizyolojik" ✗ → Alan: Fizyolojik, Problem: Solunum ✓
3. **Kapsamı yanlış seçmek:** Sınıf eğitimi yapıp "Birey" yazmak → "Toplum" ✓ (aileye yönelik ise "Aile")
4. **"Gerçek" yazıp belirti yazmamak** ya da **"Potansiyel" yazıp risk faktörü yazmamak.**
5. **Kategori yazıp hedef yazmamak:** "Sağlık eğitimi verildi" ✗ → "Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – Diyet yönetimi – tuz <5 g/gün, gizli tuz kaynakları anlatıldı" ✓
6. **Gözetim kategorisini unutmak** → "bir sonraki ziyarette neyi kontrol edeceğim?" sorusunun cevabıdır; mutlaka yaz.
7. **Bilgi-Davranış-Durum puanlarını gerekçesiz vermek** → Her puanın dayanağını (ön/son test, gözlem, ölçüm) yaz.
8. **Sadece başlangıç ya da sadece son puanı yazmak** → Değişimi göstermek için ikisi de gerekli.
9. **Bir eğitim için birden fazla gereksiz problem yazmak** → Eğitimin odağına uygun 1–2 problem yeterli.

---

8. Kendini test et

1. Omaha'nın 3 bileşeni nedir ve hemşirelik sürecinin hangi aşamalarına karşılık gelir?
2. 4 alanın adları ve problem sayıları nedir?
3. Durum niteleyicileri nelerdir? "Potansiyel" seçtiğinde ne yazarsın?
4. Girişim şemasının 4 kategorisini birer örnekle açıkla.
5. Bilgi, Davranış, Durum ölçeklerinde 1 ve 5 neyi ifade eder?
6. Bir sınıfa diş fırçalama eğitimi verdin. Omaha kaydını yaz. (İpucu: Fizyolojik – Ağız sağlığı – Toplum; hedef: Kişisel hijyen / Tıbbi-dental bakım)
7. Sigara içen gebe için problem, kategori ve hedefler neler olabilir? (İpucu: Madde kullanımı + Gebelik; hedef: Madde kullanımını bırakma, Belirti/bulgular–fiziksel)

10 – Hemşirelik Süreci: Sağlık Öyküsü, Tanılama, Planlama, Uygulama, Değerlendirme

Puanlandığı yer: FR.185 madde 11–20 (**40 puan**: veri toplama-tanılama 16, planlama 12, uygulama 4, değerlendirme 8) · FR.184 beceri 8 ("yeterli sağlık öyküsünü alabilme ve bireye özgü sağlık eğitimini planlayabilme")

> FR.185'te her basamak **ayrı ayrı 4 puan**. Bir bakım planında "etiyoloji" ya da "tanımlayıcı özellikler" bölümünü boş bırakmak, sonuç kriterini ölçülemez yazmak ya da değerlendirmeden sonra yeniden planlama yapmamak doğrudan puan kaybıdır.

1. Madde madde ne bekleniyor?

Madde	Beklenti	Kontrol sorusu
11 Tüm veri kaynaklarını kullanarak bütüncül ve sistematik veri toplama	Birey + aile + kayıtlar (AHBS, e-Nabız, izlem kartı) + sağlık ekibi + gözlem + fizik muayene + ölçekler; bir model çerçevesinde (Gordon, Omaha vb.)	Fiziksel, psikososyal, çevresel, davranışsal tüm boyutları topladım mı?
12 Objektif ve subjektif veriler doğrultusunda öncelik sırasına göre yeterli sayıda uygun tanı	NANDA-I tanıları; **en az 3–5 tanı**, öncelikli olan başta	Tanılarım verilerden mi çıkıyor? Sıralamam gerekçeli mi?
13 Tanı etiyolojisini/ilişkili faktörleri belirleme	"... ile ilişkili" bölümü; hemşirelik girişimiyle değiştirilebilir neden	Etiyoloji tıbbi tanı mı? (olmamalı)
14 Tanımlayıcı özellikleri belirleme	"... ile kendini gösteren" bölümü; subjektif + objektif veriler	Verilerimden alıntı yaptım mı?
15 Amaçları belirleme	Her tanı için genel amaç	Amaç bireye mi ait?
16 Sonuç kriterlerini belirleme	Ölçülebilir, gözlenebilir, zaman sınırlı (SMART)	Kriteri biri gözlemleyip "oldu/olmadı" diyebilir mi?
17 Bireye özgü bakım girişimleri	Gerekçeli, bireyin yaşı, kültürü, okuryazarlığı, kaynaklarına uygun	Kitaptaki kalıp mı, bu kişiye mi özgü?
18 Girişimleri öncelik sırasına göre uygulama	Hayati/acil → güvenlik → bireyin önceliği	Önce neyi, neden yaptım?
19 Sonuç kriterlerine göre değerlendirme	Her kriter için: ulaşıldı / kısmen / ulaşılmadı + kanıt	Kanıtım (ölçüm, gözlem, ifade) var mı?
20 Değerlendirme sonucuna göre yeniden planlama	Ulaşılamayan/kısmen ulaşılan kriterler için neden analizi ve revize plan	Planı değiştirdim mi, devam mı, sonlandırma mı?

2. Veri toplama ve sağlık öyküsü alma

2.1 Veri türleri ve kaynakları

	Tanım	Örnek
Subjektif veri	Bireyin ifadeleri, duyguları, algıları ("..." tırnak içinde yaz)	"Tuzsuz yemek boğazımdan geçmiyor."
Objektif veri	Gözlem, ölçüm, muayene, test sonucu	KB 156/96 mmHg, BKİ 31,2
Birincil kaynak	Bireyin kendisi	
İkincil kaynak	Aile, kayıtlar (AHBS, e-Nabız, izlem kartı, aşı kartı), sağlık ekibi, literatür	

Yöntemler: Görüşme (öykü), gözlem, fizik muayene (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon), ölçümler, ölçekler, kayıt inceleme, ev ziyareti.

2.2 Kapsamlı sağlık öyküsü – başlıklar (FR.184/8 için)

1. **Tanıtıcı bilgiler:** Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, meslek/çalışma durumu, sosyal güvence, ailede yaşayanlar, dil.
2. **Başvuru nedeni / güncel yakınma:** Kendi ifadesiyle; başlangıç, süre, şiddet, artıran-azaltan etkenler.
3. **Mevcut sağlık durumu:** Kronik hastalıklar, kullandığı ilaçlar (reçeteli, reçetesiz, bitkisel), uyum, yan etkiler, alerjiler.
4. **Geçmiş sağlık öyküsü:** Geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, yaralanmalar, hastane yatışları, kadınlarda obstetrik öykü (G-P-A-Y), menstrüel öykü.
5. **Aile öyküsü:** Birinci derece akrabalarda HT, DM, KVH, kanser, ruhsal hastalık, genetik hastalık (→ **genogram**).
6. **Yaşam tarzı:** Beslenme (24 saatlik besin tüketimi), fiziksel aktivite, uyku, sigara (paket-yıl = günlük paket × yıl), alkol, madde, ekran süresi.
7. **Koruyucu sağlık davranışları:** Aşılar (Td, influenza, pnömokok), **kanser taramaları** (son mamografi, HPV/smear, GGT), diş hekimi kontrolü, kendi kendine muayeneler.
8. **Psikososyal durum:** Duygu durumu, stres, baş etme, sosyal destek, aile ilişkileri, ekonomik durum, şiddet (yalnızken, güvenli ortamda).
9. **Çevresel durum:** Konut (ısınma, nem, güvenlik), su ve sanitasyon, mahalle, işyeri riskleri.
10. **Sistemlerin gözden geçirilmesi:** Baştan aşağı her sistem için kısa sorular.
11. **Fonksiyonel durum:** Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık (yaşlıda Katz/Lawton).
12. **Bireyin sağlık algısı, beklentileri ve öğrenme gereksinimi:** "Sağlığınızla ilgili en çok neyi öğrenmek istersiniz?" → **eğitim planının girdisi**.

2.3 Veri toplama modelleri

Gordon'un 11 Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü (bireysel bakım planlarında en sık kullanılan çerçeve)

1. Sağlığı algılama – sağlık yönetimi
2. Beslenme – metabolik
3. Boşaltım
4. Aktivite – egzersiz
5. Uyku – dinlenme
6. Bilişsel – algısal
7. Kendini algılama – benlik kavramı
8. Rol – ilişki
9. Cinsellik – üreme
10. Baş etme – stres toleransı
11. Değer – inanç

Aile değerlendirmesi araçları

- **Aile tipi:** Çekirdek, geniş, tek ebeveynli, parçalanmış/yeniden yapılanmış, çocuksuz çift vb.
- **Duvall'ın aile yaşam döngüsü (8 evre):** (1) Evli çift, (2) Çocuk doğurma (en büyük çocuk 0–30 ay), (3) Okul öncesi çocuklu aile, (4) Okul çağı çocuklu aile, (5) Ergen çocuklu aile, (6) Çocukların evden ayrılması (başlatma), (7) Orta yaş ebeveynler, (8) Yaşlanan aile. Her evrenin **gelişimsel görevleri** vardır (ör. evre 2: bebeğin bakımı, ebeveyn rollerine uyum).
- **Genogram:** En az üç kuşağı gösteren aile ağacı (hastalıklar, ölümler, ilişkiler).

- **Ekokart (eko-harita):** Ailenin çevresel sistemlerle (iş, okul, sağlık kurumu, akrabalar, dini kurum) ilişkilerini gösteren şema; güçlü/zayıf/stresli bağlantılar.
- **Aile APGAR:** **A**daptation (uyum), **P**artnership (paylaşım), **G**rowth (büyüme-gelişme), **A**ffection (sevgi), **R**esolve (birlikte zaman/çözüm) — aile işlevselliği hakkında 5 soruluk hızlı değerlendirme.

Toplum/kurum düzeyi: Toplum Ortaklığı Modeli, Omaha (Bölüm 13, 09).

---

3. Tanılama (NANDA-I)

3.1 Tanı türleri ve yazım biçimi

Tür	Yapı	Örnek
Problem odaklı (gerçek)	**Tanı etiketi + ilişkili faktörler (etiyoloji) + tanımlayıcı özellikler** (PES: Problem–Etiyoloji–Semptom)	"**Etkisiz sağlık yönetimi**; tedavi rejimine ilişkin bilgi eksikliği ve hastalığın ciddiyetini algılamama **ile ilişkili**; antihipertansif ilacını kendini iyi hissettiğinde bırakması, 'Tansiyonum yokken ilaç neden içeyim?' demesi ve KB'nin 156/96 mmHg olması **ile kendini gösteren**"
Risk tanısı	**Tanı etiketi ("... riski") + risk faktörleri** (tanımlayıcı özellik yoktur – henüz sorun yok)	"**Düşme riski**; evde kaygan halılar, yetersiz aydınlatma, 6 ilaç kullanımı ve Kalk ve Yürü testinin 16 sn olması **risk faktörleri ile**"
Sağlığı geliştirme	**Tanı etiketi ("... geliştirmeye hazır oluş") + tanımlayıcı özellikler** (isteğin ifadesi)	"**Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş**; 'Bebeğimi 6 ay sadece emzirmek istiyorum, doğru tuttuğumdan emin olmak istiyorum' demesi **ile kendini gösteren**"
Sendrom	Birbiriyle ilişkili tanı kümeleri	"Yaşlı kırılganlık sendromu"

3.2 Etiyoloji (ilişkili faktörler) yazarken

- Hemşirelik girişimiyle **değiştirilebilir** bir neden olmalı (bilgi eksikliği, inanç, kaynak yetersizliği, beceri eksikliği, çevresel engel).
- **Tıbbi tanı etiyoloji olarak yazılmaz:** "Hipertansiyon ile ilişkili" ✗ → "Tuz kısıtlamasının önemine ilişkin bilgi eksikliği ile ilişkili" ✓
- Etiyoloji ile tanı aynı şey olmamalı: "Bilgi eksikliği ile ilişkili bilgi eksikliği" ✗

3.3 Tanımlayıcı özellikler yazarken

- Topladığın **verilerden** (subjektif → tırnak içinde, objektif → ölçüm) **somut** örnekler yaz.
- En az 2–3 tanımlayıcı özellik; hem subjektif hem objektif olursa güçlü olur.

3.4 Önceliklendirme

1. **Yaşamı tehdit eden** durumlar (hava yolu, solunum, dolaşım – ABC)
2. **Güvenlik** (düşme, yaralanma, enfeksiyon riski)
3. **Maslow** hiyerarşisi: fizyolojik → güvenlik → sevgi-ait olma → saygınlık → kendini gerçekleştirme
4. Bireyin kendi önceliği ve hazır oluşu
5. Diğer tanıların çözümüne katkı (ör. bilgi eksikliği giderilince uyum artar)

3.5 Halk sağlığında sık kullanılan NANDA-I tanıları

> Türkçe çeviriler ve bazı etiketler NANDA-I baskıları arasında değişebilir (ör. "Bilgi eksikliği" yeni baskılarda "Yetersiz sağlık bilgisi"). Kullandığın baskıyı belirt.

Alan	Tanılar
Sağlığı geliştirme	Etkisiz sağlık yönetimi · Sağlık yönetimini geliştirmeye hazır oluş · Etkisiz sağlığı sürdürme davranışları · Riskli sağlık davranışı · Sedanter yaşam biçimi · Etkisiz aile sağlık yönetimi
Bilgi	Bilgi eksikliği (Yetersiz sağlık bilgisi) · Bilgiyi geliştirmeye hazır oluş
Beslenme	Obezite · Fazla kilo · Fazla kilo riski · Dengesiz beslenme: beden gereksiniminden az · **Etkisiz emzirme** · **Kesintili emzirme** · **Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş** · Kararsız kan şekeri düzeyi riski
Boşaltım	Kabızlık · Kabızlık riski · Stres inkontinansı
Aktivite-dinlenme	Uyku örüntüsünde bozulma · Yorgunluk · Fiziksel mobilitede bozulma · Aktivite intoleransı
Rol-ilişki	**Ebeveynlik rolünde bozulma** · Ebeveynliği geliştirmeye hazır oluş · Bağlanmada bozulma riski · **Bakım verici rol gerginliği** · Aile süreçlerinde bozulma
Baş etme	Anksiyete · Etkisiz baş etme · **Etkisiz toplum baş etmesi** · Toplum baş etmesini geliştirmeye hazır oluş
Güvenlik	**Düşme riski** · **Yaralanma riski** · **Enfeksiyon riski** · Kontaminasyon riski · Bası yarası riski
Konfor	Akut ağrı · Kronik ağrı · Sosyal izolasyon
Büyüme-gelişme	Gecikmiş çocuk gelişimi riski · Yaşlı kırılganlık sendromu
Toplum	**Toplum sağlığında yetersizlik** · Etkisiz toplum baş etmesi

4. Planlama

4.1 Amaç ve sonuç kriteri farkı

	Amaç	Sonuç kriteri (beklenen sonuç)
Ne?	Tanının çözümüne yönelik **genel** ifade	Amaca ulaşıldığını gösteren **ölçülebilir, gözlenebilir** davranış/durum
Kime ait?	**Bireye** (hemşireye değil)	Bireye
Örnek	"Bireyin sağlık yönetimi etkili hale gelecek."	"Birey eğitimden sonra gizli tuz içeren 5 besini sayabilecek."

4.2 SMART sonuç kriteri yazma

- **S**pecific (Özgül) · **M**easurable (Ölçülebilir) · **A**chievable (Ulaşılabilir) · **R**ealistic (Gerçekçi) · **T**ime-bound (Zaman sınırlı)
- **Yapı: Kim** + **ne yapacak (ölçülebilir fiil)** + **ne ölçüde/ölçüt** + **hangi koşulda** + **ne zaman**
- **Kullan:** sayar, açıklar, gösterir, uygular, ölçer, ifade eder, … mmHg'nin altında olur, … kg verir
- **Kullanma:** bilir, öğrenir, anlar, farkında olur, kavrar, bilgilenir (ölçülemez!)

✗ Yanlış	✓ Doğru
Hasta tuz kısıtlamasını öğrenecek.	Birey eğitimin sonunda günlük tuz tüketiminin 5 g'ın altında olması gerektiğini ifade edecek.
Hasta ilaçlarını düzenli kullanacak.	Birey 2 hafta sonraki izlemde ilaç kutusunu göstererek 14 günün en az 13'ünde ilacını aldığını gösterecek.
Anne emzirme konusunda bilgilenecek.	Anne bugünkü görüşmede doğru kavramanın 4 belirtisini gösterecek şekilde bebeğini emzirecek.
Tansiyonu düşecek.	Bireyin 1 ay sonraki izlemde ofis KB ölçümü 140/90 mmHg'nin altında olacak.

4.3 Girişimleri yazarken

- **Bağımsız** (hemşirenin kendi kararıyla: eğitim, ölçüm, danışmanlık, izlem), **bağımlı** (hekim istemiyle: ilaç, aşı), **işbirlikçi** (diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet).

- Her girişimin **gerekçesini** yaz (kısa literatür dayanağı) — bu, "bireye özgü ve bilinçli" girişim olduğunu gösterir.
- **Bireye özgüleştir:** Yaşı, okuryazarlığı, kültürü, ekonomik durumu, aile desteği, tercihleri. Örnek: Okuma yazma bilmeyen yaşlıya **resimli** ilaç takvimi; çalışan anneye **süt sağma** planı.

---

5. Uygulama

- Girişimleri **öncelik sırasıyla** uygula ve **kayda geçir** (ne, ne zaman, nasıl, bireyin yanıtı).
- Uygulama sırasında yeni veri çıkarsa (ör. KB 185/112) planı askıya alıp önceliği değiştir ve hekime bildir.

6. Değerlendirme ve yeniden planlama

- Her sonuç kriteri için **kanıtlı** karar: **Ulaşıldı / Kısmen ulaşıldı / Ulaşılmadı**.
- Ulaşılmadıysa **neden?** → Veri eksik miydi? Tanı/etiyoloji doğru muydu? Kriter gerçekçi miydi? Süre yeterli miydi? Girişim bireye uygun muydu? Birey hazır mıydı (transteorik aşama)?
- **Karar:** Planı **sürdür** / **revize et** (yeni girişim, yeni süre) / **sonlandır** (tanı çözüldü).
- **Omaha ile bağlantı:** Bilgi-Davranış-Durum puanlarındaki değişim değerlendirmenin sayısal kanıtıdır.

---

7. Örnek bakım planları

ÖRNEK A – ASM: 58 yaşında hipertansif birey (M.K.)

Veriler (özet): 3 yıldır HT; amlodipin 5 mg reçeteli, "kendimi iyi hissettiğimde içmiyorum" diyor. KB 156/96 ve 152/94 mmHg (ortalama 154/95). BKİ 29,4, bel çevresi 104 cm. Günde ~1 paket sigara (30 paket-yıl). Yemeğe tadına bakmadan tuz ekliyor, her öğün turşu; haftada 1 gün yürüyüş. Okuryazar, emekli, eşiyle yaşıyor; eşi yemekleri yapıyor. "Tansiyon zaten herkeste var" diyor.

Tanı 1 (öncelikli): Etkisiz sağlık yönetimi; tedavi rejimine ve hastalığın olası sonuçlarına ilişkin bilgi eksikliği **ile ilişkili**; ilacını düzensiz kullanması, "Tansiyon zaten herkeste var" demesi, KB'nin 154/95 mmHg olması ve tuzlu beslenmesi **ile kendini gösteren**.

- **Amaç:** Bireyin hipertansiyon yönetimi etkili hale gelecek.
- **Sonuç kriterleri:**
  1. Birey eğitim sonunda hipertansiyonun kontrol edilmediğinde yol açabileceği en az 3 komplikasyonu sayacak.
  2. Birey eğitim sonunda günlük tuz sınırını (<5 g) ve gizli tuz içeren en az 5 besini ifade edecek.
  3. Birey 2 hafta sonraki izlemde ilacını 14 günün en az 13'ünde aldığını ilaç kutusuyla gösterecek.
  4. Bireyin 1 ay sonraki izlemde ortalama KB'si 140/90 mmHg'nin altında olacak.
- **Girişimler ve gerekçeleri:**
  1. Bireyin hastalığa ilişkin bilgi ve inançları açık uçlu sorularla değerlendirildi. *(Gerekçe: Sağlık İnanç Modeline göre algılanan ciddiyet ve duyarlılık uyum davranışını belirler.)*
  2. HT'nin "sessiz" seyri, kalp-beyin-böbrek-göz komplikasyonları resimli kartla anlatıldı.
  3. Tuz kısıtlaması: tuzluğu sofradan kaldırma, turşu-salamura-hazır çorba-ekmek tuzu, etiket okuma, limon-baharat kullanımı anlatıldı; **yemekleri hazırlayan eşi de eğitime dahil edildi.** *(Gerekçe: Tuz kısıtlaması KB'yi düşürür; aile katılımı davranış değişikliğini destekler.)*
  4. Haftalık ilaç kutusu ve telefon alarmı önerildi; ilacın "iyi hissetse de" bırakılmaması gerektiği açıklandı.
  5. Evde KB ölçümü ve kayıt tutma öğretildi; ölçümü geri gösterimle yaptırıldı.
  6. Hipertansif acil belirtileri (şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu) ve 112 anlatıldı.

7. Hekime bilgi verildi; Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyenine yönlendirildi *(işbirlikçi)*.
8. 2 hafta sonra izlem randevusu verildi.

- **Değerlendirme:** (1) Ulaşıldı – inme, kalp krizi, böbrek yetmezliğini saydı. (2) Ulaşıldı – 5 besini saydı. (3) **Kısmen** – 14 günün 11'inde ilaç almış. (4) **Ulaşılmadı** – KB 146/92.
- **Yeniden planlama:** İlaç atlama nedenleri sorgulandı (sabahları aceleyle unutuyor) → ilacın kahvaltı masasına konması ve eşinin hatırlatması planlandı; hekimle KB değerleri paylaşıldı; 2 hafta sonra yeniden izlem; yürüyüşün haftada 5 güne çıkarılması için hedef belirlendi.

Tanı 2: Riskli sağlık davranışı / Sigara kullanımı – bırakmaya isteksizlik (transteorik model: düşünmeme aşaması) → 5A yaklaşımı, kısa motivasyonel görüşme, ALO 171 bilgisi; sonraki izlemde yeniden değerlendirme.

Tanı 3: Sedanter yaşam biçimi – haftada 1 gün yürüyüş ve bel çevresinin 104 cm olması ile kendini gösteren → haftada 150 dk hedefi, kademeli artış planı.

ÖRNEK B – Lohusa izlemi: Etkisiz emzirme (Z.T., 24 yaş, 6. gün)

Veriler: İlk doğum, normal doğum. "Emzirirken çok canım yanıyor", "Sütüm yetmiyor, mama ekledim." Her iki meme başında çatlak; emzirme gözleminde bebeğin yalnızca meme başını kavradığı, alt dudağının içe döndüğü, yanaklarının çukurlaştığı görüldü. Bebek 2 gündür günde 2 kez mama alıyor; günde 5 ıslak bez; doğum ağırlığının %8'ini kaybetmiş.

Tanı: Etkisiz emzirme; emzirme tekniğine (tutuş ve kavrama) ilişkin bilgi ve beceri eksikliği **ile ilişkili**; meme başlarında çatlak ve ağrı, bebeğin yalnızca meme başını kavraması, annenin mama takviyesi yapması ve "Sütüm yetmiyor" demesi **ile kendini gösteren**.

- **Amaç:** Anne etkili biçimde emzirecek.
- **Sonuç kriterleri:**
  1. Anne görüşme sırasında bebeği doğru tutuş ve kavramanın 4 belirtisini gösterecek şekilde emzirecek.
  2. Anne yeterli süt aldığını gösteren 3 belirtiyi ifade edecek.
  3. Anne 15. gün izleminde mama takviyesini bıraktığını ve günde en az 8 kez emzirdiğini ifade edecek.
  4. Bebek 15. gün izleminde doğum ağırlığına ulaşmış olacak.
  5. 15. gün izleminde meme başı çatlakları iyileşmiş olacak.
- **Girişimler:** Emzirme gözlemi; doğru tutuş/kavrama gösterimi ve uygulamada destek; emzirmeye az ağrıyan memeden başlama; emzirme sonrası sütü meme başına sürüp kurutma; arz-talep ilkesi ve sık emzirmenin önemi; yeterli süt belirtileri (ıslak bez, kilo); mama ve biberonun süt üretimine etkisi; eşin/ailenin desteği; gerekirse emzirme danışmanına yönlendirme; 15. gün izlemi.
- **Değerlendirme:** (1) Ulaşıldı (görüşmede 4 belirti gözlendi). (2) Ulaşıldı. (3)–(5) 15. günde değerlendirilecek → 15. gün: mama bırakılmış, bebek doğum ağırlığının 60 g üzerinde, çatlaklar iyileşmiş → **tanı çözüldü**, plan sonlandırıldı; "Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş" ile destek sürdürüldü.

ÖRNEK C – Ev ziyareti/yaşlı izlemi: Düşme riski (H.D., 78 yaş)

Tanı: Düşme riski; son 6 ayda düşme öyküsü, Kalk ve Yürü testinin 16 sn olması, evde kaygan halılar ve yetersiz gece aydınlatması, 6 ilaç kullanımı (biri sedatif) ve yalnız yaşama **risk faktörleri ile**.

- **Amaç:** Bireyin düşme riski azalacak / birey düşmeyecek.
- **Sonuç kriterleri:**
  1. Birey görüşme sonunda evinde düşmeye neden olabilecek en az 4 tehlikeyi ve önlemini ifade edecek.

2. 2 hafta sonraki ev ziyaretinde kaygan halılar kaldırılmış ve yatak odası–tuvalet arasına gece lambası takılmış olacak.
3. Birey yataktan kalkarken önce oturup bekleme davranışını gösterecek.
4. İlaçları 1 ay içinde hekim tarafından gözden geçirilmiş olacak.
5. Birey 3 ay boyunca düşme yaşamayacak.

- **Girişimler:** Ev güvenliği değerlendirmesi (kontrol listesi); düzenleme önerileri; ortostatik hipotansiyon değerlendirmesi ve yavaş kalkma eğitimi; denge-kuvvet egzersizlerinin gösterilmesi; uygun ayakkabı; gözlük kontrolü; polifarmasi için hekime bildirim; telefonun yanında taşınması, komşu/yakınla günlük iletişim; düşerse nasıl kalkacağı; 2 hafta sonra ev ziyareti.
- **Değerlendirme ve yeniden planlama:** Halılar kaldırılmış (ulaşıldı), gece lambası alınmamış (kısmen) → maddi engel saptandı → belediye/sosyal hizmet kaynaklarına yönlendirme; komşusunun yardımı planlandı.

ÖRNEK D – Okul/ergen: Sedanter yaşam biçimi (14 yaş, BKİ ≥95. persentil)

Tanı: Sedanter yaşam biçimi; fiziksel aktivitenin yararlarına ilişkin bilgi eksikliği ve günlük ekran süresinin uzunluğu **ile ilişkili**; "Okuldan gelince bilgisayar başında oturuyorum", günde ~5 saat ekran süresi, haftada 60 dk'dan az fiziksel aktivite ve BKİ'nin yaşına göre 96. persentilde olması **ile kendini gösteren**.

- **Sonuç kriterleri (örnek):** Ergen eğitim sonunda yaşına uygun günlük fiziksel aktivite önerisini (günde en az 60 dk) ifade edecek; 2 hafta boyunca haftada en az 5 gün 30 dk yürüyüş/spor yaptığını aktivite günlüğüyle gösterecek; günlük eğlence amaçlı ekran süresini 2 saate indireceğini planlayacak.
- **Girişimler:** Motivasyonel görüşme; ilgi alanına uygun aktivite seçimi (takım sporu, dans, bisiklet); ailenin katılımı; beden eğitimi öğretmeniyle işbirliği; aktivite günlüğü; olumlu pekiştirme; kilo/yeme üzerine damgalayıcı dil kullanmama.

---

8. Bakım planı şablonu

```
BİREY/AİLE: ______  Yaş: __  Yer: ______  Tarih: ______

VERİ ÖZETİ
  Subjektif: "..."
  Objektif : ...

HEMŞİRELİK TANISI (öncelik sırası: 1)
  [Tanı etiketi]; [etiyoloji/ilişkili faktörler] ile ilişkili;
  [tanımlayıcı özellikler] ile kendini gösteren.

AMAÇ: ...

SONUÇ KRİTERLERİ (SMART)
  1. ...
  2. ...

GİRİŞİMLER                                  GEREKÇE
  1. ...                                     ...
  2. ...                                     ...

UYGULAMA (tarih/saat — ne yapıldı — bireyin yanıtı)

DEĞERLENDİRME
  Kriter 1: Ulaşıldı / Kısmen / Ulaşılmadı — Kanıt: ...
  Kriter 2: ...

YENİDEN PLANLAMA: Sürdür / Revize et (ne değişti?) / Sonlandır
OMAHA BAĞLANTISI: Problem — Bilgi/Davranış/Durum başlangıç → son
```

---

9. Kendini test et

1. Subjektif ve objektif veriye ikişer örnek ver.
2. Gordon'un 11 fonksiyonel sağlık örüntüsünü say.
3. Problem odaklı, risk ve sağlığı geliştirme tanılarının yazım farkları nelerdir?
4. "Hipertansiyon ile ilişkili akut ağrı" ifadesindeki hata nedir?
5. "Hasta diyabet hakkında bilgi sahibi olacak" sonuç kriterini SMART biçimde yeniden yaz.
6. Değerlendirmede kriter "kısmen ulaşıldı" ise ne yaparsın?
7. Duvall'ın aile yaşam döngüsünün 2. evresinin gelişimsel görevleri nelerdir?

11 – Sağlık Eğitimi: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Konu Bankası

Puanlandığı yer: FR.184 beceri 8 (bireye özgü sağlık eğitimi planlama) · FR.185 madde 23 (kanser tarama eğitimi), 24 (çocuk-ergen eğitimi), 25 (yetişkin eğitimi) → **3 × 8 = 24 puan**, her biri **haftada en az 15 kişi** · FR.186 madde 12–13 (ASM'de her saha günü en az 1 genel + 1 kanser tarama eğitimi), 18 (okulda eğitimin uygulanması ve değerlendirilmesi)

> Formların eğitimden beklediği **beş kanıt**: (1) **Sağlık eğitim planı**, (2) **en fazla 2 sayfalık içerik**, (3) **en az 1 materyal**, (4) **fotoğraf**, (5) **eğitimin değerlendirilmesi** (+ Omaha kaydı).

---

1. Temel kavramlar

- **Sağlık eğitimi:** Bireylerin sağlıkla ilgili **bilgi, tutum ve davranışlarında** olumlu değişiklik oluşturmak amacıyla planlı öğrenme deneyimleri sunma süreci.
- **Sağlık okuryazarlığı:** Bireyin sağlık bilgisine **erişme, anlama, değerlendirme ve kullanma** kapasitesi. Türkiye'de yetersiz/sorunlu sağlık okuryazarlığı yaygındır → **sade dil, görsel materyal, öğret-geri al** şart.
- **Hemşirenin eğitici rolü:** Hemşirelik Yönetmeliği'nde tanımlı bağımsız bir işlevdir.

2. Öğrenme alanları ve hedef yazımı (Bloom)

Alan	Neyi kapsar?	Hedef fiilleri	Örnek hedef
Bilişsel	Bilgi, anlama, uygulama, analiz	sayar, tanımlar, açıklar, ayırt eder, örnek verir	"Katılımcı meme kanserinin 4 uyarı belirtisini sayar."
Duyuşsal	Tutum, değer, istek	kabul eder, önemser, niyet belirtir, ifade eder	"Katılımcı mamografi yaptırma niyetini ifade eder."
Psikomotor	Beceri	gösterir, uygular, yapar	"Katılımcı KKMM'yi maket üzerinde doğru basamaklarla gösterir."

> **Kural:** Hedefler **katılımcı açısından** ve **ölçülebilir fiil** ile yazılır. "Öğrenir, bilir, anlar, kavrar, farkında olur" **kullanılmaz**.

3. Yetişkin ve çocuk eğitiminin ilkeleri

3.1 Yetişkin eğitimi (Andragoji – Knowles)

1. Yetişkin **neden öğrenmesi gerektiğini** bilmek ister → konuyu kendi yaşamıyla ilişkilendir.
2. **Deneyimlerini** öğrenmeye katar → "Siz neler yapıyorsunuz?" diye sor.
3. **Sorun odaklı ve hemen kullanılabilir** bilgi ister.
4. **Öz-yönelimlidir**, kararlarına saygı bekler.
5. İçsel motivasyon (sağlıklı olmak, torununu büyütmek) daha güçlüdür.
6. Yaşlıda: yavaş tempo, büyük punto, tekrar, kısa oturum, görme-işitme engellerine dikkat.

3.2 Çocuk ve ergen eğitimi

- **Okul öncesi/ilkokul (somut işlemler dönemi):** Somut, görsel, **oyun, şarkı, kukla, boyama, gösterip yaptırma**; kısa süre (10–20 dk); tek mesaj; ödül-pekiştirme.

- **Ergen (soyut düşünme):** Tartışma, rol oyunu, vaka, akran eğitimi, gerçek yaşam senaryoları; yargısız, öğüt vermeyen dil; mahremiyet; kimlik ve özerklik gereksinimine saygı.

4. Sağlık davranışı modelleri (planlamada gerekçe olarak kullan)

Model	Ana fikir	Eğitimde nasıl kullanırım?
Sağlık İnanç Modeli	Kişi; hastalığa **duyarlılık** ve hastalığın **ciddiyetini** algılarsa, davranışın **yararlarının engellerden** fazla olduğuna inanırsa, **harekete geçirici bir uyaran** olursa ve **öz-etkililiği** yüksekse davranışı yapar	Taramayı yaptırmayan kadında: risk/duyarlılık ("yaşınız ve aile öykünüz"), ciddiyet, yarar (erken tanıda tedavi başarısı), engeller (korku, utanç, ulaşım → çözüm), uyaran (SMS daveti, randevuyu o an alma), öz-etkililik (KKMM'yi yaptırarak güven kazandırma)
Transteorik Model (Davranış Değişikliği Aşamaları)	**Düşünmeme → Düşünme → Hazırlık → Hareket → Sürdürme** (± nüks)	Sigara içen kişinin aşamasını belirle: düşünmeme aşamasındaysa farkındalık; hazırlıktaysa bırakma tarihi ve plan; hareketteyse nüks önleme
Pender'in Sağlığı Geliştirme Modeli	Bireysel özellikler + davranışa özgü bilişler (algılanan yarar, engel, öz-etkililik, kişilerarası/durumsal etkiler) → sağlığı geliştirici davranış	Fiziksel aktivite, beslenme gibi sağlığı geliştirme eğitimlerinde
PRECEDE-PROCEED	Eğitimi **hazırlayıcı** (bilgi, tutum), **kolaylaştırıcı** (kaynak, beceri) ve **pekiştirici** (aile, akran desteği) etkenlere göre planlama	Toplum/okul programlarında (Bölüm 12–13)

5. Yöntem ve materyal seçimi

Yöntem	En uygun olduğu durum
Bireysel görüşme/danışmanlık	ASM'de kişiye özgü gereksinim; hassas konular
Anlatım + soru-cevap	Kısa bilgi aktarımı (bekleme salonu mini eğitimi)
Gösterip yaptırma (demonstrasyon)	**Beceri öğretimi**: KKMM, insülin, inhaler, el yıkama, emzirme
Grup tartışması	Ergen, veli, çalışan grupları
Rol oyunu / vaka	Ergenlerde akran baskısına hayır deme, iletişim
Oyun, şarkı, kukla, boyama	Okul öncesi ve ilkokul
Beyin fırtınası	Toplum/okul gruplarında sorun-çözüm

Materyal	Dikkat
Broşür/el ilanı	Büyük punto (≥12–14), sade dil (kısa cümle, günlük sözcük), bol görsel, tek konu, "ne yapmalı?" odaklı, başvuru bilgisi; **en fazla 2 sayfa**
Poster	Uzaktan okunur başlık, az metin, güçlü görsel
Maket	Meme maketi, diş-fırça maketi, bebek maketi – **beceri öğretiminde en etkili**
Kart/flip chart	Bekleme salonunda küçük gruplar
Gerçek malzeme	GGT kiti, inhaler, tuz ölçüsü (5 g tuzu kaşıkta gösterme), şeker küpü ile içeceklerdeki şeker miktarı
Slayt	Okul/kurum gruplarında; yazıyı azalt, görsel artır

6. Eğitimin uygulanması – 3 aşama

1. **Giriş (%10–15):** Selamlama, kendini tanıtma, **dikkat çekme** (soru, kısa hikâye, şaşırtıcı bilgi), konunun önemi, hedefleri paylaşma, **ön değerlendirme** (ne biliyorlar?).

2. **Gelişme (%70–75):** Ana mesajlar (en fazla 3–5), basitten karmaşığa, görsel/materyal kullanımı, **gösterip yaptırma**, sık sık katılımcıya soru sorma.
3. **Sonuç (%10–15): Özet**, soruları yanıtlama, **son değerlendirme** (soru-cevap/geri gösterim/son test), **eyleme çağrı** ("Bugün randevunuzu alalım"), teşekkür, materyal dağıtımı.

Öğret-geri al (teach-back): "Size doğru anlatıp anlatmadığımı kontrol etmek istiyorum; evde eşinize anlatacak olsanız neler söylerdiniz?" → Yanlış anlaşılanı yeniden anlat.

7. Eğitimin değerlendirilmesi

Düzey	Ne ölçülür?	Nasıl?
Süreç	Eğitim plana uygun yürüdü mü?	Süre, katılım, materyal kullanımı, katılımcı memnuniyeti
Bilgi	Bilgi arttı mı?	**Ön test – son test** (3–5 soru), soru-cevap
Beceri	Beceri kazanıldı mı?	**Geri gösterim** + basamak kontrol listesi
Tutum/niyet	Davranış niyeti oluştu mu?	"Mamografi yaptırmayı düşünüyor musunuz?"
Davranış/sonuç	Davranış değişti mi?	Sonraki izlemde gözlem/kayıt (kit getirdi mi, KB düştü mü)

→ Bu sonuçları **Omaha Bilgi-Davranış-Durum** puanlarına çevir (Bölüm 09).

---

8. Sağlık eğitim planı şablonu

```
SAĞLIK EĞİTİM PLANI
Eğitimin konusu      : ...
Eğitimin türü        : Bireysel / Grup     (Kanser tarama / Çocuk-ergen / Yetişkin / Genel)
Hedef kitle          : ... (yaş, cinsiyet, özellikler, kişi sayısı)
Gereksinim belirleme : Neden bu konu? (gözlem, öykü, ön test, ASM verisi, Omaha problemi)
Yer / Tarih / Süre   : ...
Eğitimi veren        : ...

AMAÇ (genel)         : ...
ÖĞRENME HEDEFLERİ    : Eğitim sonunda katılımcı;
   Bilişsel   : ... sayar / açıklar
   Duyuşsal   : ... niyetini ifade eder
   Psikomotor : ... gösterir / uygular

İÇERİK (ana başlıklar): 1) ... 2) ... 3) ...
YÖNTEM               : Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, ...
MATERYAL             : Broşür, maket, poster, ...
EĞİTİM AKIŞI         : Giriş (… dk) – Gelişme (… dk) – Sonuç (… dk)
DEĞERLENDİRME        : Ön test / son test, geri gösterim (kontrol listesi), soru-cevap
SONUÇ                : Ön test ort. … → son test ort. …; geri gösterimde … / … basamak doğru
OMAHA KAYDI          : Problem – Girişim (kategori + hedef) – Bilgi/Davranış/Durum
KAYNAKLAR            : ...
```

---

9. Doldurulmuş örnek planlar

9.1 Kanser tarama eğitimi – KKMM ve meme kanseri taraması (bireysel)

Başlık	İçerik
Konu	Meme kanseri, KKMM ve ulusal tarama programı

Başlık	İçerik
Hedef kitle	ASM'ye başvuran 40–69 yaş kadın (bireysel)
Gereksinim	Öyküde KKMM yapmıyor, son 2 yılda mamografi yok
Süre	10–12 dk
Amaç	Kadının meme kanseri taramasına katılımını sağlamak
Hedefler	**Bilişsel:** Meme kanseri için 3 risk faktörü ve 4 uyarı belirtisini sayar; ulusal tarama yaşını ve sıklığını söyler (40–69, 2 yılda bir). **Duyuşsal:** Mamografi yaptırma niyetini ifade eder. **Psikomotor:** KKMM'yi maket üzerinde doğru basamaklarla gösterir.
İçerik	(1) Meme kanserinin önemi ve erken tanı (2) Risk faktörleri (3) Uyarı belirtileri (4) Ulusal program – KETEM/ASM, ücretsiz (5) KKMM: zamanı, inspeksiyon 4 pozisyon, palpasyon tekniği (6) Bulgu fark edilirse ne yapmalı
Yöntem	Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma
Materyal	Meme maketi, resimli KKMM broşürü
Akış	Giriş 2 dk (ön soru: "Daha önce mamografi yaptırdınız mı?") → Gelişme 8 dk (maket gösterimi + kadına yaptırma) → Sonuç 2 dk (özet, randevu)
Değerlendirme	4 soruluk ön/son test; 8 basamaklık KKMM kontrol listesi ile geri gösterim; mamografi randevusu alındı mı
Omaha	Sağlık bakımı denetimi – Birey – Gerçek; Sağlık eğitimi–Tarama işlemleri; Vaka yönetimi–Diğer toplum kaynakları (KETEM); Gözetim–Tarama işlemleri

KKMM geri gösterim kontrol listesi (8 basamak): ☐ Doğru zamanı söyledi ☐ Ayna karşısında 4 pozisyonu gösterdi ☐ Bakılacak değişiklikleri saydı ☐ Yatarak/kol başın altında pozisyonu gösterdi ☐ 3 parmak pulpasıyla dairesel hareket ☐ 3 basınç düzeyi ☐ Tüm alanı (koltuk altı dahil) dikey şeritlerle taradı ☐ Bulgu olursa başvuracağı yeri söyledi

9.2 Çocuk eğitimi – El hijyeni (ilkokul 1–2. sınıf / ASM'ye gelen çocuklar)

Başlık	İçerik
Hedefler	El yıkaması gereken 4 zamanı söyler; 7 adımda el yıkamayı uygulamalı gösterir; el yıkamanın 20 saniye sürmesi gerektiğini ifade eder
İçerik	Mikroplar nedir (gözle görülmez), nasıl bulaşır; ne zaman el yıkanır (tuvaletten sonra, yemekten önce, oyundan/teneffüsten sonra, öksürdükten-hapşırdıktan sonra); **7 adım:** ıslat-sabunla → avuç içi → el sırtı → parmak araları → başparmaklar → parmak uçları-tırnaklar → durula, kâğıt havluyla kurula, musluğu havluyla kapat
Yöntem/Materyal	Kısa kukla gösterisi, **el yıkama şarkısı** (20 sn), simli krem/boya ile "mikrop" deneyi, resimli 7 adım posteri, boyama sayfası
Değerlendirme	Her çocuğa lavaboda uygulatma (kontrol listesi), "Ne zaman el yıkarız?" soruları; 1 hafta sonra teneffüs sonrası gözlem

9.3 Ergen eğitimi – Ekran süresi ve dijital denge / Sağlıklı beslenme

Başlık	İçerik
Hedefler	Uzun ekran süresinin 4 sağlık etkisini sayar; kendi ekran süresini hesaplar; ekran süresini azaltmak için kişisel 2 hedef belirler
İçerik	Uyku (mavi ışık), göz yorgunluğu, duruş-boyun ağrısı, hareketsizlik-kilo, dikkat-ders başarısı, siber zorbalık; "yatmadan 1 saat önce ekran yok", bildirimleri kapatma, ekransız aile saatleri, alternatif aktiviteler
Yöntem/Materyal	Grup tartışması, "bir günüm" etkinliği (ekran süresi hesaplama), kısa video/infografik, mini anket
Değerlendirme	Ön-son test, kişisel hedef kartı, 1 hafta sonra ekran süresi raporu (telefon ayarlarından)

9.4 Yetişkin eğitimi – Hipertansiyonda tuz kısıtlaması

Başlık	İçerik
Hedefler	Günlük tuz sınırını (<5 g) söyler; gizli tuz içeren 5 besini sayar; tuzu azaltmak için 3 yöntem açıklar; KB ölçümünü doğru basamaklarla gösterir

Başlık	İçerik
İçerik	Tuz-KB ilişkisi; 5 g tuz = 1 silme çay kaşığı (kaşıkla göster); gizli tuz: ekmek, peynir, zeytin, turşu, salamura, hazır çorba, işlenmiş et, cips, maden suyu; etiket okuma (sodyum × 2,5 ≈ tuz); tuzluğu sofradan kaldırma; limon, sirke, baharat, nane kullanımı; aşamalı azaltma (tat alma 2–3 haftada uyum sağlar)
Yöntem/Materyal	Anlatım, gösterim (tuz kaşığı, besin etiketleri), broşür
Değerlendirme	Soru-cevap, teach-back, sonraki izlemde KB ve beyan

10. "Haftada en az 15 kişi" kuralını kanıtlamak (FR.185/23–25)

> Üç ayrı kategori için **her biri haftada ≥15 kişi**: Kanser tarama · Çocuk-ergen · Yetişkin.

Pratik strateji:

1. **Bekleme salonu mini grup eğitimleri:** 5–10 dk, 3–6 kişilik gruplar; günde 2–3 grup → haftada rahatça 15+.
2. **İzlemlerle birleştir:** Bebek izlemine gelen anneye (yetişkin) emzirme/beslenme; aşıya gelen 13 yaşındaki ergene (çocuk-ergen) Td + ergenlik/sağlıklı beslenme; 40–69 yaş kadın hastaya (kanser tarama) KKMM.
3. **Konu takvimi yap:** Ör. 1. hafta KKMM + el hijyeni + HT/tuz; 2. hafta GGT + diş sağlığı + DM ayak bakımı; 3. hafta HPV taraması + ekran süresi + sigara bırakma...
4. **Her eğitimi aynı gün çizelgeye işle** (Bölüm 01'deki şablon): tarih, tür, konu, baş harfler, yaş, yöntem, materyal, değerlendirme, Omaha no, fotoğraf no.
5. **Fotoğraf:** İzinli, yüzsüz/maskelenmiş; materyal ve eğitim anını gösteren.
6. **Her konunun 2 sayfalık içeriğini** ve planını kanıt dosyasında tut; aynı konu farklı kişilere tekrar edilebilir, plan bir kez hazırlanır, **değerlendirme her kişi için** yapılır.

11. Konu bankası – anahtar mesajlar

11.1 Çocuk ve ergen konuları

Konu	Anahtar mesajlar
El hijyeni	4 kritik zaman; 7 adım; 20 sn; sabun ve akan su; kâğıt havlu
Ağız-diş sağlığı	Günde 2 kez (sabah kahvaltı sonrası, gece yatmadan) en az 2 dk fırçalama; florürlü macun; şekerli/yapışkan besinleri azaltma; diş ipi; 6 ayda bir diş hekimi
Sağlıklı beslenme	Kahvaltı yapma; her gün sebze-meyve (5 porsiyon); şekerli ve gazlı içecek yerine su/ayran; abur cubur ve fast food sınırlama; tabak modeli
Fiziksel aktivite	**Günde en az 60 dk** orta-şiddetli aktivite; haftada 3 gün kas-kemik güçlendirme; oturma süresini bölme
Ekran süresi ve dijital bağımlılık	Eğlence amaçlı ekranı sınırlama (2 saat altı önerilir), yatmadan 1 saat önce ekran yok, yatak odasında telefon yok, siber zorbalığı bildirme
Uyku hijyeni	6–12 yaş 9–12 saat, 13–18 yaş 8–10 saat; düzenli yatış-kalkış
Ergenlik dönemi değişiklikleri	Fiziksel-duygusal değişikliklerin normal olduğu; kişisel hijyen (duş, deodorant, akne bakımı); menstrüel hijyen (ped değişimi 4–6 saatte bir, el yıkama, ağrıda sıcak uygulama)
Akran zorbalığı	Tanıma (fiziksel, sözel, sosyal, siber), güvendiği yetişkine söyleme, seyirci kalmama
Sigara-alkol-madde	Zararları, akran baskısına "hayır" deme becerisi, elektronik sigara da zararlıdır; ALO 191 (madde bağımlılığı danışma hattı) ve ALO 171
Kazalar ve ilk yardım	Trafik (emniyet kemeri, kask), suda boğulma, düşme, yanık; 112; temel ilk yardım
Güneşten korunma	10.00–16.00 arası gölge, şapka, güneş kremi, su

Konu	Anahtar mesajlar
Kişisel güvenlik/istismardan korunma	"Vücudum bana ait", iyi-kötü dokunma, sır tutmama, güvendiği yetişkine anlatma (yaşa uygun)

11.2 Yetişkin konuları

Konu	Anahtar mesajlar
Hipertansiyon	Sessiz katil; düzenli ölçüm; tuz <5 g; ilaç uyumu; yaşam tarzı; acil belirtiler
Diyabet	Belirtiler; HbA1c; diyet; egzersiz; ilaç/insülin; hipoglisemi 15-15; ayak bakımı; yıllık göz-böbrek kontrolü
Sağlıklı beslenme ve obezite	Tabak modeli; porsiyon kontrolü; şeker ve işlenmiş gıdayı azaltma; su; bel çevresi
Fiziksel aktivite	Haftada **150–300 dk orta** ya da **75–150 dk şiddetli** + haftada 2 gün kas güçlendirme; yaşlıda denge
Sigara bırakma	Bırakmanın faydaları (20 dk'da KB-nabız normale yaklaşır; 1 yılda koroner risk yarıya iner); ALO 171; sigara bırakma polikliniği; tetikleyicilerle baş etme
Kanser taramaları	Bölüm 08
Aile planlaması	Yöntemler, doğum aralığı, doğum sonu yöntem, acil kontrasepsiyon
Gebelikte sağlık	İzlemler, tehlike belirtileri, beslenme, demir-D vitamini
Emzirme ve bebek bakımı	Bölüm 05–06
Menopoz ve osteoporoz	Belirtiler ve baş etme; kalsiyum-D vitamini; yük bindiren egzersiz; düşme önleme; sigara-alkol
Akılcı ilaç kullanımı	Antibiyotikler virüslere (grip-soğuk algınlığı) etkisizdir; hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanmama; tedaviyi yarıda bırakmama; ilaçları başkasıyla paylaşmama; artan ilaçları ilaç atık kutusuna
Erişkin aşıları	Td 10 yılda bir; 65 yaş üstü ve kronik hastalarda influenza (her yıl) ve pnömokok
Ruh sağlığı ve stres	Stres belirtileri; gevşeme-nefes egzersizi; uyku; sosyal destek; yardım arama; intihar uyarı işaretleri ve 112
Afete hazırlık	Afet çantası, aile afet planı, toplanma alanı (e-Devlet/AFAD), deprem anında "çök-kapan-tutun"
Gıda güvenliği	Elleri yıkama, çiğ-pişmiş ayrımı, yeterli pişirme, buzdolabında saklama (+4 °C altı)
Yaşlıda düşme önleme	Bölüm 07

---

12. Kendini test et

1. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlar için birer hedef yaz.
2. "Hastalar meme kanserini öğrenecek" hedefindeki hata nedir?
3. Sağlık İnanç Modeli'nin bileşenlerini, mamografi yaptırmayan bir kadın örneğiyle açıkla.
4. Transteorik modelin aşamaları nelerdir? "Düşünmeme" aşamasındaki sigara içicisine ne yaparsın?
5. Bir eğitimin değerlendirmesi hangi düzeylerde yapılabilir?
6. Haftada 15 kişi hedefini 3 kategoride nasıl tutturur ve kanıtlarsın?

12 – Okul Sağlığı Süreci

Puanlandığı yer: FR.186 Okul Sağlığı Süreci (**26 puan**)

- 15 – Okulun **risk değerlendirmesini** yapmak ve buna uygun girişim planlamak (5)
- 16 – **Öğrenci** sağlığına yönelik girişim: tarama, sağlık eğitimi, etkinlik, risk belirleme, kronik hastalıklı öğrenci izlemi – fotoğraf (6)
- 17 – **Okul çalışanlarına** yönelik girişim: tarama, eğitim, risk belirleme, kronik hastalıklı çalışan izlemi – fotoğraf (6)
- 18 – Hazırlanan eğitimin uygulanması: **çalışan ve velilerle iletişim**, zaman-süre belirleme, materyal kullanımı, **eğitimin değerlendirilmesi** (4)
- 19 – Eğitimlerde **Omaha** kullanımı (5)

> Ayrıca profesyonel davranışlar (20 puan) okul sürecinde de ayrıca puanlanıp ASM ve toplum süreciyle ortalaması alınır.

---

1. Okul sağlığı ve okul sağlığı hemşiresi

- **Okul sağlığı:** Öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığını korumak, geliştirmek, sağlık sorunlarını erken saptamak ve sağlıklı bir okul çevresi oluşturmak için yürütülen hizmetlerin bütünü.
- **Neden önemli?** Okul çağı nüfusu toplumun büyük bir kesimidir; bu dönemde kazanılan sağlık davranışları yaşam boyu sürer; okul, aileye ve topluma ulaşmada köprüdür.
- **Okul sağlığı hemşiresinin rolleri:** Bakım verici (ilk yardım, kronik hastalık yönetimi) · Eğitici · Danışman · Savunucu (öğrenci hakları, sağlıklı çevre) · Koordinatör/işbirlikçi (okul idaresi, rehber öğretmen, aile, ASM, belediye) · Vaka yöneticisi · Araştırmacı · Lider/yönetici.

1.1 Okul sağlığı bileşenleri (Bütüncül Okul – WSCC modeli, 10 bileşen)

1. Sağlık eğitimi
2. Beden eğitimi ve fiziksel aktivite
3. Beslenme ortamı ve hizmetleri (kantin, yemekhane)
4. Sağlık hizmetleri (taramalar, ilk yardım, kronik hastalık yönetimi)
5. Danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler
6. Sosyal ve duygusal iklim (zorbalık, aidiyet)
7. Fiziksel çevre (bina, güvenlik, hijyen)
8. Çalışanların sağlığı (personel iyilik hali)
9. Aile katılımı
10. Toplum katılımı

1.2 Türkiye'de okul sağlığıyla ilgili bazı programlar (MEB – Sağlık Bakanlığı işbirliği)

- **Beyaz Bayrak:** Okulların temizlik ve hijyen standartlarını belgelendiren program.
- **Beslenme Dostu Okul:** Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyen okulların belgelendirilmesi.
- **Okulda Diyabet Programı:** Tip 1 diyabetli öğrencilerin okulda güvenli izlenmesi.
- **Okul kantinleri düzenlemeleri:** Sağlıksız gıdaların (enerji içecekleri, gazlı-şekerli içecekler, yüksek tuz/yağ/şeker içeren atıştırmalıklar) satışına yönelik kısıtlamalar.
- ASM/TSM aracılığıyla okul çağı **aşılamaları** (ilkokul 1. sınıf dönemine denk gelen 48. ay aşıları kontrolü, 8. sınıf Td) ve **taramalar**.

---

2. Okul risk değerlendirmesi (FR.186/15)

2.1 Basamaklar

1. **Hazırlık:** Okul idaresinden izin ve randevu; okulun genel bilgileri (öğrenci-öğretmen-personel sayısı, kademe, ikili/tam gün eğitim, kaynaştırma öğrencileri, taşımalı eğitim).
2. **Veri toplama:** Gözlem (kontrol listesi), okul yöneticisi/rehber öğretmen/öğretmenlerle görüşme, kayıt inceleme (revir defteri, kaza kayıtları, devamsızlık nedenleri, kronik hastalıklı öğrenci listesi, aşı durumu), öğrenci/çalışan anketleri, fotoğraf (izinli, öğrenci yüzü olmadan).
3. **Tehlikeleri belirleme** (aşağıdaki kontrol listesi).
4. **Risk puanlama:** Olasılık × Şiddet (5×5 matris).
5. **Önceliklendirme:** Yüksek riskler önce.
6. **Kontrol önlemleri / girişim planı:** Kontrol hiyerarşisine göre, sorumlu ve tarih belirterek.
7. **Raporlama ve okul idaresiyle paylaşma**; uygulama ve izlem.

2.2 Okul risk değerlendirme kontrol listesi

Alan	Kontrol edilecekler (Var/Yok/Uygun değil)
Okul çevresi	Trafik yoğunluğu, yaya geçidi-trafik görevlisi, okul geçidi uyarı levhaları; sanayi, gürültü, hava kirliliği kaynakları; çevrede alkol/tütün satış noktaları; terk edilmiş yapılar, inşaat; başıboş hayvanlar
Bina ve bahçe	Duvar-zemin çatlakları, kaygan zemin, kırık cam, korkuluk yüksekliği ve aralıkları (çocuğun başı geçmeyecek), merdiven kaydırmazları ve küpeşte, bahçe zemini, oyun alanı ekipmanlarının sağlamlığı ve altındaki zemin, bahçe kapısı güvenliği, gölgelik alan
Sınıflar	Sınıf mevcudu ve öğrenci başına alan; **aydınlatma** (yeterli doğal + yapay ışık, ışığın sol taraftan gelmesi), **havalandırma** (pencereler açılabiliyor mu), **ısı** (yaklaşık 20–22 °C), nem, gürültü, sıra-masa boyutlarının öğrenci boyuna uygunluğu, tahtanın parlamaması, priz ve kabloların güvenliği, keskin köşeler, dolapların sabitlenmesi (deprem)
Tuvalet ve lavabolar	Öğrenci sayısına göre yeterlilik, kız/erkek ayrımı, temizlik, **sabun, kâğıt havlu/kurutucu**, akan su (sıcak su), çöp kovası (kız tuvaletinde kapaklı), kapı kilitleri, engelli tuvaleti, koku-havalandırma
Su	Şebeke suyu, su deposu temizliği ve kayıtları, içme suyu kaynakları (sebil/şişe), su analizi
Kantin ve yemekhane	Satılan ürünlerin mevzuata uygunluğu, gıda saklama (buzdolabı ısısı), çalışan hijyeni (bone, önlük, el yıkama), **portör muayeneleri**, haşere kontrolü, bulaşık hijyeni, menüde sebze-meyve
Spor salonu ve laboratuvar	Zemin, ekipman sabitlemesi, ilk yardım; laboratuvarda kimyasal depolama, göz duşu, havalandırma, yangın söndürücü
Yangın ve afet güvenliği	Yangın söndürücülerin dolum tarihi, acil çıkış işaretleri ve aydınlatması, kapıların dışa açılması, kilitli acil çıkış olmaması, tahliye planı ve **tatbikat** kayıtları, toplanma alanı, deprem tatbikatı, sabitlenmemiş eşyalar
Elektrik ve ısınma	Açık kablolar, prizlerin yüksekliği/koruyucusu, sobalı sınıfta karbonmonoksit riski, kalorifer kazan dairesi güvenliği
İlk yardım ve sağlık hizmetleri	**İlk yardım dolabı/çantası** ve içeriği (son kullanma tarihleri), revir/sağlık odası, ilk yardım sertifikalı personel, acil telefon listesi (112, aile), kaza kayıt defteri, **kronik hastalıklı öğrenci listesi** ve bireysel sağlık planları, ilaç uygulama kuralları
Hijyen ve atık	Genel temizlik, çöp konteynerleri, atık ayrıştırma, haşere
Psikososyal çevre	Akran zorbalığı ve şiddet olayları, rehberlik servisi, madde kullanımı riski, okul iklimi, devamsızlık, okul terki
Ulaşım	Okul servis araçlarının güvenliği, rehber personel, emniyet kemeri, iniş-biniş alanı
Öğrenci sağlığı göstergeleri	Devamsızlık nedenleri, salgınlar (grip, ishal, pediküloz, uyuz), obezite, görme sorunları, aşılama durumu
Erişilebilirlik	Rampa, asansör, engelli tuvaleti, kaynaştırma öğrencilerine uygun düzenleme

2.3 Risk puanlama (5×5 matris)

Risk Skoru = Olasılık (1–5) × Şiddet (1–5)

Olasılık	1 Çok düşük · 2 Düşük · 3 Orta · 4 Yüksek · 5 Çok yüksek (neredeyse kesin)
Şiddet	1 Önemsiz (ilk yardım gerektirmez) · 2 Hafif (ilk yardım) · 3 Orta (tıbbi tedavi, kısa iş/okul kaybı) · 4 Ciddi (kalıcı hasar, uzun tedavi) · 5 Çok ciddi (ölüm, çoklu yaralanma)

Skor	Risk düzeyi	Eylem
1–6	Düşük	İzlenir, mevcut önlemler sürdürülür
8–12	Orta	Planlı önlem alınır (belirli süre içinde)
15–25	Yüksek	**Hemen** önlem; gerekirse etkinlik durdurulur

Kontrol önlemleri hiyerarşisi (en etkiliden en aza): 1) Tehlikeyi **ortadan kaldırma** → 2) Daha az tehlikeli olanla **ikame** → 3) **Mühendislik** önlemleri (korkuluk, kaydırmaz bant) → 4) **İdari** önlemler (nöbetçi öğretmen, kurallar, eğitim, uyarı levhası) → 5) **Kişisel koruyucu donanım**.

2.4 Örnek risk değerlendirme tablosu

Tehlike	Risk	Kimler etkilenir	O	Ş	Skor	Önlem (sorumlu – tarih)
Merdiven basamaklarında kaydırmaz bant yok, ıslak zemin	Kayma-düşme, kırık	Öğrenci, personel	4	3	**12 Orta**	Kaydırmaz bant (müdür yrd. – 2 hafta), ıslak zemin uyarı levhası, teneffüste nöbetçi öğretmen
Lavabolarda sabun ve kâğıt havlu yok	Enfeksiyon (ishal, ÜSYE)	Tüm öğrenciler	5	3	**15 Yüksek**	Sıvı sabun ve kâğıt havlu temini (idare – hemen), el hijyeni eğitimi (öğrenci hemşire), haftalık kontrol
Okul önünde yaya geçidi ve trafik levhası yok	Trafik kazası	Öğrenci, veli	3	5	**15 Yüksek**	Belediyeye yazı (idare), giriş-çıkışta trafik nöbetçisi, trafik güvenliği eğitimi
İlk yardım dolabında süresi geçmiş malzeme	Yetersiz ilk müdahale	Tümü	3	3	**9 Orta**	Malzemelerin yenilenmesi, sorumlu kişi belirleme, 3 ayda bir kontrol
Kantinde paketli şekerli ürün satışı	Obezite, diş çürüğü	Öğrenciler	4	2	**8 Orta**	Kantin denetimi için idareye bildirim, sağlıklı alternatifler, beslenme eğitimi
Kitaplıklar duvara sabitlenmemiş	Depremde devrilme	Sınıftakiler	2	4	**8 Orta**	Sabitleme (hizmetli – 1 ay), deprem tatbikatı

---

3. Öğrenci sağlığına yönelik girişimler (FR.186/16)

3.1 Okul taramaları

Tarama	Nasıl yapılır?	Sevk/dikkat
Boy-kilo-BKİ	Ayakkabısız, hafif giysiyle; aynı tartı; boy ölçer	BKİ persentili ≥85 fazla kilolu, ≥95 obez, <5 zayıf; boy <3. persentil
Görme (Snellen eşeli)	İyi aydınlatılmış ortamda **6 m (20 feet)** mesafe; eşel göz hizasında; **önce sağ göz** (sol göz kapatılır – bastırmadan), sonra sol; gözlüklü ise gözlükle; okuma yazma bilmeyenlerde **E eşeli**	Görme keskinliği yaşa göre beklenenin altında (okul çağında genellikle **≤0,7 / 20/30**) ya da **iki göz arasında ≥2 sıra fark** → göz hekimine. Gözünü kısma, başı eğme, sık göz ovma, tahtayı görememe yakınması da sevk nedenidir
Renk görme	Ishihara levhaları	Renk görme bozukluğunda bilgilendirme/yönlendirme
İşitme	Fısıltı testi (bir kulak kapatılarak ~60 cm arkadan fısıltıyla sayı/sözcük), varsa odyometre	Tekrar eden başarısızlık, dikkat sorunu, konuşma bozukluğu → KBB
Skolyoz (Adams öne eğilme testi)	Öğrenci sırtı açık (mahremiyete dikkat, aynı cinsiyetten eşlik), ayaklar bitişik, dizler düz, **öne eğilir**, kollar sarkık, avuçlar birleşik; **arkadan ve önden** bakılır	Omuz ve kalça seviye farkı, kürek kemiği asimetrisi, bel kıvrımlarında asimetri, **eğilince kaburga kamburluğu** → ortopedi. Özellikle ergenlik başlangıcında (kızlarda ~10–12, erkeklerde ~13–14 yaş)

Tarama	Nasıl yapılır?	Sevk/dikkat
Ağız-diş	Ağız lambası ve tek kullanımlık abeslang ile çürük, diş eti, diş taşı	Çürük/apse → diş hekimi
Pediküloz (bit)	Özellikle **ense ve kulak arkası**; canlı bit ya da saç köküne yakın (≤1 cm) yapışık **sirke**	Aileye gizlilik içinde bilgi; tedavi (hekim/eczacı önerisiyle bit şampuanı, 7–10 gün sonra tekrar), ince dişli tarak, yastık-çarşaf-havlu sıcak yıkama, **tüm aile ve sınıfın kontrolü**; çocuğu **damgalamama**
Kan basıncı	Uygun boy çocuk manşonu	Yaş-cinsiyet-boy persentiline göre yüksek → hekim
Aşı kartı kontrolü	Okula başlarken ve 8. sınıfta	Eksik aşılar → ASM
Duruş (postür)	Çanta ağırlığı, oturuş	Çanta ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının yaklaşık **%10–15'ini** geçmemeli; iki askılı ve iki omuzda taşıma

> **Tarama öncesi:** Okul idaresinden izin, **veli onamı/bilgilendirme**, öğrencilere işlemin açıklanması, mahremiyet; **sonuçlar yalnızca ilgili veliye ve gerekli kişilere** iletilir (sınıf önünde açıklanmaz).

3.2 Kronik hastalığı olan öğrencinin izlemi

- **Bireysel sağlık planı:** Tanı, ilaçlar, acil durumda yapılacaklar, aile ve hekim iletişim bilgileri; sınıf öğretmeni ve beden eğitimi öğretmeniyle paylaşılır (gizlilik çerçevesinde).

Hastalık	Okulda dikkat edilecekler
Tip 1 diyabet	Hipoglisemi belirtileri (terleme, titreme, solukluk, dikkatsizlik, baş ağrısı, davranış değişikliği) ve **15 g basit şeker**; sınıfta atıştırmalık ve su izni; kan şekeri ölçümüne ve insüline uygun ortam; spor öncesi kan şekeri; sınav günü planı; eğitimli kişi tarafından glukagon
Astım	Tetikleyiciler (toz, polen, sigara dumanı, soğuk hava, egzersiz); **kurtarıcı inhalere** erişim; egzersiz öncesi plan; atak belirtileri ve yapılacaklar
Epilepsi	**Nöbet ilk yardımı:** Sakin ol, **süreyi tut**, çevredeki sert cisimleri uzaklaştır, başın altına yumuşak bir şey koy, **ağzına bir şey koyma, hareketlerini tutmaya çalışma**, nöbet bitince **yan yatır** (derlenme pozisyonu), nefesini kontrol et; **5 dk'dan uzun süren**, ardışık, ilk kez geçirilen, yaralanmalı ya da suda geçirilen nöbette **112**
Besin alerjisi/anafilaksi	Alerjenden kaçınma, etiket okuma, kantin bilgilendirme; anafilakside **adrenalin oto-enjektörü** (uyluk dış yüzü) + 112
Çölyak	Glutensiz beslenme, kantin/yemekhanede alternatif
Kalp hastalıkları	Beden eğitimi kısıtlamaları, acil plan
DEHB, öğrenme güçlüğü	Rehberlik servisiyle işbirliği, sınıf düzenlemesi, ilaç saatleri
Görme/işitme kaybı	Ön sıraya oturtma, materyal düzenleme

3.3 Bulaşıcı hastalıklarda okul

- **Okuldan uzak kalma (genel öneriler – il sağlık müdürlüğü/okul talimatına uy):**

Hastalık	Okula dönüş
Suçiçeği	Tüm lezyonlar kabuklanınca (genellikle döküntüden ~5 gün sonra)
Kızamık	Döküntü başladıktan 4 gün sonra
Kabakulak	Şişlik başladıktan 5 gün sonra
Kızamıkçık	Döküntü başladıktan yaklaşık 5–7 gün sonra
Kızıl / streptokok farenjiti	Uygun antibiyotik başladıktan 24 saat sonra

Hastalık	Okula dönüş
İnfluenza	Ateş düştükten (ateş düşürücü olmadan) 24 saat sonra
İshal/kusma (akut gastroenterit)	Son ishal/kusmadan 48 saat sonra
Hepatit A	Sarılık/belirtiler başladıktan yaklaşık 7 gün sonra
Uyuz	Tedavi başladıktan sonra (ertesi gün)
Pediküloz	Tedavi başlayınca dönebilir (uzaklaştırma gerekmez)

- Salgın şüphesinde (aynı sınıfta kısa sürede çok sayıda benzer olgu) **ASM/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirim**.

3.4 Öğrencilere yönelik sağlık eğitimi ve etkinlik fikirleri

El yıkama günü · Diş fırçalama etkinliği · "Sağlıklı beslenme tabağı" boyama/yapma · Su içme kampanyası · Ekran süresi ajandası · Hareketli teneffüs/dans · Akran zorbalığı drama çalışması · Ergenlik dönemi bilgilendirme (kız-erkek ayrı gruplar) · Afet çantası hazırlama · Trafik güvenliği · Güneşten korunma · İlk yardım temel bilgileri (üst sınıflar). (Anahtar mesajlar: Bölüm 11)

---

4. Okul çalışanlarına yönelik girişimler (FR.186/17)

4.1 Çalışan gruplarına göre riskler

Grup	Başlıca riskler	Önerilen girişimler
Öğretmenler	**Ses bozuklukları** (ses kısıklığı, nodül), uzun süre ayakta durmaya bağlı **varis**, bel-boyun ağrısı, **stres ve tükenmişlik**, çocuklardan bulaşan enfeksiyonlar, sedanter yaşam (idareciler)	KB-kan şekeri-BKİ taraması; **ses hijyeni eğitimi** (bol su, bağırmama, mikrofon, sınıfı sessizleştirme teknikleri, sigara-kafein azaltma); varis için bacak egzersizleri, uygun ayakkabı; stres yönetimi ve gevşeme; ergonomi; el hijyeni ve influenza aşısı
Temizlik personeli	**Kimyasal maruziyet** (çamaşır suyu ile tuz ruhu/asitli ürünlerin karıştırılması → **zehirli klor gazı**!), cilt-solunum tahrişi, kas-iskelet (kova taşıma, eğilme), kayma-düşme, kesici atıklarla yaralanma	Kimyasalların **asla karıştırılmaması**, orijinal kabında ve etiketli saklama; **eldiven-maske** kullanımı; havalandırma; doğru kaldırma tekniği; Hepatit B ve Td aşı durumu
Kantin/yemekhane çalışanları	Gıda kaynaklı hastalık bulaştırma, yanık, kesik, sıcak ortam	**Portör (periyodik sağlık) muayenesi** ve hijyen eğitimi belgesi; el hijyeni, bone-önlük; çiğ-pişmiş ayrımı; gıda saklama ısıları
Servis şoförleri	Sedanter yaşam, stres, trafik kazası	KB, görme taraması, uyku-yorgunluk, öğrenci güvenliği eğitimi
Güvenlik/hizmetli personel	Dış ortam koşulları, kas-iskelet	Taramalar, ergonomi

4.2 Çalışanlarda tarama ve kronik hastalık izlemi

- **KB ölçümü**, **kapiller kan şekeri**, **boy-kilo-BKİ-bel çevresi**, sigara sorgulama; yaşa uygun **kanser taramalarına yönlendirme** (Bölüm 08), aşı durumu (Td, influenza).
- Kronik hastalığı olan çalışanların (HT, DM, astım) ilaç uyumu ve kontrolleri sorgulanır; gerekli olanlar ASM'ye yönlendirilir.
- Sonuçlar **gizlilik** içinde kişiye bildirilir; ortak alanda açıklanmaz.

---

5. Eğitimin uygulanması – veli ve çalışanlarla iletişim (FR.186/18)

1. **İzin ve planlama:** Okul müdürü ve **rehber öğretmen** ile görüş; eğitimin amacı, hedef kitle, süre, materyal.

2. **Zaman ve süre:** Öğretmenler için öğle arası/ders sonrası/zümre toplantısı; veliler için **veli toplantısı** günü, okul çıkış saati; **20–30 dk** + soru-cevap.
3. **Duyuru/davet:** Okul aracılığıyla davet yazısı, sınıf öğretmenleri ile veli grubu duyurusu, öğrenci aracılığıyla davet kartı.
4. **Ortam:** Uygun sınıf/salon, oturma düzeni, projeksiyon/flip chart, materyallerin hazır olması.
5. **Uygulama:** Giriş-gelişme-sonuç; materyalin **etkin** kullanımı (yalnızca slayt okumak değil; maket, gösterim, katılımcı etkinliği).
6. **Değerlendirme:** Ön-son test, soru-cevap, katılımcı geri bildirim formu, (mümkünse) davranış izlemi.
7. **Kayıt:** Katılımcı listesi (sayı), plan, fotoğraf (izinli), Omaha (kapsam: **Toplum** – öğretmenler/veliler).

Veli eğitimi konu önerileri: Çocukta sağlıklı beslenme ve obezite · Ekran süresi ve dijital güvenlik · Uyku düzeni · Akran zorbalığı · Ergenlik dönemi ve iletişim · Bit (pediküloz) ile mücadele · Aşılar · Ev kazaları ve ilk yardım · Ağız-diş sağlığı.

Çalışan eğitimi konu önerileri: Ses sağlığı · Stres yönetimi ve tükenmişlik · Ergonomi ve bel sağlığı · Kronik hastalıklar (HT, DM) · Kanser taramaları · Okulda ilk yardım ve nöbet/anafilaksi/hipoglisemi yönetimi · Temizlik kimyasallarının güvenli kullanımı.

---

6. Okulda Omaha kullanımı (FR.186/19)

- Grup eğitimlerinde **kapsam = Toplum** (ör. "4-A sınıfı öğrencileri", "okul öğretmenleri"); tek bir öğrenciye/çalışana yönelik ise **Birey**; bir öğrencinin ailesiyle çalışıyorsan **Aile**.
- Okulda sık kullanılan problemler: **Sanitasyon** ve **Komşuluk/İşyeri güvenliği** (çevresel – risk değerlendirmesi bulguları), **Bulaşıcı/enfeksiyöz durum** (el hijyeni, pediküloz), **Ağız sağlığı**, **Görme**, **İşitme**, **Beslenme**, **Fiziksel aktivite**, **Kişisel bakım**, **Büyüme ve gelişme**, **Kişilerarası ilişki** (zorbalık), **Madde kullanımı**, **Ruh sağlığı** (stres – öğretmen).
- Örnek: Bölüm 09 – Örnek 3 (el hijyeni).

---

7. Okul sağlığı süreci raporu – iskelet

```
1. Okulun tanıtımı (ad – kodlanabilir, kademe, öğrenci/öğretmen/personel sayısı, fiziki yapı, çevre)
2. Veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, kayıt, anket, tarama)
3. Risk değerlendirmesi (kontrol listesi bulguları + 5×5 matris tablosu + öncelikler)
4. Öğrencilere yönelik girişimler (taramalar ve sonuçları – sayısal; eğitimler; kronik hastalıklı öğrenci izlemi)
5. Çalışanlara yönelik girişimler (taramalar, riskler, eğitimler)
6. Veli eğitimleri
7. Eğitim planları ve değerlendirme sonuçları (ön-son test)
8. Omaha kayıtları
9. Okul idaresine öneriler (sorumlu – süre)
10. Sonuç ve değerlendirme; fotoğraflar (izinli)
```

---

8. Kendini test et

1. Okul risk değerlendirmesinin basamakları nelerdir? 5×5 matriste skor 15 ne anlama gelir?
2. Kontrol önlemleri hiyerarşisini sırala.
3. Snellen testi nasıl yapılır? Hangi durumda sevk edersin?
4. Adams öne eğilme testinde neye bakarsın?

5. Pedikülozlu öğrenci saptadın; ne yaparsın?
6. Tip 1 diyabetli öğrenci sınıfta terliyor ve titriyor; ne yaparsın?
7. Sınıfta nöbet geçiren öğrenciye ilk yardım nasıl yapılır? Hangi durumda 112?
8. Temizlik personeline hangi konuda mutlaka eğitim verirsin? Neden?
9. Öğretmenlere yönelik 3 sağlık riski ve girişim say.

13 – Toplum Süreci: Kurum ve Kuruluşlarda Risk Belirleme, Planlama ve Girişim

Puanlandığı yer: FR.186 madde 20 — "**Valiliğe bağlı resmi kurum ve özel kuruluşlardaki** sağlık sorunlarına ilişkin **risk belirleme, sağlık eğitimi planlama ve gerekli girişimlerin uygulanması**" (**20 puan**)

> Tek madde ama 20 puan. Değerlendiren kişi, toplumu (kurumu) **bir hasta gibi** sistematik değerlendirmeni bekler: **Veri toplama → Toplum tanısı → Önceliklendirme → Planlama → Uygulama → Değerlendirme.**

1. Hangi kurumlar olabilir?

Tür	Örnekler
Valiliğe bağlı resmi kurumlar	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı **huzurevleri**, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, **çocuk evleri/sevgi evleri**, engelli bakım merkezleri, kadın konukevleri; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı **gençlik merkezleri**, öğrenci yurtları; **Halk Eğitim Merkezleri**; Müftülüğe bağlı Kur'an kursları; il/ilçe müdürlükleri (çalışan sağlığı); belediye birimleri
Özel kuruluşlar	Özel kreş ve anaokulları, özel huzurevleri, **fabrika ve işyerleri**, oteller, alışveriş merkezleri, özel yurtlar, dernekler

2. Temel kavramlar (sözlü sınavda sorulabilir)

2.1 Toplum ve toplum sağlığı hemşireliği

- **Toplum:** Ortak coğrafya, ilgi, değer veya amaçları paylaşan ve birbiriyle etkileşim içindeki insanlar topluluğu (coğrafi toplum, ortak ilgi toplumu, sorun toplumu).
- **Toplum sağlığı hemşireliğinde danışan:** Birey, aile, grup ve **toplumun bütünü**; amaç toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalıkları önlemek.
- **Halk sağlığı hemşiresinin rolleri:** Bakım verici, eğitici, danışman, savunucu, vaka yöneticisi, koordinatör/işbirlikçi, araştırmacı, lider, değişim ajanı.

2.2 Koruma düzeyleri

Düzey	Amaç	Örnek
Primordiyal	Risk faktörlerinin ortaya çıkmasını önlemek	Sağlıklı kentsel planlama, okul kantin politikaları
Birincil	Hastalık oluşmadan önlemek	Aşılama, sağlık eğitimi, el hijyeni, güvenli çevre
İkincil	Erken tanı ve tedavi	Tarama (KB, kan şekeri, kanser taramaları)
Üçüncül	Komplikasyonları ve sakatlığı sınırlamak, rehabilitasyon	Diyabetik ayak bakımı, inme sonrası rehabilitasyon
Dördüncül	Gereksiz/aşırı tıbbi müdahaleden korumak	Gereksiz antibiyotik ve tetkikin önlenmesi

2.3 Sağlığı geliştirme – Ottawa Şartı (1986)

- **5 eylem alanı:** (1) Sağlıklı kamu politikaları oluşturma, (2) **Destekleyici çevreler** yaratma, (3) **Toplum eylemini** güçlendirme, (4) **Kişisel becerileri** geliştirme, (5) Sağlık hizmetlerini yeniden yönlendirme.
- **3 strateji: Savunuculuk** (advocate), **olanak sağlama/güçlendirme** (enable), **arabuluculuk** (mediate).

2.4 Sağlığın belirleyicileri (Dahlgren–Whitehead katmanları)

İçten dışa: Yaş, cinsiyet, kalıtım → **Bireysel yaşam tarzı** → **Sosyal ve toplumsal ağlar** → **Yaşam ve çalışma koşulları** (eğitim, çalışma ortamı, işsizlik, su-sanitasyon, sağlık hizmetleri, konut, beslenme/tarım) → **Genel sosyoekonomik, kültürel ve çevresel koşullar**.

2.5 Epidemiyolojik çerçeve

- **Epidemiyolojik üçgen: Konak** (yaş, bağışıklık, davranış) – **Etken** (biyolojik, kimyasal, fiziksel) – **Çevre** (fiziksel, sosyal, biyolojik).
- **Enfeksiyon zinciri (6 halka):** Etken → Rezervuar → Çıkış kapısı → Bulaşma yolu → Giriş kapısı → Duyarlı konak. **Girişimler zincirin bir halkasını kırmayı hedefler** (el hijyeni = bulaşma yolu; aşı = duyarlı konak).

---

3. Toplum değerlendirme modelleri

3.1 Toplum Ortaklığı Modeli (Community as Partner – Anderson ve McFarlane)

Toplum değerlendirme çarkı:

- **Çekirdek (insanlar):** Tarihçe, **demografik özellikler** (yaş-cinsiyet, medeni durum, eğitim), etnik/kültürel yapı, **değerler, inançlar**, din.
- **8 alt sistem:**
  1. **Fiziksel çevre** (bina, iklim, konut, su, hava, gürültü, güvenlik)
  2. **Sağlık ve sosyal hizmetler** (kurum içi revir, ASM'ye erişim, sağlık personeli, sosyal hizmet)
  3. **Ekonomi** (gelir, istihdam, bütçe)
  4. **Ulaşım ve güvenlik** (servis, yangın, güvenlik görevlisi, acil plan)
  5. **Politika ve yönetim** (yönetim yapısı, kurallar, karar alma)
  6. **İletişim** (resmi-resmi olmayan iletişim kanalları, ilan panoları, WhatsApp grupları)
  7. **Eğitim** (eğitim düzeyi, eğitim olanakları, hizmet içi eğitimler)
  8. **Rekreasyon** (boş zaman etkinlikleri, sosyal alanlar)
- Model, toplumun **stresörlere** karşı savunma hatlarını ve hemşirenin **birincil-ikincil-üçüncül koruma** girişimlerini tanımlar.

3.2 Ön cam (windshield) taraması

Kurumu ve çevresini **yürüyerek/gözlemleyerek** sistematik inceleme: binanın durumu, sınırlar ve çevre, toplanma alanları, ulaşım, hizmet noktaları, insanların görünümü ve etkinlikleri, temizlik ve atık, güvenlik, sağlık-hastalık göstergeleri (ör. engelli bireyler, sigara içen gruplar), duyurular ve iletişim kanalları.

3.3 Veri toplama yöntemleri

Yöntem	Örnek
Gözlem (kontrol listesi)	Fiziksel çevre, hijyen, güvenlik
Kilit kişi görüşmesi	Kurum müdürü, sorumlu hemşire/sağlık personeli, aşçı, bakım personeli
Odak grup görüşmesi	6–10 kişilik sakin/çalışan grubu
Anket	Sağlık sorunları, yaşam tarzı, bilgi düzeyi
Ölçüm ve tarama	KB, kan şekeri, BKİ, düşme riski testleri
İkincil veri	Kurum kayıtları (revir, kaza, ilaç, menü), TÜİK, ilçe sağlık müdürlüğü verileri

4. Toplum süreci – adım adım

Adım 1 – Hazırlık

Kurum yöneticisinden izin; amaç ve programın paylaşılması; kurumla iletişimden sorumlu kişinin belirlenmesi; etik ilkeler (gönüllülük, gizlilik, fotoğraf izni).

Adım 2 – Veri toplama (Toplum Ortaklığı Modeli çerçevesinde)

Kurum tanıtımı (kuruluş amacı, kapasite, kişi sayısı, yaş-cinsiyet dağılımı, çalışan sayısı ve meslekleri), fiziki yapı, sağlık hizmetleri, beslenme hizmetleri, güvenlik ve acil durum planları, kayıtlardaki sağlık sorunları, anket/tarama sonuçları.

Adım 3 – Veri analizi ve toplum tanıları

Toplum tanısı yazım formatı:

> **[Toplum/grup]**'ta **[sorun veya risk]**; **[etiyoloji/ilişkili faktörler]** ile ilişkili; **[göstergeler – sayısal veriler]** ile kendini gösteren.

Örnekler:

1. "**Huzurevinde kalan yaşlılarda düşme riski**; ortak alanlarda kaygan zemin, koridorlarda yetersiz gece aydınlatması ve bakım personelinin düşme önleme konusunda eğitim almamış olması ile ilişkili; son 6 ayda kayıtlarda 14 düşme olayı bulunması ve değerlendirilen 40 sakinin 17'sinde (%42,5) Kalk ve Yürü testinin ≥14 sn olması ile kendini gösteren."
2. "**Kreşteki 3–6 yaş çocuklarda bulaşıcı hastalık riski**; lavabolarda sabun bulunmaması, çocukların el yıkama becerisinin yetersizliği ve oyuncakların düzenli dezenfekte edilmemesi ile ilişkili; son 1 ayda 9 çocuğun ishal nedeniyle devamsızlık yapması ve gözlemde çocukların yalnızca %20'sinin yemekten önce elini yıkaması ile kendini gösteren."
3. "**Fabrika çalışanlarında kas-iskelet sistemi sorunları**; ergonomik olmayan çalışma istasyonları, ağır yük kaldırma ve mola yetersizliği ile ilişkili; anket yapılan 60 çalışanın 34'ünün (%57) bel ağrısı bildirmesi ve son 1 yılda 11 rapor kaydı ile kendini gösteren."
4. "**Öğrenci yurdunda kalan gençlerde sağlıksız beslenme ve sedanter yaşam**; yurt menüsünde sebze-meyvenin az olması, kantinde hazır atıştırmalıkların yaygınlığı ve spor alanının bulunmaması ile ilişkili; ankete katılan öğrencilerin %48'inin kahvaltı atlaması, %35'inde BKİ ≥25 olması ile kendini gösteren."

> NANDA-I'da toplum düzeyinde "**Toplum sağlığında yetersizlik**", "**Etkisiz toplum baş etmesi**", "Toplum baş etmesini geliştirmeye hazır oluş" tanıları da kullanılabilir. Omaha'da kapsam **Toplum** seçilir.

Adım 4 – Önceliklendirme

Basit puanlama yöntemi (her ölçüt 1 = düşük, 2 = orta, 3 = yüksek):

Ölçüt	Tanı 1 Düşme	Tanı 2 …
Toplumun (kurumun) sorunun farkında olması	3	
Toplumun sorunu çözme isteği/motivasyonu	3	
Hemşirenin çözümü etkileme gücü	3	
Çözüm için uzman/kaynak bulunabilirliği	2	

Ölçüt	Tanı 1 Düşme	Tanı 2 ...
Çözülmezse sonuçların ciddiyeti	3	
Çözümün hızlı sağlanabilmesi	2	
Toplam	**16**	

> En yüksek puanlı tanı ilk öncelik olur. (Alternatif: Hanlon yöntemi – sorunun büyüklüğü, ciddiyeti ve müdahalenin etkililiği ile puanlama.)

Adım 5 – Planlama

Plan tablosu (her öncelikli tanı için):

Bileşen	Örnek – Huzurevinde düşme riski
Amaç	Huzurevinde düşme olaylarını azaltmak
Hedefler (ölçülebilir)	(1) Eğitime katılan bakım personelinin %80'i düşme risk faktörlerinden en az 5'ini sayabilecek (eğitim sonunda). (2) Eğitime katılan sakinlerin %70'i yataktan güvenli kalkma basamaklarını gösterebilecek. (3) 1 ay içinde koridorlara gece aydınlatması ve banyolara kaydırmaz paspas konmuş olacak. (4) 3 ay sonunda aylık düşme olayı sayısı azalmış olacak.
Hedef kitle	Sakinler, bakım personeli, kurum yönetimi
Faaliyetler	Sakinlere grup eğitimi (düşmeyi önleme, güvenli kalkma, uygun ayakkabı); personele eğitim (risk değerlendirme, ortostatik hipotansiyon, transfer teknikleri); haftada 2 gün sandalye/denge egzersiz grubu; ortam düzenlemesi için yönetime yazılı öneri; ilaç gözden geçirme için kurum hekimiyle görüşme; düşme kayıt formunun kullanıma alınması
Yöntem/Materyal	Anlatım, gösterip yaptırma, büyük puntolu broşür, poster, egzersiz kartları
Sorumlular	Öğrenci hemşire, kurum hemşiresi, yönetim, fizyoterapist (varsa)
Zaman çizelgesi	1. hafta veri toplama; 2. hafta eğitimler; 3. hafta egzersiz grubu, ortam düzenlemesi takibi; 4. hafta değerlendirme
Kaynaklar	Kurum salonu, projeksiyon, maket, egzersiz için sandalye
Değerlendirme göstergeleri	Ön-son test puanları; geri gösterim kontrol listesi; düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı; düşme sayısı

Adım 6 – Uygulama

- Planlanan eğitimlerin ve girişimlerin yapılması; katılım listesi (sayı), fotoğraf (izinli), Omaha kaydı (kapsam: **Toplum**).
- Kurum yönetimine **yazılı rapor ve öneriler** (sorumlu ve süre önerisiyle).

Adım 7 – Değerlendirme

Değerlendirme türü	Soru	Örnek
Süreç değerlendirmesi	Faaliyetler planlandığı gibi yapıldı mı?	3 eğitim yapıldı, 32 sakin ve 12 personel katıldı
Etki değerlendirmesi	Bilgi, tutum, davranış, çevre değişti mi?	Personelin ön test ortalaması 52 → son test 86; sakinlerin %75'i güvenli kalkmayı gösterdi; banyolara kaydırmaz paspas kondu
Sonuç değerlendirmesi	Sağlık göstergeleri değişti mi? (uzun vadeli)	3 ay sonra aylık düşme sayısı 2,3'ten 1,0'a indi (kurumun izlemesi için öneri)

→ Hedeflere ulaşılamayan noktalar için **yeniden planlama** ve kuruma sürdürülebilirlik önerileri.

---

5. Kurum türlerine göre olası riskler ve girişimler (hazır liste)

Kurum	Olası sağlık sorunları/riskler	Olası girişimler
Huzurevi / yaşlı bakım merkezi	Düşme, bası yarası, malnütrisyon ve dehidratasyon, enfeksiyonlar (influenza, solunum yolu, idrar yolu, uyuz, ishal), polifarmasi, depresyon ve yalnızlık, demans, inkontinans, sıcak çarpması, yangın tahliyesi, personelde bel ağrısı ve tükenmişlik	Düşme önleme, el hijyeni, influenza/pnömokok aşı durumu, sıvı alımı programı, bası yarası önleme (pozisyon, cilt bakımı – Braden), egzersiz grupları, bilişsel uyarım etkinlikleri, ilaç güvenliği, personele transfer/ergonomi eğitimi
Kreş / anaokulu / çocuk evleri	Bulaşıcı hastalıklar (ishal, el-ayak-ağız, grip, pediküloz), kazalar (düşme, boğulma, zehirlenme, yanık), yetersiz/dengesiz beslenme, aşı eksikliği, diş çürüğü, ihmal-istismar riski	El hijyeni (çocuk + personel), oyuncak-ortam temizliği, ilk yardım ve boğulmada ilk yardım (Heimlich – çocuk), kaza önleme, sağlıklı menü önerileri, aşı kartı kontrolü, diş fırçalama alışkanlığı, kişisel güvenlik eğitimi (yaşa uygun)
Engelli bakım merkezi	Bası yarası, aspirasyon, kontraktür, kabızlık, enfeksiyon, epileptik nöbet, bakım veren yükü	Pozisyon ve cilt bakımı, güvenli besleme, nöbet ilk yardımı, personel eğitimi, bakım veren stres yönetimi
Öğrenci yurdu / gençlik merkezi	Sağlıksız beslenme, uyku düzensizliği, sedanter yaşam, sigara-alkol-madde, stres-depresyon, cinsel sağlık, bulaşıcı hastalıklar (uyuz, menenjit, TB, grip), yangın	Sağlıklı beslenme ve uyku, stres yönetimi ve sınav kaygısı, madde kullanımını önleme, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, KKMM/TKM farkındalığı, aşı ve el hijyeni, yangın güvenliği
Kadın konukevi	Travma ve ruh sağlığı, gebelik ve üreme sağlığı, çocukların izlemi, kronik hastalıklar	Güvenli ve güçlendirici yaklaşım, üreme sağlığı/AP danışmanlığı, kanser taramaları, ASM'ye bağlama, çocuk izlem ve aşı kontrolü
İşyeri / fabrika	**Fiziksel** (gürültü, titreşim, ısı, aydınlatma, toz), **kimyasal** (solvent, boya), **biyolojik**, **ergonomik** (yük kaldırma, tekrarlayan hareket, uzun süre ayakta/oturma), **psikososyal** (stres, vardiya, mobbing), iş kazaları, kronik hastalıklar, sigara	KKD kullanımı (kulak koruyucu, maske, gözlük, eldiven), doğru kaldırma tekniği ve egzersiz, KB-kan şekeri-BKİ taraması, sigara bırakma, stres yönetimi, iş kazası ve ilk yardım eğitimi, vardiyalı çalışanlarda uyku hijyeni
Halk Eğitim Merkezi / kurs katılımcıları	Kronik hastalıklar, kanser taramalarına katılım düşüklüğü, sağlıksız beslenme, sigara	Kanser tarama eğitimi (KKMM, GGT, HPV), HT/DM eğitimi, sağlıklı beslenme, aile planlaması
Kur'an kursu / yatılı kurslar	Pediküloz, uyuz, ishal, kalabalık ortam, beslenme, ağız-diş sağlığı	Kişisel hijyen, el hijyeni, pediküloz taraması ve eğitimi, diş fırçalama, beslenme

İşyeri sağlığı için bilmen gereken çerçeve

- **6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:** İşverenin **risk değerlendirmesi yapma/yaptırma** yükümlülüğü; işyerleri **az tehlikeli – tehlikeli – çok tehlikeli** olarak sınıflanır; **işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli (DSP – hemşire)** görevlendirilir; çalışanlara İSG eğitimi zorunludur; işe giriş ve periyodik muayeneler.
- **Gürültü:** Uzun süreli yüksek gürültü (yaklaşık **80–85 dB(A) ve üzeri**) işitme kaybı riski → kulak koruyucu ve odyometrik izlem.
- **KKD**, risk kontrol hiyerarşisinde **son basamaktır**; önce tehlikeyi kaynağında azaltmak gerekir.

---

6. Toplum süreci raporu – iskelet

```
1. Giriş: Kurumun adı (kodlanabilir), türü, bağlı olduğu birim, amacı
2. Veri toplama yöntemleri ve tarihleri
3. Toplum Ortaklığı Modeli'ne göre veriler
   3.1 Çekirdek: kişi sayısı, yaş-cinsiyet, eğitim, değerler
   3.2 Alt sistemler: fiziksel çevre, sağlık-sosyal hizmetler, ekonomi, ulaşım-güvenlik,
       politika-yönetim, iletişim, eğitim, rekreasyon
4. Saptanan sorunlar/riskler (sayısal göstergelerle)
5. Toplum tanıları ve önceliklendirme tablosu
6. Plan tablosu (amaç – hedefler – faaliyet – yöntem/materyal – sorumlu – zaman – gösterge)
7. Uygulama: yapılan eğitimler (katılımcı sayısı), taramalar, düzenlemeler; Omaha kayıtları
8. Değerlendirme: süreç – etki – (öngörülen) sonuç; ön-son test sonuçları
9. Kuruma öneriler (sürdürülebilirlik)
10. Sonuç; ekler (eğitim planları, broşürler, anket formu, izinli fotoğraflar)
```

---

7. Kendini test et

1. Toplum Ortaklığı Modeli'nin çekirdeği ve 8 alt sistemi nelerdir?
2. Ön cam taramasında neleri gözlemlersin?
3. Bir kreş için toplum tanısı yaz (etiyoloji ve sayısal göstergelerle).
4. Toplum tanılarını önceliklendirmede kullanılan 6 ölçüt nedir?
5. Süreç, etki ve sonuç değerlendirmesi arasındaki fark nedir? Birer örnek ver.
6. Ottawa Şartı'nın 5 eylem alanı ve 3 stratejisi nelerdir?
7. Enfeksiyon zincirinin halkalarını say; el hijyeni hangi halkayı kırar?
8. Bir fabrikada hangi risk gruplarını değerlendirirsin?

14 – Hızlı Tekrar, Ezber Kartları ve Soru Bankası

> Değerlendirmeden önceki gece ve sabah bu dosyayı oku. Soruların cevaplarını **sesli** vermeye çalış; takıldığın yerde ilgili dosyaya dön.

1. Rakamlar – tek sayfada ezber kartı

İzlemler

Konu	Rakam
Gebe izlemi	**En az 4**: ≤14. hf · 18–24. hf · 28–32. hf · 36–38. hf
Lohusa izlemi	Hastanede ilk 24 saat + taburculuk sonrası en az 3: **2–5. gün · 13–17. gün · 30–42. gün** (kaynağa göre değişebilir)
Bebek izlemi (0–1 yaş)	**9**: doğum · ilk hafta/ilk 10 gün · 15. gün · 41. gün · 2. ay · 3. ay · 4. ay · 6. ay · 9. ay
Çocuk izlemi (1–6 yaş)	**7**: 12 · 18 · 24 · 30 · 36 · 48 · 60. ay → 6 yaşa kadar toplam **16**
Okul çağı / ergen	**Yılda 1**

Aşı takvimi (2025 sonrası – altılı karma)

Zaman	Aşı
Doğum	Hep B
2. ay	BCG + Altılı karma 1 + KPA 1
4. ay	Altılı karma 2 + KPA 2
6. ay	Altılı karma 3 + OPA 1
12. ay	KPA rapel + KKK 1 + Suçiçeği
18. ay	Karma rapel + OPA 2 + Hep A 1
24. ay	Hep A 2
48. ay	KKK 2 + DaBT-İPA
13 yaş	Td
Gebe Td	Td1 4. ay · Td2 +4 hafta · Td3 +6 ay · Td4 +1 yıl · Td5 +1 yıl

Destekler

Destek	Ne zaman	Doz
Bebek D vitamini	Doğumdan 12. ayın sonuna	400 IU (3 damla)/gün
Bebek demir	4. aydan 12. ayın sonuna	1 mg/kg/gün
Gebe folik asit	Gebelik öncesi – ilk 12 hafta	400 mcg/gün
Gebe demir	16. haftadan doğum sonrası 3. ay sonuna	40–60 mg/gün
Gebe D vitamini	12. haftadan doğum sonrası 6. ay sonuna	1200 IU/gün

Kanser taramaları

Kanser	Yaş	Test	Sıklık
Meme	40–69 K	Mamografi (+KMM)	2 yılda bir
Serviks	30–65 K	HPV-DNA (+smear)	5 yılda bir

Kanser	Yaş	Test	Sıklık
Kolorektal	50–70 K+E	GGT / kolonoskopi	2 yılda bir / 10 yılda bir

Normal değerler

Parametre	Değer
Yenidoğan KTA / solunum / ısı	120–160 / 30–60 / 36,5–37,5 °C
FKS	110–160/dk
Fizyolojik kilo kaybı	%7–10; 10–14. günde geri kazanılır
Ağırlık	4–5 ayda 2 kat, 1 yaşta 3 kat
Boy	1 yaşta 1,5 kat (~75 cm), 4 yaşta 2 kat (~100 cm)
Baş çevresi	Doğumda 33–35 cm; ilk 3 ay +2 cm/ay, 4–6 ay +1 cm/ay, 6–12 ay +0,5 cm/ay
Fontanel	Arka ~2 ay, ön 12–18 ay
Fundus	12 hf simfiz üstü · 20–22 hf göbek · 36 hf ksifoid altı
Gebelikte anemi	Hb <11 g/dl
GDM (75 g OGTT)	Açlık ≥92 · 1. saat ≥180 · 2. saat ≥153
Gebelikte HT	≥140/90; ağır ≥160/110
Loşia	Rubra 1–3 · Serosa 4–10 · Alba 10. gün → 6. hafta
Doğum sonu fundus	Günde ~1 cm iner; 10–14. günde palpe edilmez
HT evreleri	E1 140–159/90–99 · E2 160–179/100–109 · E3 ≥180/≥110
Ev KB	≥135/85 hipertansif
DM tanı	AKŞ ≥126 · OGTT 2. sa ≥200 · HbA1c ≥%6,5 · rastgele ≥200 + belirti
Hipoglisemi	<70 mg/dl → 15 g şeker, 15 dk sonra ölç
BKİ	18,5–24,9 normal · 25–29,9 fazla kilolu · ≥30 obez
Bel çevresi (belirgin risk)	K ≥88, E ≥102 cm
Çocuk BKİ persentili	≥85 fazla kilolu, ≥95 obez
Kalk ve Yürü	≥12–14 sn düşme riski
GDS-15	≥5 depresyon şüphesi
EPDS	≥13 doğum sonu depresyon riski

Teknik

İşlem	Açı	Not
IM	90°	Bebek: vastus lateralis; erişkin: ventrogluteal/deltoid; aşıda aspirasyon yok
SC	45–90°	İnsülin, DMAH (masaj/aspirasyon yok), KKK, suçiçeği
ID	10–15°	BCG (<1 yaş 0,05 ml), PPD (48–72 saatte endürasyon)
Kan alma	15–30°	Turnike ≤1 dk; tüp sırası: kültür → mavi → kırmızı/sarı → yeşil → mor → gri
Soğuk zincir	+2/+8 °C	Günde 2 kez ısı kaydı; donmaya hassaslar dondurulmaz
Aşı sonrası gözlem	15–30 dk	
Anafilaksi	Adrenalin 1/1000, 0,01 mg/kg IM uyluk	Çocuk max 0,3 mg, erişkin 0,5 mg; 5–15 dk'da tekrar

2. Formüller

- **BKİ** = kg / m² · **TDT (Naegele)** = SAT + 7 gün − 3 ay + 1 yıl
- **BÖH** = 1 yaş altı ölüm / canlı doğum × 1000 · **Anne ölüm oranı** = … / canlı doğum × 100.000
- **Kaba doğum hızı** = canlı doğum / yıl ortası nüfus × 1000 · **Genel doğurganlık hızı** = canlı doğum / 15–49 yaş kadın × 1000
- **Bağımlı nüfus oranı** = (0–14 + 65+) / 15–64 × 100
- **Prevalans** = tüm olgular / nüfus · **İnsidans** = yeni olgular / risk altındaki nüfus
- **Risk skoru (okul/işyeri)** = Olasılık × Şiddet (5×5)
- **Paket-yıl** = günlük paket × içilen yıl

---

3. Çerçeveler (kısaltmalar)

Kısaltma	Açılımı
SBAR	Durum – Öykü – Değerlendirme – Öneri
PES	Problem – Etiyoloji – Semptom (NANDA tanı yazımı)
SMART	Özgül – Ölçülebilir – Ulaşılabilir – Gerçekçi – Zamanlı
HEEADSSS	Ev – Eğitim – Beslenme – Aktivite – Madde – Cinsellik – İntihar/Depresyon – Güvenlik
REEDA	Kızarıklık – Ödem – Ekimoz – Akıntı – Yara kenarları
BE-FAST	Denge – Göz – Yüz – Kol – Konuşma – Zaman (inme)
ABCDE (ben)	Asimetri – Kenar – Renk – Çap >6 mm – Değişim
5A	Sor – Öner – Değerlendir – Yardım et – İzlem ayarla (sigara)
Omaha	4 alan – 42 problem · 4 kategori – 75 hedef · Bilgi/Davranış/Durum 1–5
Omaha alanları	Çevresel 4 · Psikososyal 12 · Fizyolojik 18 · Sağlıkla ilgili davranışlar 8
Omaha kategorileri	Sağlık eğitimi-rehberlik-danışmanlık · Tedaviler ve işlemler · Vaka yönetimi · Gözetim
Transteorik	Düşünmeme → Düşünme → Hazırlık → Hareket → Sürdürme
Toplum Ortaklığı	Çekirdek + 8 alt sistem (fiziksel çevre, sağlık-sosyal hizmet, ekonomi, ulaşım-güvenlik, politika-yönetim, iletişim, eğitim, rekreasyon)
Ottawa	5 eylem alanı + 3 strateji (savunuculuk, olanak sağlama, arabuluculuk)

---

4. Soru bankası (kısa cevaplı)

A. ASM ve demografi

1. **ASM'nin verdiği hizmetlerden 10'unu say.** → Aşılama, gebe-lohusa-bebek-çocuk-ergen-yaşlı izlemleri, kanser taramaları, kronik hastalık izlemi (HYP), AP danışmanlığı, sağlık eğitimi, poliklinik-tanı-tedavi-reçete, enjeksiyon-pansuman-kan alma, ev ziyaretleri, sağlık raporları, kayıt-bildirim, sevk.
2. **ASE kimlerdir?** → Hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni.
3. **BÖH'ün paydası nedir?** → Aynı yıldaki canlı doğum sayısı.
4. **Prevalans ile insidans farkı?** → Prevalans belirli bir andaki tüm (eski+yeni) olgular; insidans belirli dönemdeki yeni olgular.
5. **Nüfus piramidinin tabanı daralıyorsa ne anlarsın?** → Doğurganlık azalıyor, nüfus yaşlanıyor; kronik hastalık ve yaşlı sağlığı hizmetleri önem kazanır.

B. İnvaziv işlemler ve aşı

6. **Bebekte IM aşı nereye yapılır?** → Uyluk anterolateral – vastus lateralis.
7. **Ventrogluteal bölge nasıl bulunur?** → Avuç büyük trokanter, işaret parmağı SİAS, orta parmak iliak kristaya; V'nin ortası.
8. **BCG nasıl uygulanır, ne beklenir?** → ID, <1 yaş 0,05 ml; 2–3 haftada papül-püstül-ülser, 2–3 ayda skar; pansuman/antiseptik yok.
9. **2. ay aşıları?** → BCG, altılı karma 1, KPA 1.
10. **12. ay aşıları?** → KPA rapel, KKK, suçiçeği.
11. **Canlı aşılar ve kontrendikasyonları?** → BCG, OPA, KKK, suçiçeği; gebelik ve ağır immün yetmezlikte verilmez.
12. **Hafif ishali olan bebek aşılanır mı?** → Evet; hafif hastalık kontrendikasyon değildir.
13. **Prematüre bebek nasıl aşılanır?** → Kronolojik yaşına göre.
14. **Buzdolabı +10 °C gösteriyor; ne yaparsın?** → Aşıları kullanmayı durdur, sorumluya bildir, aşıları uygun soğuk kaba al, maruziyet süresini kaydet, kullanılabilirlik kararı için ilçe sağlık müdürlüğü/sorumlu talimatına uy.
15. **Aşı sonrası kaç dakika gözlem?** → En az 15 dk (risk varsa 30 dk).
16. **Anafilakside ilk ilaç ve dozu?** → Adrenalin 1/1000, 0,01 mg/kg IM uyluk (çocuk max 0,3 mg, erişkin max 0,5 mg).
17. **Topuk kanı neden topuğun ortasından alınmaz?** → Kalkaneusa ulaşma, osteomiyelit riski.
18. **Topuk kanıyla hangi hastalıklar taranır?** → Fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, SMA.
19. **Kan alırken turnike en fazla ne kadar kalır?** → 1 dakika.
20. **EDTA'lı tüp hangi renk, ne için?** → Mor; hemogram, HbA1c.

C. Bebek-çocuk-ergen

21. **0–1 yaşta izlem sayısı ve zamanları?** → 9: doğum, ilk 10 gün, 15. gün, 41. gün, 2., 3., 4., 6., 9. ay.
22. **İzlem basamaklarını sırala.** → Hazırlık, karşılama-izin, el hijyeni, öykü, fizik muayene, büyüme ölçümleri-persentil, gelişim, taramalar, aşı, profilaksi (D vit/demir), eğitim, kayıt ve sonraki izlem.
23. **Baş çevresi nasıl ölçülür?** → Esnemeyen mezura, kaşların hemen üstü – oksipital çıkıntı, en geniş çevre.
24. **6 aylık bebekte beklenen gelişim?** → Desteksiz oturmaya başlama, elden ele nesne aktarma, dönme, heceleme, tanıdık-yabancı ayırt etme.
25. **12 ayda beklenen?** → Tutunarak yürüme/ilk adımlar, ince kıskaç, 1–2 anlamlı kelime, bay-bay.
26. **Moro refleksi ne zaman kaybolur?** → 4–6 ay.
27. **Sevk gerektiren gelişimsel bulgular?** → Beceri kaybı, 4 ayda baş kontrolü yok, 9 ayda oturamıyor, 16 ayda tek kelime yok, 18 ayda yürümüyor, 24 ayda iki kelimelik cümle yok, göz teması yok.
28. **D vitamini ve demir desteği?** → D vit doğumdan 12. ay sonuna 400 IU; demir 4. aydan 12. ay sonuna 1 mg/kg/gün.
29. **Patolojik sarılık belirtileri?** → İlk 24 saatte başlama, avuç-tabana yayılma, 2 haftadan uzun sürme, açık renkli dışkı-koyu idrar, emmeme.
30. **ABÖS'ü önlemek için 5 öneri?** → Sırtüstü yatırma, sert yatak, yatakta yumuşak eşya yok, sigara dumanı yok, aşırı ısıtma yok (+ emzirme, oda paylaşımı).
31. **Bebekte hızlı solunum sınırları?** → <2 ay ≥60, 2–12 ay ≥50, 1–5 yaş ≥40/dk.
32. **Erken puberte sınırları?** → Kızlarda 8, erkeklerde 9 yaştan önce.
33. **HEEADSSS'i açıkla.** → Ev, eğitim, beslenme, aktiviteler, madde, cinsellik, intihar/depresyon, güvenlik.

D. Gebe-lohusa

34. **Gebe izlemleri?** → En az 4: ilk 14 hf, 18–24, 28–32, 36–38. hf.
35. **SAT 05.04.2026 ise TDT?** → 12.01.2027.

36. **Fundus 36. haftada nerede?** → Ksifoidin hemen altında.
37. **Gebelikteki tehlike belirtileri?** → Kanama, şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, epigastrik ağrı, yüz-el ödemi, havale, ateş, bebek hareketlerinde azalma, su gelmesi, erken düzenli kasılmalar.
38. **Fetal hareket sayımı?** → 28. haftadan sonra; 2 saatte 10 hareketten az → başvuru.
39. **Leopold manevraları neyi gösterir?** → 1: fundustaki kısım, 2: sırtın yönü, 3: prezente kısım, 4: angajman.
40. **Gebelikte demirin kullanımı?** → Aç karnına/öğün arası, C vitaminiyle, çay-kahve-süt ile değil; dışkı siyahlaşabilir.
41. **Doğum sonu 3. günde loşia nasıl olmalı?** → Rubra (kırmızı).
42. **Fundus doğum sonu 7. günde?** → Göbeğin yaklaşık 6–7 cm (parmak) altında, sert.
43. **Lohusa hüznü ile depresyon farkı?** → Hüzün 2–3. günde başlar, 2 haftada geçer; depresyon 2 haftadan uzun, işlevselliği bozar → sevk.
44. **LAM koşulları?** → Bebek <6 ay, tam emzirme, adet başlamamış.
45. **Doğru kavramanın 4 belirtisi?** → Ağız geniş açık, alt dudak dışa dönük, çene memeye değiyor, areolanın üst kısmı daha fazla görünür.
46. **Angorjmanda öneri?** → Sık-etkili emzirme, öncesi ılık, sonrası soğuk uygulama, gerekirse sağma.

E. Erişkin-yaşlı-kronik

47. **KB ölçümünde dar manşon?** → Değeri olduğundan yüksek gösterir.
48. **Doğru KB ölçümünün kritik basamakları?** → 30 dk öncesi sigara/kafein yok, 5 dk dinlenme, sırt destekli-ayaklar yerde, kol kalp hizasında, uygun manşon, konuşmama, 2–3 ölçüm ortalaması, ilk ölçümde iki kol.
49. **HT'de günlük tuz?** → <5 g.
50. **Hipoglisemide ne yaparsın?** → Bilinç açıksa 15 g basit şeker, 15 dk sonra ölç, gerekirse tekrar; bilinç kapalıysa ağızdan verilmez, 112.
51. **Diyabetik ayak bakımında 5 öneri?** → Günlük kontrol, ılık su ve parmak arası kurulama, düz tırnak kesimi, çıplak ayak yürümeme, uygun ayakkabı-çorap.
52. **MDI kullanımı?** → Çalkala, nefes ver, yavaş derin nefes alırken bas, 10 sn tut; steroid sonrası ağız çalkala.
53. **Yaşlıda düşmeyi önleme?** → Ev düzenlemesi (halı, aydınlatma, tutunma barı), yavaş kalkma, uygun ayakkabı, gözlük, ilaç gözden geçirme, denge egzersizleri.
54. **Polifarmasi?** → ≥5 ilaç; etkileşim, düşme, uyumsuzluk riski.

F. Kanser taramaları

55. **KKMM ne zaman?** → Adet bitiminden 5–7 gün sonra; menopozda her ayın aynı günü.
56. **KKMM'de inspeksiyon pozisyonları?** → Kollar yanda, kollar başın üstünde, eller belde kasılı, öne eğilerek.
57. **Palpasyon tekniği?** → Karşı elin 3 parmak pulpası, küçük daireler, 3 basınç düzeyi, dikey şerit paterni, koltuk altı dahil.
58. **HPV testi öncesi hazırlık?** → 48 saat ilişki, vajinal duş, tampon, vajinal ilaç yok; adet döneminde alınmaz.
59. **GGT kitinde numune alınmaması gereken durumlar?** → Adet dönemi, kanayan hemoroid, idrarda kan.
60. **GGT pozitif ise?** → Kolonoskopiye yönlendirme; pozitiflik kanser demek değildir ama ileri inceleme şarttır.

G. Omaha – Hemşirelik süreci – Eğitim

61. **Omaha'nın 3 bileşeni?** → Problem sınıflama şeması, girişim şeması, problem değerlendirme ölçeği.
62. **Durum niteleyicileri?** → Sağlığın geliştirilmesi, potansiyel (risk faktörleri), gerçek (belirti/bulgular).
63. **Kapsam niteleyicileri?** → Birey, aile, toplum.
64. **Gözetim kategorisi ne demek?** → Durumun/ilerlemenin ölçme ve gözlemle izlenmesi (sonraki ziyarette kontrol).
65. **Davranış ölçeğinde 3 ne demek?** → Tutarsız (bazen uygun).
66. **NANDA tanısı nasıl yazılır?** → Tanı + "... ile ilişkili" (etiyoloji) + "... ile kendini gösteren" (tanımlayıcı özellikler).
67. **Risk tanısında tanımlayıcı özellik var mıdır?** → Hayır; risk faktörleri yazılır.

68. **"Hasta bilgilenecek" neden yanlış sonuç kriteri?** → Ölçülemez; "... sayacak/gösterecek + ne zaman" şeklinde yazılmalı.
69. **Değerlendirmede kriter kısmen ulaşıldıysa?** → Nedeni analiz et, girişimi/süreyi revize et, yeniden planla.
70. **Eğitim hedefinde kullanılmayacak fiiller?** → Bilir, öğrenir, anlar, kavrar, farkında olur.
71. **Gösterip yaptırma hangi alanda en etkilidir?** → Psikomotor (beceri).
72. **Sağlık İnanç Modeli bileşenleri?** → Algılanan duyarlılık, ciddiyet, yarar, engel, harekete geçirici uyaran, öz-etkililik.

H. Okul ve toplum

73. **Okul risk matrisinde skor 16?** → Yüksek risk – hemen önlem.
74. **Kontrol hiyerarşisi?** → Ortadan kaldırma → ikame → mühendislik → idari → KKD.
75. **Snellen'de sevk?** → Yaşa göre beklenen altı (≈≤0,7) ya da iki göz arasında ≥2 sıra fark.
76. **Adams testi?** → Öne eğilmede kaburga kamburluğu, omuz/kalça/skapula asimetrisi → skolyoz şüphesi.
77. **Nöbet ilk yardımında yapılmayacaklar?** → Ağza bir şey koymak, hareketleri tutmak; 5 dk'dan uzun → 112.
78. **Temizlik personeline en önemli uyarı?** → Çamaşır suyu ile asitli ürünleri (tuz ruhu) asla karıştırmamak – klor gazı.
79. **Toplum Ortaklığı Modeli'nin alt sistemleri?** → Fiziksel çevre, sağlık-sosyal hizmetler, ekonomi, ulaşım-güvenlik, politika-yönetim, iletişim, eğitim, rekreasyon.
80. **Süreç, etki, sonuç değerlendirmesi?** → Süreç: faaliyet yapıldı mı; etki: bilgi/davranış/çevre değişti mi; sonuç: sağlık göstergeleri değişti mi.

---

5. Vaka senaryoları (sözlü sınava hazırlık)

Vaka 1 – Aşı günü

4 aylık bebek 4. ay aşıları için gelmiş. Anne "Dün akşamdan beri burnu akıyor, ateşi 37,8 °C oldu" diyor. Bebek aktif, emiyor. **Beklenen yaklaşım:** Kimlik ve öykü; ateş ölç; genel durumu değerlendir (emme, solunum sayısı, çekilme); hafif üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif ateş **kontrendikasyon değildir** → hekim değerlendirmesiyle aşılama yapılabilir (altılı karma 2 + KPA 2); ağrıyı azaltma (emzirirken); 15–30 dk gözlem; anneye yan etkiler, soğuk uygulama, ateş takibi ve tehlike belirtileri; demir desteğini başlatma; sonraki izlem 6. ay. Omaha: Bulaşıcı/enfeksiyöz durum – Potansiyel ya da Büyüme ve gelişme – Sağlığın geliştirilmesi; Tedaviler ve işlemler – (aşı uygulaması); Gözetim – Belirti/bulgular–fiziksel.

Vaka 2 – Gebe izlemi

32 haftalık gebe, KB 148/96, yüzünde şişlik, "2 gündür başım ağrıyor" diyor. **Beklenen yaklaşım: Preeklampsi şüphesi** → KB'yi doğru teknikle tekrar ölç, idrarda protein bak, görme bozukluğu-epigastrik ağrı sor; **hemen hekime bildir**, ikinci basamağa acil sevk; gebeyi yalnız bırakma; konvülsiyon riskine karşı hazırlıklı ol; kayıt.

Vaka 3 – Lohusa

Doğum sonu 6. gün, ateş 38,5 °C, sol memede kızarık, sıcak, ağrılı alan. **Beklenen yaklaşım:** Mastit şüphesi → hekime yönlendir; **emzirmeye devam** (önce etkilenen memeden), sık boşaltma, dinlenme, sıvı; doğru kavrama kontrolü; ilaç hekim önerisiyle; tehlike belirtileri; NANDA: "Etkisiz emzirme" / "Akut ağrı"; Omaha: Doğum sonu – Gerçek.

Vaka 4 – Kronik hasta

62 yaşında diyabetik kadın; parmak ucu kan şekeri 58 mg/dl, terliyor, titriyor, bilinci açık. **Beklenen yaklaşım: 15-15 kuralı** → 15 g basit karbonhidrat (½ bardak meyve suyu), 15 dk sonra ölçüm, <70 ise tekrar; düzelince kompleks karbonhidrat; nedeni sorgula (öğün atlama, insülin dozu, egzersiz); hipoglisemi eğitimi; hekime bilgi; kayıt.

Vaka 5 – Kanser taraması

53 yaşında erkek, hiç kolorektal tarama yaptırmamış, "Kanser olsam anlarım" diyor. **Beklenen yaklaşım:** Sağlık İnanç Modeli: hedef yaş aralığında olduğunu (duyarlılık), erken dönemde belirti vermeyebileceğini ve erken tanıda tedavi başarısını (ciddiyet-yarar), testin kolay ve ücretsiz olduğunu (engelleri azaltma) anlat; GGT kitini ver ve kullanımını adım adım göster; numune alınmayacak durumlar; sonucun takibi; Omaha: Sağlık bakımı denetimi – Gerçek; Sağlık eğitimi – Tarama işlemleri; Gözetim – Tarama işlemleri.

Vaka 6 – Okul

İlkokul 3. sınıfta 5 öğrencide bit saptandı; veliler tedirgin. **Beklenen yaklaşım:** Gizlilik ve damgalamadan kaçınma; ailelere bireysel bilgilendirme, tedavi (hekim/eczacı önerisiyle şampuan, 7–10 gün sonra tekrar, ince dişli tarak, eşyaların sıcak yıkanması, tüm aile kontrolü); sınıfın ve kardeşlerin taranması; veli bilgilendirme toplantısı/broşür; okul idaresine bilgi; öğrencilerin tedaviyle okula devam edebileceği; Omaha: Bulaşıcı/enfeksiyöz durum – Toplum – Gerçek.

Vaka 7 – Toplum süreci (huzurevi)

Huzurevinde son 3 ayda 9 düşme kaydı var. **Beklenen yaklaşım:** Toplum Ortaklığı Modeli ile veri toplama (fiziksel çevre, personel, sakinlerin özellikleri), Kalk ve Yürü testi, ilaç kullanımı; toplum tanısı yazma; önceliklendirme; plan (sakin + personel eğitimi, egzersiz grubu, ortam düzenlemesi, ilaç gözden geçirme); uygulama; süreç-etki-sonuç değerlendirmesi; kuruma yazılı öneriler.

---

6. Değerlendirme günü kontrol listesi

Bir gün önce

- ❑ Bu dosyadaki rakam tablolarını bir kez yaz-ez
- ❑ Kanıt dosyası tamam mı? (eğitim çizelgesi + haftalık sayılar, planlar, ≤2 sayfa içerikler, materyaller, fotoğraflar, Omaha formları, bakım planı, okul/toplum raporları)
- ❑ Haftalık "15 kişi" sayıları üç kategoride de tutuyor mu?
- ❑ Fotoğraflarda kimlik/yüz/ekran görünmüyor mu?

Değerlendirme sabahı

- ❑ Forma, yaka kartı, tırnak, saç, takı kontrolü
- ❑ Not defteri, kalem, saniyeli saat, mezura, maket/broşür
- ❑ Bugünkü izlemlere ait yaş/hafta bilgilerini gözden geçir (hangi aşı, hangi gelişim basamağı, hangi tehlike belirtileri)

Uygulama sırasında

- ❑ Kendini tanıt – izin al – el hijyeni – kimlik doğrula
- ❑ Yaparken anlat (gerekçesiyle)
- ❑ İşlem sonrası değerlendir ve eğit
- ❑ "Bir sonraki izlem … tarihinde, … yapılacak" cümlesini mutlaka kur
- ❑ Kaydet; anormal bulguyu bildir
- ❑ Omaha ile kapat (Problem – Girişim – Bilgi/Davranış/Durum)

Başarılar!